#10
(1199) СЕНТЯБРЬ 2026

ОТРАСЛЕВОЕ
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Фармацевтический ВЕСТНИК

PHARMVESTNIK.RU

В НОМЕРЕ:

24 ТРУДНОЕ ДЕТСТВО
Сколько на рынке педиатрических лекарств

38 НОВАЯ ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Как закон о платформенной экономике изменит онлайн-торговлю в фарме

42 СЛАБОЕ ЗВЕНО
Какие вызовы встают перед фармрынком в сфере кибербезопасности

48 НЕКУДА МИГРИРОВАТЬ
Как новые условия работы с маркетплейсами повлияют на продажу БАД отраслями

ВРЕМЯ И СТЕКЛО

Почему производители стерильных препаратов не успевают перейти на новые правила GMP ЕАЭС



Изображение создано с использованием технологий ИИ редакцией «ФВ»

До перехода российских производителей стерильных лекарственных средств на новые требования GMP ЕАЭС осталось менее трех месяцев. Отрасль предупреждает: компании, которые часто называют элитой фарминдустрии из-за крайне жестких требований к производству, могут не успеть подготовиться. Цена вопроса — десятки, а для отдельных производств сотни миллионов рублей на один производственный участок. Попытка успеть уложиться в срок может обернуться ростом себестоимости продукции, в крайних случаях — остановкой производства. Что собой представляет сегмент производителей стерильных препаратов в России, какие изменения потребуют от компаний наибольших затрат и какой срок для перехода на новые правила фармпроизводители считают реально выполнимым, разобрался «ФВ». ПОДРОБНЕЕ → СТР. 8



14 ЛАРИСА МАТВЕЕВА:
«Мы ищем единый подход к орфанным препаратам»



16 ПОДСТЕЛИТЬ СОЛОМКУ
Механизмы минимизации договорных рисков в сделках с фармактивами



43 ДМИТРИЙ КРАВЧЕНКО:
«Патентная неразбериха: кому выгодно»

Мединтернет

Войти | Зарегистрироваться

МЫ ОЖИДАЛИ УВИДЕТЬ ПОИСК ЗАБОЛЕВАНИЙ.

ВМЕСТО ЭТОГО УВИДЕЛИ СОВЕРШЕННО ДРУГУЮ КАРТИНУ.

На основе исследования реальных врачебных запросов (проанализировано 30 000+ врачей) к специализированному медицинскому ИИ.



28 388

РЕАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ВРАЧЕЙ

11:00 — ПИК ОБРАЩЕНИЙ.

ИИ используют во время рабочего дня.

НЕ ПОИСК, А ДИАЛОГ.

Врач описывает клинический случай, а не диагноз.

О ПАЦИЕНТЕ, А НЕ О БОЛЕЗНИ.

Запросы становятся сложнее и ближе к реальной практике.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ФАРММАРКЕТИНГА.

ИИ становится новой точкой поиска профессиональной информации.

ИССЛЕДОВАНИЕ.

Почти 30 000 обезличенных запросов врачей. Первый анализ того, как российские врачи используют специализированный медицинский ИИ.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО.

Если ИИ становится первой точкой поиска профессиональной информации, меняется и подход к медицинским коммуникациям.

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
по QR-коду.

Полная статья-исследование для фармацевтических компаний.

Реклама

Главный редактор
Оксана Агарёва

Шеф-редактор Ринат Васбеев

Медицинский редактор Надежда Синицына

Редакционная коллегия:
Мария Гордеева
Елена Григорьева
Владимир Заболотских
Ольга Коберник
Дина Коблова
Таисия Кубрина
Екатерина Погонцева
Сергей Рякин

Аналитический отдел Елена Калиновская

Председатель редакционного совета
Юрий Крестинский

Арт-директор Марина Лындина

Дизайн-макет Александр Ларин

Отдел дизайна и верстки:
Марина Полякова

Выпускающий редактор Лариса Шпудейко

Подразделение редакторов-корректоров:
Елена Лаврова
Наталья Жданова

Тел.: +7 (495)786-25-57, доб. 200
E-mail: edition@pharmvestnik.ru

Отдел подписки и распространения
Тел.: +7 (495) 786-25-41
E-mail: podpiska@bionika.ru

Подписной индекс в каталоге «Почта России»:
полугодовой — ПР304

www.pharmvestnik.ru
В электронной версии газеты отдельные материалы могут быть в расширенном варианте

ИЗДАТЕЛЬ ООО «Бионика Медиа»

Председатель Совета директоров
Ирина Красивская

Генеральный директор
Сергей Крестинский

Газета «Фармацевтический вестник» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77-59313 от 18.09.2014 г.
Выходит с февраля 1994 г.
Периодичность — 14 раз в год,
день выхода — вторник
Адрес издателя, редакции: 117485, Москва, ул. Обручева, 30/1, стр.2
www.bionika-media.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «Бионика Медиа»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Телефон: +7 (495) 786-25-57
E-mail: reklama@bionika-media.ru
Руководитель отдела по работе с клиентами:
Людмила Макарова
Менеджеры по работе с клиентами:
Диана Ханинева

Подписка и распространение
8 (495) 786-25-41

Срок сдачи в печать: 25.09.2026, 19.00
Подписано в печать: 25.09.2026, 19.00

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Борус-Принт», 115201, г.Москва, вн.тер.г. м.о. Москворечье-Сабурово, 1-й Котляковский пер., д.3, этаж 1, пом. 1/12.

№ заказа 14152
Совокупный тираж 16 200 экз.
Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой
Цена свободная

* Изображения созданы редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ.

pharmvestnik.ru Канал в Telegram Канал в «Макс»

АЛЕКСАНДР ЧЕРНИЧЕНКО,

генеральный директор «Мьюз Медиа»

МЫ НЕ ВИДИМ РАЗВОРОТА РЫНКА БАД В СТОРОНУ КЛАССИЧЕСКИХ АПТЕК



ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

ЛИЦА ФВ

Сегодня на рынке все чаще обсуждается тезис о том, что усиление регулирования маркетплейсов может изменить баланс сил и вернуть часть продаж БАД в аптечный канал. Мы такого разворота не видим. Регуляторное давление 2026 года действительно перестраивает маркетплейсы изнутри, меняет правила их работы и делает рынок более прозрачным, но само по себе не возвращает покупателя в физическую аптеку. Главная причина — в архитектуре цены.

Маркетплейс работает преимущественно по B2C-модели: производитель получает возможность продавать конечному покупателю практически напрямую, без полноценного торгового звена в том виде, в каком оно существует в классической аптечной рознице.

Аптека — это другая экономика. Здесь возникает B2B-цепочка, в которой сеть должна заработать фронт-маржу, бэк-маржу, получить бонусы за выкладку, ретро и другие составляющие своей коммерческой модели. В результате цена одного и того же SKU в аптечном канале объективно оказывается выше на 25—40%.

Поэтому даже при ужесточении требований к маркетплейсам базовая причина выбора потребителя не исчезает. Если ценовая конструкция каналов остается разной, то и экономическая мотивация покупателя сохраняется.

Важно и другое. Аптечная доля сегодня во многом поддерживается собственным онлайном — «Аптека.ру», «Здравсити», партнерствами с «Яндекс.Маркетом». То есть часть продаж, которая формально относится к аптечному каналу, также развивается в B2C-логике. Это не означает возвращения трафика к офлайн-полке. Напротив, сама аптечная розница все глубже уходит в онлайн.

Поэтому происходящее правильнее называть не разворотом рынка, а санацией маркетплейсов и перераспределением ролей между каналами. Маркетплейсы становятся более регулируемыми, аптечные сети укрепляют собственные цифровые каналы, а производители строят омниканальные модели и разводят ассортимент по разным площадкам.

БАД в физическую аптеку не возвращаются. Они остаются в онлайне — просто все в большей степени в его белой и регулируемой части. ФВ

МАРКЕТПЛЕЙСЫ НАЧАЛИ ПОВЫШАТЬ КОМИССИИ ДЛЯ СЕЛЛЕРОВ НА РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ. САМОЕ ДРАМАТИЧНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗОШЛО У ЧЕТЫРЕХ КАТЕГОРИЙ, ВКЛЮЧАЯ БАД И ВИТАМИНЫ. ВЫНУЖДАЕТ ЛИ ЭТО СЕЛЛЕРОВ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ КАНАЛЫ ПРОДАЖ, ЧИТАЙТЕ НА СТР. 48.

сентябрь 2026

СОДЕРЖАНИЕ



В ФОКУСЕ

6 Тренды отрасли

12 Индикаторы фармацевтического рынка

БИЗНЕС

8 ВРЕМЯ И СТЕКЛО
Почему производители стерильных препаратов не успевают перейти на новые правила GMP ЕАЭС

35 КОДОВОЕ СЛОВО
Как работает стартап, где основной сотрудник — искусственный интеллект

40 ЦИФРОВАЯ АПТЕКА-2030
Почему будущее фармрынка — за самовывозом, а не за доставкой





42 СЛАБОЕ ЗВЕНО
Какие вызовы встают перед фармрынком в сфере кибербезопасности

45 МАРОККАНСКОЕ ВРЕМЯ
Что российской фарме обещает рынок королевства

48 НЕКУДА МИГРИРОВАТЬ
Как новые условия работы с маркетплейсами повлияют на продажу БАД

50 ВОТ ТАКОЙ РАССЕЯННЫЙ
Что следует знать фармкомпаниям о том, как нейросети добывают информацию о лекарствах

52 ЭКСПЕРТ СО ЗНАНИЕМ БИОЛОГ-ИИ
Умение интегрировать ИИ в науку стало главным критерием при подборе персонала в отрасли

РЕГУЛЯТОРИКА

16 ПОДСТЕЛИТЬ СОЛОМКУ
Механизмы минимизации договорных рисков в сделках с фармактивами

38 НОВАЯ ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Как закон о платформенной экономике изменит онлайн-торговлю в фарме

ИНТЕРВЬЮ

14 ЛАРИСА МАТВЕЕВА:
«Мы ищем единый подход к орфанным препаратам»



«РАЗНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И КРИТЕРИИ ОРФАННОСТИ СОЗДАЮТ БАРЬЕР ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕПАРАТА ВО ВСЕХ СТРАНАХ СОЮЗА».

14

ТЕМА НОМЕРА

ПЕДИАТРИЯ



19 МОЛОДО-ЗЕЛЕНО
Самые распространенные и самые редкие педиатрические заболевания

22 ИРИНА ЗАХАРОВА:
«Педиатрам приходится быть изобретательными»

24 ТРУДНОЕ ДЕТСТВО
Сколько на рынке педиатрических лекарств

28 НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПЕДИАТРИИ
От профилактики респираторно-синцитиальной инфекции до лечения редких заболеваний



ОСОБОЕ МНЕНИЕ

32 ДМИТРИЙ КРАВЧЕНКО:
«ПАТЕНТНАЯ НЕРАЗБЕРИХА: КОМУ ВЫГОДНО?»

«ХОЧЕТСЯ ТОГО, ЧЕГО НЕ БУДЕТ: РАЗРЕШЕНИЯ НАЗНАЧАТЬ ДЕТЯМ НЕКОТОРЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. К СЧАСТЬЮ, ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЯТЬ ТАКИЕ ЛЕКАРСТВА ПО РЕШЕНИЮ КОНСИЛИУМА».



ИРИНА ЗАХАРОВА,
заведующая кафедрой педиатрии им. акад. Г.Н. Сперанского РМАНПО, докт. мед. наук, проф., заслуженный врач РФ

22



МОНИТОРИНГ

54 ОБЗОР ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РОССИИ ПРЕПАРАТОВ
в августе 2026 года

56 ОБЗОР ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
в августе 2026 года

57 ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ ОДОБРЕНИЙ
в августе 2026 года

ДОКУМЕНТЫ

61 ОБЗОР РАЗРАБОТАННЫХ И ПРИНЯТЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
в сентябре 2026 года

НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЕТПРЕПАРАТОВ



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»

В образцах серии № 20 вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, установлено наличие живого вируса болезни Ауески. О результатах проверки ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ВГНКИ) сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Служба поручила изъять из обращения с последующим уничтожением препарат «Мультикан-8» серии № 20 производителя ООО «Ветбиохим», следует из документа, который опубликовала служба. Московская прокуратура в ходе проверки выявила нарушения требований законодательства в сфере производства ветпрепаратов.

В августе в СМИ появилась информация о том, что при использовании вакцины «Мультикан-8» проявились осложнения в состоянии здоровья у вакцинированных собак. В Центре ветеринарии в Ярославле заявили об остановке использования ветпрепарата. Производитель вакцины начал проверку и сообщил о возможном деструктивном вмешательстве третьих лиц в ситуацию. Затем Россельхознадзор приостановил обращение четырех серий вакцины.

По предварительным данным, при производстве вакцины «Мультикан-8» могло быть допущено нарушение технологий.

ЦИФРА МЕСЯЦА

56,7 млн доз

вакцины для профилактики гриппа закуплено за счет федерального бюджета в регионы в эпидемическом сезоне 2026—2027 годов. Последние годы за счет федерального бюджета поставлялось около 70 млн доз. Таким образом, в текущем сезоне закупки снизились на 19% в рамках НКПП, обратил внимание «ФВ». При этом снизился и целевой охват населения вакцинацией, но не так значительно.

СУДЫ МЕСЯЦА

ФАС России инициировала четыре иска к фармкомпании «Аксельфарм» о взыскании прибыли от реализации незаконно выведенных на рынок дженериков. Общая сумма, которую надлежит перечислить в федеральный бюджет, превышает 2 млрд руб.

Минздрав РФ одержал победу в споре с «Джодас Экспоим» о приостановке действия регудостоверения на препарат «Коромакс». Основанием послужило «наличие в регистрационном досье недостоверных документов и данных».

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Novartis на непринятие обеспечительных мер в отношении компании «Изварино Фарма» судом первой инстанции. Обе инстанции согласились, что истец не представил доказательств того, что объем продаж его оригинального препарата «Юперио» снизился в результате поставок препарата ответчика «Валсуперио».

Арбитражный суд Московской области принял к рассмотрению иск Takeda к «ПСК Фарма» о взыскании. Иск связан со спором вокруг препарата с МНН тедуглутид для лечения пациентов с синдромом короткой кишки.

Суд по интеллектуальным правам отказал американской ViiV Healthcare, которая обжаловала решение Роспатента, сохранившее в силе патент «Биохимика». Он охраняет способ очистки долутегравира, используемого в антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕСЯЦА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДЛОЖИЛИ ИЗМЕНИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОФСЕТНЫХ КОНТРАКТОВ И АДАПТИРОВАТЬ ИХ К РОЗНИЦЕ

На конференции «Фармпроекции» в Минске эксперты обсудили совершенствование офсетных контрактов: гибкость в изменениях, пересмотр цен, привлечение третьих лиц, увеличение сроков конкурсных процедур. Они предложили внедрить аналогичный механизм для розницы — долгосрочные соглашения между производителями и аптечными сетями.

«Когда заключается офсетное соглашение, там фигурируют лекарственные препараты, которые находятся под патентной защитой. И если компания продлила патентную защиту в силу тех или иных обстоятельств, ты не можешь выпускать эти препараты, согласно патентному законодательству. Значит, надо иметь возможность уменьшать инвестиционную часть офсетного соглашения», — заявил директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» **Александр Быков**.

ЦИТАТА МЕСЯЦА

Начальник профильного отдела ЕЭК **Дмитрий Рождественский** предупредил фармпроизводителей о внеплановых инспекциях на соответствие GMP.

«БЫЛО ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ ИНСПЕКТИРОВАНИЮ, ГДЕ КОЛЛЕГИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОДНЯЛИ ВОПРОС О ТОМ, ЧТО НЕПЛОХО БЫ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛА НАДЛЕЖАЩЕЙ ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ ПРАКТИКИ GDP ЕАЭС. ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ: «СЛАВА БОГУ, К НАМ ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ, МЫ ПРОИЗВОДИМ ЛЕКАРСТВА». НО ВАШ СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ — ЭТО КОНЕЦ ВАШЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ И ОДНОВРЕМЕННО НАЧАЛО ЦЕПОЧКИ ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ. ПОЭТОМУ ВНЕПЛАНОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ GDP, НЕ ХОЧУ СКАЗАТЬ, КАК ЧУМА В СРЕДНЕВЕКОВУЮ ЕВРОПУ, НО МОГУТ ПОРАЗИТЬ И ВАС».



ДМИТРИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медизделий Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

Новым гендиректором ООО «Авексима Сибирь» стал **Андрей Скороход**. Он будет совмещать этот пост с должностью заместителя гендиректора по производству в головной «Авексиме». В этой должности он сменил **Сергея Герасимова**.

Губернатор Саратовской области освободил **Владимира Дудакова** от должности министра здравоохранения региона. Исполняющим обязанности назначен **Виталий Луцет**, ранее занимавший пост главного врача Марксовской районной больницы.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НОВЫМ РЕГУЛЯТОРНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ GMP ЕАЭС БЕЗ ИЗБЫТОЧНЫХ ЗАТРАТ

В Москве 12—13 ноября состоится ежегодная отраслевая конференция — открытая площадка для диалога между практиками фармпрома «Обеспечение качества в фармацевтическом производстве: современные вызовы и практические решения». Организаторы мероприятия — компания «СКИФ» и Пироговский университет.



К участию в мероприятии приглашаются директора качества, уполномоченные лица, сотрудники, занимающиеся вопросами контроля и обеспечения качества, квалификации и валидации, технологи, главные инженеры, руководители IT-служб, специалисты в области управления данными, специалисты в области фармразработки.

Конференция посвящена практическим аспектам внедрения обновленных требований приложения 1 ЕАЭС GMP, которое распространяется как на стерильное, так и на нестерильное производство, и вступает в силу с 2027 года.

В центре внимания — трансформация фармацевтической системы качества, стратегии контроля контаминации и подготовка предприятий к ужесточающимся регуляторным требованиям без избыточных затрат.

Спикерами конференции выступят директора ведущих фармпредприятий России, руководители в области качества, признанные эксперты в области обеспечения и контроля качества, валидации, фармацевтического инжиниринга.

Специальный гость — директор Евразийского отделения ISPE – МАФИ ЕАЭС, один из разработчиков приложения 1 ЕАЭС **Владимир Орлов**.

Ключевые тематические блоки

- Регуляторные изменения и адаптация системы качества.
- Стратегия контроля контаминации.
- Инженерные решения и технологические барьеры.
- Мониторинг и предиктивная аналитика.
- Валидация и управление рисками.

Внимание: количество мест ограничено.

Адрес: Москва, Пироговский университет, ул. Островитянова, 1.

Программа и регистрация: https://skifgmp.tilda.ws

Дополнительная информация
Телефон: +7 (985) 223-95-14
Почта: gmp@gmp-consult.ru, gmpconsultru@gmail.com

МЕДИАНА ФИЛЬТР
LAMSYSTEMS
журнал Фарм технологии и упаковка Лекарства по GMP
Фармацевтический бизнес
РЕКЛАМА

Почему производители не успевают перейти на новые правила GMP ЕАЭС

ВРЕМЯ И СТЕКЛО

ТЕКСТ: Екатерина Погонцева



Российские производители стерильных лекарственных средств просят дать им больше времени, чтобы привести предприятия в соответствие с новыми требованиями GMP ЕАЭС. Предложение, направленное АРФП в Минпромторг РФ, поддерживают все крупнейшие отраслевые ассоциации. По их мнению, выполнить необходимый объем работ до 28 декабря в условиях текущей неопределенности весьма проблематично, требуется больше времени.

22%

— доля стерильных лекарственных средств на рынке госзакупок медикаментов (в денежном выражении, по итогам 7 месяцев 2026 года), согласно данным «АльфаРМ»

В чем суть инициативы

Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП) предложила перенести на три года дату вступления в силу новых требований GMP ЕАЭС для стерильных лекарственных средств — с 28 декабря 2026 года на 31 декабря 2029 года. Соответствующее обращение она направила министру промышленности и торговли России Антону Алиханову, рассказал генеральный директор АРФП **Виктор Дмитриев** на XX конференции «Фармпроекции» в Минске. Копия письма есть в распоряжении «ФВ».

«Представители нашей ассоциации принимали участие в обсуждении проекта приложения № 1 к Правилам надлежащей производственной практики ЕАЭС (Производство стерильных лекарственных средств) и были уверены, что переходный период составит порядка трех лет. После подписания документа оказалось, и это стало для нас неожиданностью, что основные его положения вступают в силу 28 декабря 2026 года», — поделился Виктор Дмитриев.

В июле этого года Минпромторг РФ направил письмо отечественным производителям с просьбой прислать к сентябрю свои планы мероприятий по приведению предприятий в соответствие с новым документом. На GMP-конференции в сентябре представители министерства несколько раз напомнили об этом участникам рынка и попросили отнестись к задаче ответственно.

В ЕЭК официальных обращений о переносе срока вступления в силу новой редакции приложения № 1 к Правилам GMP не поступало, сообщили «ФВ» в пресс-службе комиссии. Вместе с тем проект изменений приложения № 1 и сроки его вступления в силу разрабатывали с участием бизнеса и обсуждали на площадке ЕЭК с 2024 года. Была достигнута договоренность о двухэтапном вступлении в силу.

На необходимость скорейшего принятия актуализированной редакции Правил GMP обращали внимание производители ЕАЭС, которые осуществляют экспорт в третьи страны. До вступления в силу новой редакции фактически экспортеры вынуждены выполнять требования двух редакций — для инспекций ЕАЭС и для инспекций третьих стран, которые уже применяют новые требования с 2024 года.

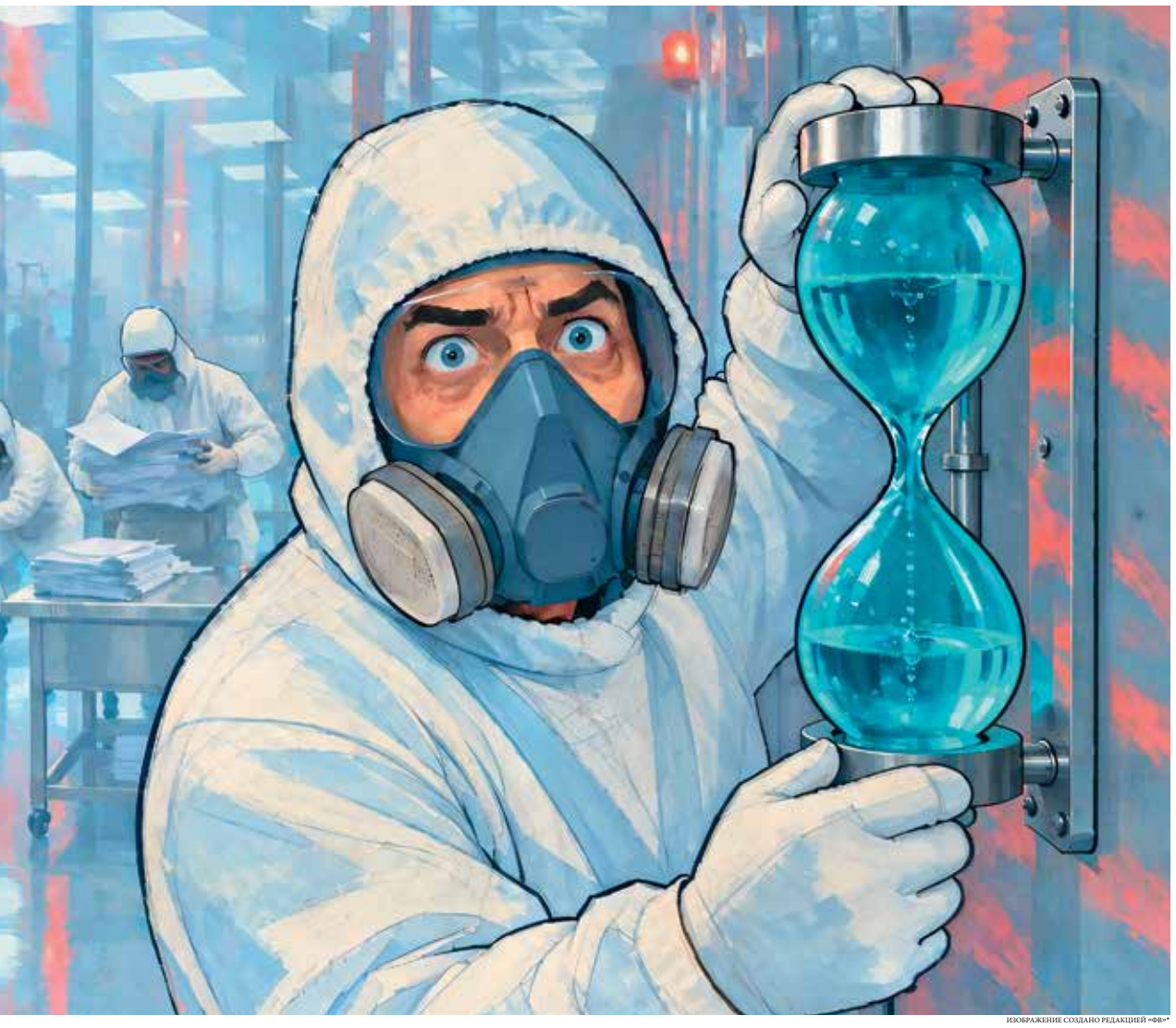
«Мы три года говорили о приложении № 1 к GMP ЕАЭС: «Коллеги, смотрите, изучайте». А теперь нам говорят: «Давайте перенесем — мы не успеваем», — поделилась начальник Управления инспектирования производства лекарственных средств ФБУ «ГИЛС и НП» **Мадина Соттаева**.

Что говорит закон

Новые изменения были официально опубликованы 1 июля 2026 года, напомнила советник юридической фирмы Lidings **Юлия Кузьменко**. Они вызваны глобальным трендом ужесточения стандартов стерильности, заботой о пациентах и необходимостью гармонизации правил стран — членов ЕАЭС для устранения барьеров на едином рынке.

Главное нововведение — появилась стратегия контроля контаминации, объяснила эксперт. Это единый комплексный документ, который объединяет оценку рисков загрязнения, контроль оборудования, проверку персонала, мониторинг среды и анализ данных для устранения слабых мест в защите, что позволяет управлять рисками системно, а не точечно.

Что касается персонала, введена ежегодная переаттестация для получения допусков в зоны А и В. При негативных результатах мониторинга оператор подлежит дисквалификации до повторного обучения и пересдачи квалификации, уточнила Юлия Кузьменко.



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФФ»*

Советник юридической фирмы Lidings Юлия КУЗЬМЕНКО:
«Для моделирования асептического процесса требования ужесточены до «нулевого роста». Теперь любая контаминация требует расследования, а для подтверждения эффективности корректирующих мер необходимо провести как минимум три повторные успешные имитации».

Введена обязательная проверка целостности стерилизующего фильтра после стерилизации перед использованием (PUPSIT), которая гарантирует стерильность раствора и исключает риск скрытого повреждения фильтра.

Все методы стерилизации детализированы: добавлена лиофилизация, разрешен не только пар, но и другие системы влажного тепла. При этом УФ-излучение признано неприемлемым методом стерилизации, подчеркнула эксперт.

Также раскрыты требования к барьерным системам RABS* и изоляторам, добавлены положения об одноразовых системах.

Топ-10 производителей стерильных лекарственных средств по доле на рынке, январь—июль 2026 года

Рейтинг	Корпорация	Сумма продаж, млрд руб.	Доля корпорации на рынке стерильных препаратов, %	Прирост суммы, январь—июль 2026 (год к году), %
1	Roche	37,6	6,41	↓ 10,16
2	Биокад	36,1	6,16	↑ 17,18
3	ГК Промомед	33,4	5,69	↑ 226,77
4	Sanofi	30,4	5,17	↑ 34,67
5	Герофарм	29,8	5,08	↑ 75,27
6	Johnson & Johnson	22,3	3,80	↑ 38,26
7	Takeda	20,5	3,49	↑ 7,46
8	Генериум	18,7	3,19	↑ 4,04
9	Novartis	18,5	3,16	↑ 5,44
10	AstraZeneca	18,4	3,13	↑ 37,20

Источник: «АльфаРМ» — БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ» Таблица 1

Изменения вступают в силу поэтапно, рассказала Юлия Кузьменко. Для основной части требований установлен срок 180 дней с даты публикации. Для наиболее сложных инженерных и процедурных пунктов, включая PUPSIT, предоставлен переходный период сроком три года.

Ответственность за невыполнение новых требований определяется национальным законодательством стран ЕАЭС в рамках инспекционного контроля GMP, напомнила эксперт.

«Данные нововведения являются продолжением установления приоритета правовых актов ЕАЭС, — резюмировала Юлия Кузьменко. — Сфера действия национальных требований GxP продолжает сужаться. Из всего массива GxP на национальном уровне будут устанавливаться только правила надлежащей аптечной практики и правила хранения лекарственных средств».

В чем сложность внедрения на практике

По мнению экспертов АРФП, реализовать такие мероприятия в обозначенный срок нереально. Пересмотр документации, внедрение стратегии контроля контаминации, актуализация стандартных операционных процедур, программ мониторинга, систем обучения персонала, квалификации, валидации и процессов управления рисками качества требуют серьезных вложений: временных и финансовых. Так, для инфузионного и ампульного производства объем необходимых инвестиций составит более 12 млн руб. для одного предприятия, показали предварительные расчеты экспертов.

В АРФП указывают и на существующую правовую неопределенность: ряд положений приложения № 1 допускает различные подходы к трактовке и реализации. В зависимости от интерпретации и выбранных технических решений объем необходимых инвестиций для участка производства порошков для инъекций составит от 60 млн до 220 млн руб. В том числе возникнет необходимость в покупке оборудования, часть которого производится в недружественных странах, а это создает дополнительные временные риски.

Все это отразится на себестоимости продукции. Производители лекарств, входящих в Перечень ЖНВЛП, окажутся перед выбором: остановить производство или повысить отпускную цену, прогнозируют в АРФП.

«Гарантированное бесперебойное производство стерильных лекарственных средств в текущих реалиях, при угрозах террористических атак на производственные объекты и необходимости организации их пассивной защиты, делает невыполнимыми требования к началу работы по новым требованиям 28 декабря 2026 года», — говорится в обращении ассоциации.

В Минпромторге РФ подтвердили получение письма и сообщили, что оно находится на рассмотрении. Также в ведомстве напомнили, что работа по актуализации приложения № 1 Правил GMP началась с января 2023 года при участии представителей фармацевтической индустрии, в том числе ведущих российских ассоциаций. К этому моменту документ уже был принят в ЕС.

С 2024 года документ рассматривался открыто на рабочих группах ЕЭК, в том числе обсуждались →

Какие изменения GMP ЕАЭС потребуют от производителей стерильных лекарств

Блок изменений	Что придется сделать	Срок
Основная часть изменений (общие требования к производству стерильных ЛС)	Внедрить обновленные требования к чистым помещениям, классификации зон, мониторингу среды, одежде персонала, дезинфекции, инженерным системам, воде, пару, газам, контролю качества	28.12.2026
Стратегия контроля контаминации (CCS)	Разработать и внедрить единый комплексный документ: оценка рисков, контроль оборудования, мониторинг среды, анализ данных	
Требования к персоналу	Ввести ежегодную переаттестацию для допуска в зоны A и B, дисквалификация при негативных результатах мониторинга, повторное обучение	
Моделирование асептического процесса (APS) Ужесточение до принципа «нулевого роста»	При любой контаминации проводить расследования, минимум три повторные успешные имитации для подтверждения эффективности корректирующих мер	
Методы стерилизации	Добавить лиофилизацию, другие системы влажного тепла, исключить УФ-излучение	
Барьерные системы (RABS, изоляторы)	Внедрить требования к проектированию, эксплуатации, мониторингу, передаче материалов	
Одноразовые системы (SUS)	Внедрить требования к оценке поставщиков, стерилизации, целостности	
Передача материалов в зоны A и B	Обеспечить однонаправленный процесс передачи, использовать проходные стерилизаторы, валидированную дезинфекцию, отдельное удаление предметов	30.06.2029
Воздушные шлюзы	Спроектировать и использовать шлюзы для разделения зон, отдельные шлюзы для персонала и материалов, ротацию профильтрованным воздухом, раздельные комнаты переодевания	
PUPSIT	Внедрить обязательную проверку целостности стерилизующего фильтра после стерилизации перед использованием, валидацию метода, оценку рисков при невозможности	
Целостность критических дыхательных и стерилизующих газовых фильтров	Подтверждать целостность после использования	
Мониторинг среды для BFS	Внедрить риск-ориентированный мониторинг жизнеспособных частиц для процессов «выдувание — наполнение — запаивание»	
Целостность лиофилизатора	Поддерживать целостность после стерилизации, стерилизовать фильтр перед каждым использованием	

Источник: приложение № 1 к Правилам надлежащей производственной практики ЕАЭС

Таблица 2

сроки его вступления в действие, говорится в ответе министерства на запрос «ФВ». С началом актуализации приложения № 1 Правил GMP представители ведомства на различных площадках освещали планируемые изменения, в том числе при GMP-инспекциях.

По мнению министерства, российская фармпромышленность должна оставаться конкурентоспособной как на российском рынке, так и за ее пределами. Очень важно, чтобы регуляторные требования соответствовали международным, в том числе ВОЗ, подчеркнули в Минпромторге РФ.

«ФВ» направил запрос в Минздрав РФ и ЕЭК.

В Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий солидарны с коллегами. Необходим более реалистичный переходный период, сказала в разговоре с «ФВ» председатель координационного совета, исполнительный директор Национальной ассоциации «АПФ» **Надежда Дараган**.

В ассоциации «Лекмедобращение» поддерживают идею предоставления трехлетнего переходного периода для вступления в силу обновленных требований GMP ЕАЭС к производству стерильных лекарственных препаратов.

«Новая редакция приложения № 1 — не точечная корректировка действующих правил, а существенный пересмотр требований к организации стерильного производства, — пояснил генеральный директор ассоциации **Филипп Романов**. — Одним из ключевых нововведений становится обязательная стратегия контроля контаминации — CCS, которая требует комплексного пересмотра всей системы обеспечения качества и производственных процессов».

По его словам, для приведения действующих производственных площадок в полное соответствие необходимо не только актуализировать документацию, провести проектирование, закупку и монтаж нового оборудования, но и осуществить модернизацию инженерных и барьерных систем, их последующую квалификацию и валидацию, обучить персонал. Дополнительным подтверждением проблематичности быстрого перехода является то, что для отдельных технологически сложных требований предусмотрены более длительные переходные сроки, обращает внимание руководитель «Лекмедобращения».

По его мнению, для части отечественных производителей полностью привести производственные мощности в соответствие со всеми новыми требованиями до конца 2026 года представляется невозможным.

«Трехлетний переходный период мы рассматриваем как обоснованную меру, необходимую для полноценной модернизации производств, — сообщил Филипп Романов. — Речь идет не об отказе от новых стандартов, а о возможности внедрить их системно и без риска остановки производственных линий. Форсированный переход может негативно повлиять на непрерывность выпуска и создать риски дефицита стерильных лекарственных препаратов на рынке ЕАЭС».

Генеральный директор ассоциации «Лекмедобращение» Филипп РОМАНОВ: «Как и все подходы в медицине, предлагаемые новые стандарты производства должны подчиняться принципу «Не навреди!». При внедрении новых требований следует не допустить искусственного возникновения дефектуры ЖНВЛП, к коим относятся практически все инъекционные лекарственные формы. Действующая методика установления цен на ЖНВЛП не предусматривает какую-либо индексацию в случае изменения регуляторики».

Взгляд со стороны

Новое приложение № 1 GMP неравномерно по «ресурсоемкости» своих требований, прокомментировал ситуацию технический директор PQE CIS (российское подразделение международной компании, специализирующейся на консалтинге в сфере GxP) **Александр Белинский**.

«В асептическом ядре теперь допускается либо RABS*, либо изолятор — такую реконструкцию, если компании этим озаботились только в настоящий момент, действительно проблематично осуществить до начала 2027 года, — привел пример эксперт. — Другое дело, что о проекте приложения было известно задолго до его публикации. Более того, не было сюрпризом, что содержательная часть в целом будет практически равной европейскому аналогу, без существенных изъятий и искажений. Если площадки не сделали проактивных шагов, реализовать это в оставшееся время крайне проблематично».

Проблема в том, что при механическом наложении имеющейся регуляторной практики в России и новых требований ЕАЭС происходит кратное усложнение схем и конфигураций по отношению к имеющимся зарубежным решениям, продолжил эксперт. Ведь за рубежом уже накоплен некоторый опыт реализации требований нового приложения № 1 GMP EU, а в России его только предстоит имплементировать.

«Можно приветствовать тот факт, что приложение № 1 способствует гармонизации регуляторных требований и реализации передовых практик при организации производств стерильных продуктов. Однако насколько достаточным является период в полгода для реализации большей части его содержания для отечественных площадок, вопрос открытый. В ЕС этот период был один год, за исключением одного пункта 8.123 — там было дано два года», — подытожил Александр Белинский.

Более
12 млн руб.
составит объем необходимых инвестиций для инфузионного и ампульного производства, чтобы привести его в соответствие с новыми требованиями GMP ЕАЭС для стерильных лекарственных средств, показали предварительные расчеты экспертов

Что представляет собой рынок стерильных препаратов

Производство стерильных лекарственных средств часто называют элитой фарминдустрии из-за крайне жестких требований. На него приходится 30% от общего объема рынка лекарств в денежном выражении и 13% — в натуральном (ритейл + госпитальный сектор), по данным «АльфаРМ».

В розничном канале в денежном и натуральном выражении лидируют отечественные игроки, в тендерном — в денежном выражении заметные позиции занимают зарубежные фармпроизводители за счет оригинальных препаратов с более высокой стоимостью, а в натуральном выражении лидирует «Фармасинтез» (за счет госпитальных растворов хлорида натрия), согласно данным «АльфаРМ».

В Перечне ЖНВЛП значительную долю занимают группы, где стерильные формы преобладают:

- антибиотики для системного применения (лиофилизаты и растворы для инъекций/инфузий);
- противоопухолевые препараты (инъекционные/инфузионные, лиофилизаты);
- гормональные препараты (инсулины, некоторые гормоны);
- сердечно-сосудистые препараты для неотложной помощи (растворы для инъекций/инфузий);
- офтальмологические препараты (глазные капли).

Сегмент развивается в двух основных направлениях: производители расширяют выпуск массовых госпитальных растворов и инвестируют в технологически сложные асептические мощности для био-, онкологических препаратов, лиофилизатов и препаратов в преднаполненных устройствах.

По итогам последних 12 месяцев (с июля 2025-го по июль 2026 года) наиболее динамично растут продажи преднаполненных шприцев. В ритейле их продажи увеличились почти вдвое (+97%, до 116,2 млрд руб.), в госзакупках — на 20% (до 125,9 млрд руб.), согласно данным «АльфаРМ».

В 2025 году «Фарм-Синтез» анонсировал инвестиционный проект стоимостью 16 млрд руб., третья очередь которого предполагает строительство участка стерильных жидких и порошкообразных форм цитостатиков мощностью 3,4 млн упаковок в год**.

На иркутском заводе ГК «Фармасинтез» была введена новая высокопроизводительная ампульно-шприцевая линия, ассортимент включает 12 наименований из восьми фармакотерапевтических групп.

«ПСК Фарма» провела масштабную реконструкцию линии по производству лиофилизатов стоимостью 133 млн руб., чтобы увеличить суточную мощность цеха до 25,5 тыс. флаконов.

«Герофарм» запустил участок асептического розлива готовых лекарственных форм мощностью до 46 млн флаконов в год. Сейчас на его заводе в Оболенске создается новый участок асептического розлива для увеличения объемов выпуска лекарств инсулиновой группы и продуктов для метаболического здоровья.

В этом году компания Renewal («ПФК Обновление») ввела в эксплуатацию крупный производственный комплекс с цехом по выпуску стерильных лекарств, включая инфузионные растворы (натрия хлорид, раствор Рингера, глюкоза), гормональные инъекционные препараты, глазные капли.

После модернизации предприятие Solopharm возобновило выпуск офтальмологических препаратов в формате OSD-флакона, который оснащен специальной системой дозирования и конструкцией крышки, помогающей предотвратить попадание загрязнений из окружающей среды внутрь упаковки. ФВ

*RABS (от англ. Restricted Access Barrier System) — барьерная система ограниченного доступа, которая создает контролируемую среду для асептических процессов в фармацевтическом, биотехнологическом и медицинском производстве. Ее главная задача — минимизировать риск микробиологического и механического загрязнения стерильной продукции при сохранении необходимой для работы операторов гибкости.
**Данные с сайтов и из пресс-релизов фармкомпаний.

2113,4 МЛРД РУБ. +12%*

3,5 МЛРД УПАК. -3%*

ОБЪЕМ РЫНКА ЛЕКАРСТВ** ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ—АВГУСТА 2026 ГОДА

ГОССАКУПКИ **849,3** МЛРД РУБ. +20%

АПТЕКИ **1264,7** МЛРД РУБ. +7%

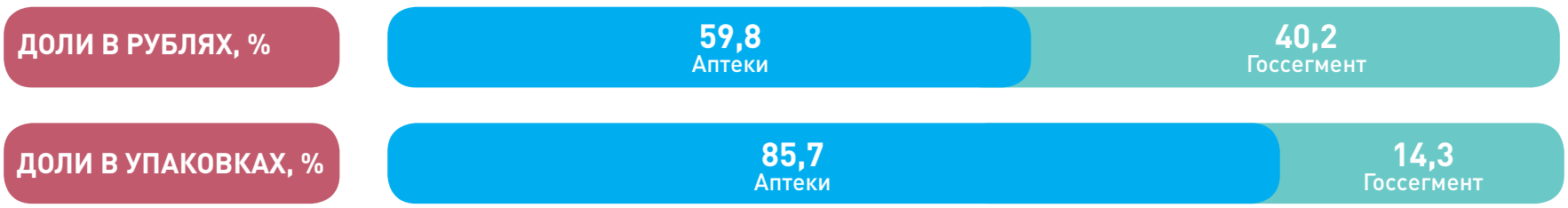
ОБЪЕМ РЫНКА ЛЕКАРСТВ** ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ—АВГУСТА 2026 ГОДА

ГОССАКУПКИ **0,5** МЛРД УПАК. +20%

АПТЕКИ **3** МЛРД УПАК. -6%

*По сравнению с январем—августом 2025 года.

СЕГМЕНТЫ РЫНКА ЛЕКАРСТВ В ЯНВАРЕ—АВГУСТЕ 2026 ГОДА



КОЛИЧЕСТВО АПТЕК В РОССИИ[1]

83,3 ТЫС. +1%

31 августа 2025 — 82,7

31 августа 2026 — 83,3

ВЫРУЧКА АПТЕК

(лекарства, БАД, прочий ассортимент)

1609,7 МЛРД РУБ. +6%

Январь—август 2025 — 1525,2

Январь—август 2026 — 1609,7

СРЕДНИЙ ЧЕК

(лекарства, БАД, прочий ассортимент)

797,5 РУБ. +11%

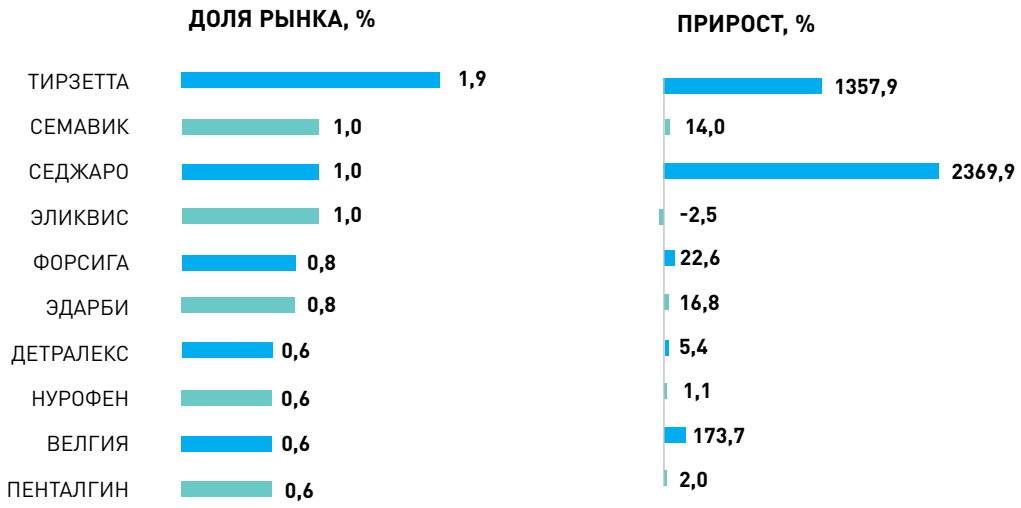
Январь—август 2025 — 721,6

Январь—август 2026 — 797,5

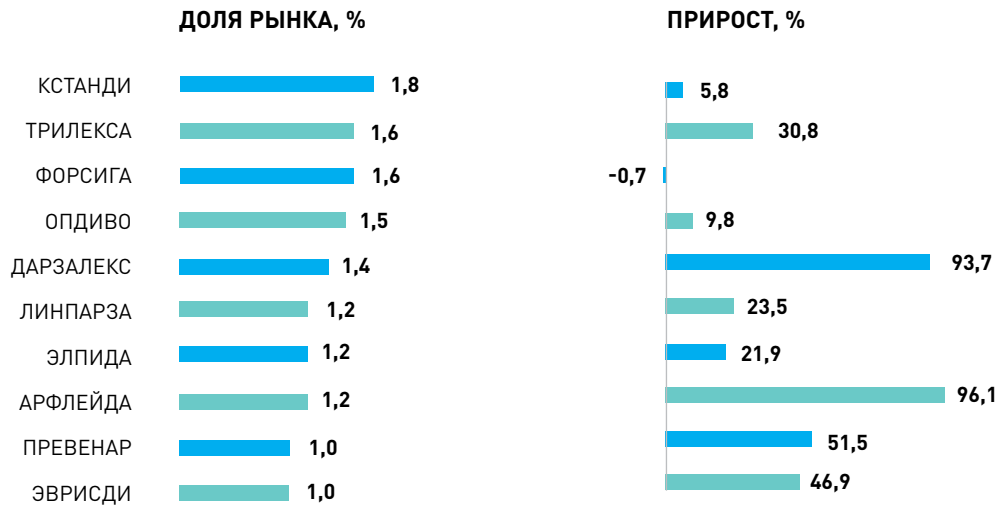
[1]На 31.08.2026.

ДИНАМИКА ПРОДАЖ БРЕНДОВ ЛЕКАРСТВ И БАД (ЯНВАРЬ—АВГУСТ 2026 ГОДА)

ТОП-10 БРЕНДОВ ЛЕКАРСТВ В АПТЕКАХ



ТОП-10 БРЕНДОВ ЛЕКАРСТВ В ГОСЗАКУПКАХ



ТОП-10 БРЕНДОВ БАД В АПТЕКАХ

№	Бренд	Корпорация	Доля рынка, 8 мес. 2026, руб., %	Прирост, 8 мес. 2026/ 8 мес. 2025, руб., %
1	Эвалар (линейка)	Эвалар	8,97	↑ 8
2	Солгар (линейка)	Солгар	6,36	↑ 9
3	Будь здоров (линейка)	ГК Протек	4,32	↑ 44
4	Бак-сет (монобренд)	Фармамед	2,17	↓ 4
5	Витамир (линейка)	Квадрат-с	2,14	↓ 19
6	Витасайнс (линейка)	Вита лайн	1,72	↑ 887
7	Альфазокс (монобренд)	Альфасигма	1,69	↑ 27
8	Консумед (линейка)	Консумед	1,60	↓ 30
9	Максилак (монобренд)	Биннофарм Групп	1,52	↑ 9
10	Фемибион (монобренд)	Д-р Редди'с Лабораторис	1,39	↓ 8

Таблица

**Мониторинг фармацевтического рынка РФ, 2026 год.
Источник: «АльфаРМ» — БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ». В ценах конечного потребления.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА



НИКОЛАЙ ДЕМИДОВ,
генеральный директор
«АльфаРМ»

Рынок лекарств в России продолжает демонстрировать устойчивый ценовой рост при сокращении физических объемов. Разрыв динамики в деньгах и в натуральных единицах — ключевая характеристика текущего периода: рынок растет не за счет потребления, а за счет цены и структурных сдвигов.

Госсегмент остается главным драйвером. Госзакупки выросли на +20% и в деньгах, и в упаковках, достигнув 849,3 млрд руб. и 0,5 млрд упак.

На фоне снижения трафика и количества чеков сама аптечная сеть продолжает расширяться. Рост чека при скромном росте выручки, собственно, подтверждает вывод о продолжении снижения трафика. Другими словами, пациент ходит реже, но покупает больше за визит. Причем больше — это не обязательно в количестве разных лекарственных препаратов. Сегодня больше — это может быть более крупная фасовка одного препарата.

Среди брендов — лидеров в ритейле в лекарственных средствах уже привычно всех затеняет соревнование за долю рынка между «Тирзеттой» и «Седжаро». В секторе БАД новый прорыв — линейка «Витасайнс» ворвалась в топ-10. Очевидно, что линейки СТМ аптечных сетей будут все активнее атаковать позиции классических монобрендов БАД и линеек.

Классические большие аптечные бренды — «Нурофен», «Детралекс», «Пенталгин» — растут на уровне или ниже рынка. Обращает на себя внимание расширение поставок пневмококковой вакцины «Превенар».

В госзакупках поляризация прошла по линии, где в рейтинге сосуществуют бренды, у которых поставки очевидно достигли уровня насыщения, и сравнительно новые продукты, рост поставок которых в 2026 году все еще очень бурный.

Ориентация на объемные метрики для производителей лекарственных средств и аптечных сетей, в том числе для определения параметров партнерства, становится рискованной. Ключевыми становятся доля в деньгах, средний чек, удержание пациента. А работа с государственным сегментом для тех компаний, кому позволяет ассортимент и кто может выполнить требования регулятора, также остается в кратко- и среднесрочной перспективах привлекательной. ФВ

Различия в регуляторике создают барьер для одновременной регистрации орфанных препаратов в ЕАЭС

ЛАРИСА МАТВЕЕВА:

«МЫ ИЩЕМ ЕДИНЫЙ ПОДХОД К ОРФАННЫМ ПРЕПАРАТАМ»



ЛИЦА ФВ

ТЕКСТ: Ольга Коберник ФОТО: из личного архива

Мировой фармрынок становится все более высокотехнологичным — доля препаратов с новым механизмом действия составляет почти половину всех регистраций. Одновременно производители ориентируются на более узкие группы пациентов. Аналитику регистраций FDA представила «ФВ» исполнительный директор Ассоциации международных фармпроизводителей (АМФП) Лариса МАТВЕЕВА. Те же тренды эксперт наблюдает и в российской фарме. Однако производителям по-прежнему сложно выходить в страны ЕАЭС — создать единое пространство для лекарственного обеспечения на территории союза пока не удалось.

Российский рынок и мировые тренды

— Какие тенденции определяют мировой рынок новых лекарственных препаратов?

— Мировая фарма сегодня все отчетливее ориентируется на инновации. По данным нашего анализа регистраций FDA за 2024—2025 годы, доля препаратов с новым механизмом действия составляет 43—48% от общего количества выданных регистрационных удостоверений. Онкология стабильно остается драйвером: на противоопухолевые препараты приходится около 30% новых регистраций. При этом портфель меняется качественно — он расширяется за счет таргетных решений для молекулярно определенных подтипов опухолей.

Мы также видим, что заболевания, которые раньше воспринимались как массовые, дробятся на отдельные группы пациентов с разными биомаркерами и терапевтическими потребностями. Поэтому инновации возникают не только в онкологии, но и в гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, иммунологии. Одновременно развивается рынок биоаналогов: 2024 год стал рекордным по числу таких регистраций — 19 против пяти годом ранее. Это важная часть более рационального использования ресурсов системы здравоохранения.

— Насколько российский рынок следует этим тенденциям?

— В последние годы мы наблюдаем рост числа клинических исследований биоэквивалентности. Однако, по данным опроса 24 крупных членов ассоциации, проведенного в 2026 году, международные фармацевтические компании продолжают выводить в Россию именно новые оригинальные препараты. С 2021-го по март 2026 года члены АМФП подали более 100 заявлений на регистрацию оригинальных лекарственных препаратов. И это не воспроизведенные препараты или новые дозировки уже известных лекарств, а новые разработки.

В ближайшие пять лет планируется еще порядка 100 заявлений, включая 15 препаратов для лечения редких заболеваний. Каждая четвертая молекула в будущем портфеле предназначена для лечения злокачественных новообразований, почти 20% — для лечения неврологических заболеваний. Более половины планируемых к регистрации препаратов — биотехнологические и высокотехнологичные; препараты химического синтеза составляют лишь около трети этого портфеля.

Это означает, что российский рынок в целом отражает мировую трансформацию. Но одновременно он становится менее «общетерапевтическим» и все более концентрированным вокруг сложных, наукоемких решений для четко определенных групп пациентов. Такая трансформация требует соответствующей готовности всей системы здравоохранения.

Для приоритетных инноваций можно рассматривать ограниченное по сроку включение в орфанные перечни с заранее определенными условиями и последующей оценкой результатов лечения в реальной практике. Это позволит быстрее открывать доступ пациентам, одновременно сохраняя управляемость расходов и возможность уточнять решение на основе накопленных данных.

— Что дает международная фарма системе здравоохранения помимо регистрации лекарств?

НИЗКИЙ ПОРОГ ВХОДА В «ОРФАННУЮ» ЗОНУ В ЕС И США КОМПЕНСИРУЕТСЯ ИНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ, НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ПОСТАВИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ОРФАННОГО СТАТУСА НА ПОТОК. ТАК, В США ПРИ ДВУХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КРИТЕРИЯХ ОРФАННОСТИ, ПО РАЗНЫМ ИСТОЧНИКАМ, НАСЧИТЫВАЕТСЯ ОКОЛО 6 ТЫС. СТАТУСОВ И 1,2 ТЫС. ОДОБРЕНИЙ. В ЕС, ГДЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЧЕТЫРЕ КРИТЕРИЯ, — ОКОЛО 3 ТЫС. СТАТУСОВ И ОКОЛО 300 ОДОБРЕНИЙ.
В РОССИИ, ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДИН КРИТЕРИЙ — РЕДКОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОЛИЧЕСТВО СТАТУСОВ СВЯЗАНО С ПЕРЕЧНЕМ ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ЗАЯВИТЕЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ ПРОЦЕДУРЫ. ЧИСЛО ПРЕПАРАТОВ С ОРФАННЫМ СТАТУСОМ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ДЕСЯТКАМИ ПРИ ПЕРЕЧНЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕМ СВЫШЕ 200 ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

— Вклад международных компаний давно не ограничивается поставками лекарственных препаратов. Речь идет о трансфере технологий, локализации производства на российских площадках, совместных научно-исследовательских работах, развитии диагностики, программах раннего доступа и непрерывном медицинском образовании.

Сегодня компании реализуют более 50 диагностических программ стоимостью свыше 2 млрд руб.: 19 из них посвящены онкологическим, сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету. В рамках программ раннего доступа лечение до официальной регистрации препарата получили более 20 тыс. пациентов, включая свыше 8 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями.

Ежегодно проводится более 6 тыс. образовательных мероприятий в 30 терапевтических областях. Они охватывают более 35 тыс. врачей из свыше 6 тыс. медицинских организаций в 80 регионах страны. Для нас принципиально, что современная терапия должна быть доступна не только в крупнейших федеральных центрах.

Российская отрасль уже сформировала серьезную производственную базу, а следующий этап — развитие собственных инновационных компетенций и технологических партнерств. Международный опыт, экспертиза и кооперация здесь не противоречат лекарственной безопасности, а укрепляют ее.

Рынок ЕАЭС

— Можно ли сказать, что за 10 лет Евразийской экономической комиссии удалось сформировать единый фармрынок на территории ЕАЭС?

— Этот путь начался в 2016 году — был принят пакет решений, создающий с нуля единую наднациональную правовую архитектуру вместо пяти национальных моделей. 6 мая 2017 года де-юре был запущен общий рынок, формировалась единая процедура регистрации и экспертизы — базовая и специальные механизмы, включая ускоренную экспертизу для орфанных и высокотехнологичных препаратов. В 2020 году принята Фармакопея ЕАЭС. Формируются единые правила GMP и риск-ориентированное планирование инспекций.

24 августа 2026 года была принята Надлежащая регуляторная практика (GRP), предусматривающая внедрение международных регуляторных стандартов. Сейчас мы стоим на пороге следующего этапа — перехода к риск-ориентированному регулированию новых групп препаратов: биологических, орфанных, высокотехнологичных, ADC.

Однако до сих пор в системе сохраняется разрыв на уровне орфанного статуса, регуляторные механизмы для этого класса препаратов не гармонизированы.

Сильная фармацевтическая отрасль строится не на изоляции, а на последовательном наращивании компетенций, конкуренции и партнерстве.

— В чем заключается проблема?

— Различия национальных перечней орфанных заболеваний и критериев орфанности создают барьер для одновременной ускоренной регистрации лекарственных препаратов в странах союза. При отсутствии единой процедуры орфанный статус присваивается по национальным правилам, что исключает одновременное применение ускоренных и условных процедур регистрации на всей территории ЕАЭС.

Только единообразие подхода, работающие законодательные нормы и понятный механизм получения орфанного статуса дают результат. Получение орфанного статуса как такового не гарантирует регистрацию и дальнейший вывод препарата на рынок в странах ЕАЭС.

— Каким может быть решение?

— Разные национальные перечни редких заболеваний и критерии орфанности создают барьер для одновременной регистрации препарата во всех странах союза. Отсутствие единой процедуры присвоения статуса означает, что он присваивается по национальным правилам, а значит, ускоренные и условные процедуры регистрации нельзя применить одновременно на всей территории ЕАЭС.

И главное: следующий шаг — вынести на рабочую группу ЕЭК предложение о создании единой процедуры присвоения орфанного статуса в ЕАЭС. По аналогии с европейским опытом: единая заявка — единое решение с признанием во всех государствах-членах, при этом национальные особенности возмещения сохраняются. Это путь к тому, чтобы общий рынок ЕАЭС расширил доступ пациентов к современной терапии редких заболеваний. Это предложение будет рассмотрено на рабочей группе ЕЭК в ближайшее время. ФВ

Механизмы минимизации договорных рисков в сделках с фармактивами

ПОДСТЕЛИТЬ СОЛОМКУ

ТЕКСТ: Таисия Кубрина



Ошибка в сделках с активами может дорого обойтись их участникам. Поэтому стороны заранее закрепляют в договоре механизмы, которые позволяют распределить риски и определить последствия неблагоприятных событий. В числе таких механизмов — не только «классические» убытки и неустойка, но и возмещение потерь, заверения об обстоятельствах, а также иные подходы. Юристы «Пепеляев Групп» обобщили судебную практику по распространенным гражданско-правовым механизмам защиты от рисков в сделках.

I. Возмещение потерь

В сделках нередко используется механизм «возмещение имущественных потерь» (ст.406.1 ГК РФ). Этот инструмент используют как дополнительную «страховку» на случай реализации конкретных рисков, связанных с активами, но не являющихся нарушением обязательств одной из сторон, например, отзыв регистрационного удостоверения, отказ в госрегистрации препарата, налоговые доначисления, претензии регулятора или третьих лиц и другие претензии.

Ключевое отличие потерь от убытков — потери не должны быть связаны с нарушением обязательств по договору. Продавец может обязаться возместить покупателю заранее согласованные потери из-за отмены регистрации препаратов, даже когда продавец не нарушал своих обязанностей. Либо контрагент нарушил свои обязанности перед государством (не уплатил налоги и т.д.) или перед третьими лицами (не выплатил вознаграждение авторам произведения и т.д.).

Условия для применения возмещения потерь:

- обязательство возместить потери четко и недвусмысленно описано в договоре — это конкретные обстоятельства, при которых потери возмещаются, виды потерь (механизм их расчета или описание) и порядок их возмещения. Суды отказали в возмещении потерь по договору лизинга, т.к. его условия не раскрывали принцип их определения, в т.ч. процентную ставку[1];
- есть документы, подтверждающие потери, например, акты налоговой проверки, судебные решения, претензии и т.д.[2].

Если стороны сами способствовали наступлению потерь, в их возмещении может быть отказано.

Суды отказали компании во взыскании суммы доначисленного НДС по «бумажным» сделкам между ней и контрагентом. Налоговая установила, что операции были оформлены только на бумаге и фактически не проводились. Действия по заключению таких сделок суды признали недобросовестными[3].

Возмещение потерь похоже на страховку. Суд проверяет, наступило ли описанное в договоре событие и не выходит ли требуемая компенсация за рамки согласованного размера. Чем более конкретно расписаны события и содержание потерь, а также порядок их возмещения, тем выше шанс, что суд удовлетворит требование и взыщет компенсацию.

Плюсы механизма:

- Гибкость. Можно заранее договориться о компенсации не только за нарушения договора, но и за внешние события.
- Прозрачность. Покупатель заранее понимает, какие потери будут покрыты, и может учесть это в цене сделки и в модели риска.

Существенный **минус механизма** состоит в том, что суд может не признать заявленные требования возмещением потерь и оценить их как требование о взыскании убытков.

Так, суд признал убытками, а не потерями, невозможность взыскания переуступленной задолженности из-за банкротства должника[4].

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ:
«ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ НЕ МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ «УПРОЩЕННЫМ СПОСОБОМ» ДОКАЗЫВАНИЯ УБЫТКОВ».



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»*

Второй минус — если в договоре обязательство по возмещению потерь недостаточно конкретизировано, используются слишком широкие или неопределенные формулировки, то суд может признать такое условие несогласованным, что повлечет отказ в удовлетворении требования.

Например, суд отказал супермаркету во взыскании с частной охранной организации (ЧОО) потерь от недостачи товара, т.к. в договоре не был определен порядок ее выявления и ее связи с действиями ЧОО[5].

II. Упущенная выгода

Одним из элементов убытков наряду с реальным ущербом является упущенная выгода, т.е. компенсация за доход, который компания могла бы заработать, но не заработала из-за нарушения договора. Например:

- поставщик не поставил сырье, из-за чего фармкомпания не произвела и не продала препарат;
- продавец актива скрывал проблемы с регистрацией, сделка сорвалась, покупатель потерял возможность выйти на рынок.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ: «УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА — НЕПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ, КОТОРЫЕ ЛИЦО ПОЛУЧИЛО БЫ ПРИ ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА, ЕСЛИ БЫ ЕГО ПРАВО НЕ БЫЛО НАРУШЕНО»[6].

Стандарт доказывания ущерба (стоимость утраченного товара, допзатраты на его закупку у другого поставщика и пр.) в суде более-менее понятен. Требования судов к доказыванию упущенной выгоды строже по сравнению с ущербом. Чтобы ее взыскать, истцу приходится доказывать:

- наличие реальных предпосылок к получению дохода (контракты, производственные мощности, рынок сбыта, согласованная цена и т.п.);
- причинно-следственную связь между нарушением контрагента и неполучением дохода;
- обоснованность заявленного размера упущенной выгоды, который должен подтверждаться документами и расчетами.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ: «САМО ПО СЕБЕ УКАЗАНИЕ ЛИЦОМ НА НАЛИЧИЕ У НЕГО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ БЕЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ОБЪЯСНЯЮЩИХ ИХ ХАРАКТЕР И СОСТАВ, А ТАКЖЕ ПРИЧИННОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОТЕРЬ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАНО ДОСТАТОЧНЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УБЫТКОВ В ФОРМЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ»[7].

Фармпоставщик взыскал с иностранной компании более 876 млн руб.: она не согласовала заявки и не поставила продукцию, из-за чего истец не получил бонусы[8]. Из-за прекращения поставок поставщик не смог принять участие в государственных аукционах на общую сумму 5,3 млрд руб. Дочернее юрлицо иностранной компании само приняло в них участие и выиграло тендеры. Следовательно, истец не получил, но мог бы получить бонусы в размере 876 млн руб., если бы его право на получение товара не было нарушено ответчиком.

Плюс механизма — возможность компенсировать не только понесенные расходы, но и все, что компания «недозаработала». В отличие от возмещения потерь, право на взыскание упущенной выгоды предполагается (по умолчанию нарушение обязательств по договору чревато взысканием убытков, в т.ч. упущенной выгоды), если иное прямо не согласовано в договоре (оговорка о том, что упущенная выгода не возмещается).

Минус механизма — высокий стандарт доказывания: просто «прогноз» или «оценка» без опоры на реальные данные, а также на доказательства фактической подготовки к получению такой прибыли не принимается судами. Другой минус вытекает из плюса — возможность взыскания упущенной выгоды может быть направлена как в пользу, так и против самой компании.

→



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»*

III. Заверения об обстоятельствах

Заверения об обстоятельствах — это способ стороны сказать в договоре: «На дату сделки у нас все вот так, и мы готовы отвечать рублем, если это не так». В условиях информационной асимметрии этот механизм зачастую позволяет сторонам преодолеть взаимное недоверие.

В фармсделках это, как правило, утверждения продавца (иногда и покупателя) о ключевых фактах, которые критичны, для того чтобы принять решение о заключении сделки. Например:

- регистрационные удостоверения на продукты действительны, отсутствуют основания для отзыва или приостановления;
- у компании есть необходимые лицензии и разрешения на производство, хранение, оптовую реализацию;
- нет существенных, незаявленных судебных споров, проверок или претензий регулятора по передаваемым активам;
- финансовая отчетность не содержит существенных искажений, влияющих на оценку актива;
- отсутствуют скрытые обременения на производственные площадки или IP (изобретения, товарные знаки).

Если после сделки выясняется, что заверения были ложными, добросовестный контрагент, который на них полагался, вправе использовать несколько линий защиты: возмещение убытков, неустойки, отказ от договора или признание его недействительным (ст.431.2 ГК РФ).

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ: «ЗАВЕРЕНИЯ — ЭТО УТВЕРЖДЕНИЯ О ФАКТАХ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО ИЛИ УЖЕ СЛОЖИВШИХСЯ ОСНОВАНИЯХ БУДУЩИХ СОБЫТИЙ, А НЕ ПРО ТО, ЧТО «СТОРОНА ЧТО-ТО СДЕЛАЕТ»[9]. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ ЗА ОБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТ НЕСООТВЕТСТВИЯ ЗАВЕРЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, А НЕ ЗА «ВИНУ» В ПРИВЫЧНОМ СМЫСЛЕ»[10].

Плюсы механизма:

- Снижение риска «скрытых сюрпризов».
- Упрощенное доказывание. Фокус не на том, «что и почему произошло после сделки», а на том, что было на самом деле на дату ее заключения и соответствует ли это заверениям.

Минус механизма — добросовестность получателя заверений. Если покупатель знал или должен был знать, что заверения недостоверны, он может лишиться части защиты. Кроме того, заверения не должны подменять обязательства о будущем поведении стороны, они касаются только фактов прошлого или настоящего (в момент подписания сделки). Если контрагент «заверяет» о чем-то в будущем, то это не будет рассмотрено судами в качестве заверения, а наиболее вероятно будет переквалифицировано в обязательство.

На что обратить внимание

На практике при заключении продуктовых сделок в фармацевтике компании чаще используют комбинации различных механизмов минимизации рисков, таких как:

- возмещение потерь — для специфических отраслевых рисков (регуляторные действия, претензии третьих лиц, налоговые доначисления), не связанных прямо с нарушением обязательств по договору контрагентом;
- заверения об обстоятельствах — устранение информационной асимметрии, страховка сторон от неожиданных «сюрпризов» со стороны контрагента;
- неустойка — для управляемых нарушений, таких как сроки закрытия сделки, передача документов, выполнение обязательств;

НА ПРАКТИКЕ ДОЛЖНИКИ НЕРЕДКО ЗАЯВЛЯЮТ ХОДАТАЙСТВО О СНИЖЕНИИ НЕУСТОЙКИ ПО СТ.333 ГК РФ. ЕСЛИ У КОМПАНИИ ОТСУТСТВУЮТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СОРАЗМЕРНОСТИ, ТО ВЫСОКА ВЕРОЯТНОСТЬ СНИЖЕНИЯ НЕУСТОЙКИ СУДОМ.

- упущенная выгода — как дополнительная опция в судебном споре, когда есть сильные доказательства того, что именно нарушение контрагента сделало невозможным получение плановой прибыли. Соглашением сторон взыскание упущенной выгоды может быть исключено. Необходимо помнить, что каждый из инструментов обладает своей спецификой и их некорректное использование может повлечь для компании финансовые потери (например, невозможность взыскания), в связи с чем при согласовании сделок необходимо обращать пристальное внимание на подобные условия. ФВ

[1] Определение СК по экономическим спорам Верховного суда РФ от 14.11.2023 № 305-ЭС23-11168 по делу № А40-101929/2022.
[2] Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2026 по делу № А55-14392/2025.
[3] Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 22.01.2025 по делу № А09-11746/2021.
[4] Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.10.2025 по делу № А40-54226/2024.
[5] Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.08.2020 по делу № А59-2637/2019.
[6] П.14 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 1 ГК РФ».
[7] Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 15.06.2023 по делу № А40-281504/2021.
[8] Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.10.2016 по делу № А40-17761/2016.
[9] Постановление Пленума Верховного суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ о заключении и толковании договора».
[10] Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ № 305-ЭС22-17862 от 21.03.2023.

Самые распространенные и самые редкие педиатрические заболевания

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО



ТЕКСТ: Надежда Синицына

Педиатрия — это раздел медицины, который изучает особенности роста и развития, а также профилактику, диагностику и лечение патологий, которые возникают у детей и подростков от рождения до 18 лет. С какими заболеваниями педиатры сталкиваются чаще, а с какими реже и какую медицинскую помощь дети получают с самого первого дня жизни, разобрался «ФВ».

До 1,22 млн детей в год снизилась рождаемость в России в 2024 году, по данным Росстата

Рождаемость

Рождаемость в мире за последние пять лет снижалась с 134,7 млн родившихся в 2020 году до 132,4 млн в 2025 году с небольшим ростом в 2024-м, следует из данных ООН[1]. В 2024 году суммарный коэффициент рождаемости составил около 2,2 ребенка на женщину, а в 2025-м — 2,1. По состоянию на 2026 год человечество впервые находится ниже уровня воспроизводства, выяснили[2] ученые из Университета Пенсильвании и Северо-западного университета (США). Таких показателей ранее не выявляли даже во время войн и пандемий. Это значит, что детей в мире рождается меньше, чем нужно для поддержания постоянной численности населения, то есть суммарный коэффициент рождаемости ниже уровня простого воспроизводства. По данным исследователей, даже в Китае, где рождаемость традиционно высокая, фиксируется на 3,3 млн смертей в год больше, чем рождений.

В России, по данным Росстата[3], рождаемость год от года также постепенно снижается: с 1,44 млн в 2020 году до 1,22 млн в 2024 году. Ниже показатель опускался только в 1999 году. С весны 2025 года Росстат ограничил публикацию детальной демографической статистики, поэтому данные за 2025 год отсутствуют (табл. 1).

Смертность

С 2000-го по 2023 год глобальная смертность среди детей до пяти лет снизилась на 52% и составила в 2023 году 4,8 млн смертей. Почти половина смертей (2,3 млн случаев) среди детей до пяти лет приходится на первые 28 дней жизни. Такие данные приводятся в отчете UNICEF, опубликованном в 2025 году[4].

Рождаемость с 2020-го по 2025 год в абсолютных числах, млн человек

Год	В мире	В России
2020	134,72	1,44
2021	133,45	1,40
2022	132,48	1,30
2023	132,11	1,26
2024	132,41	1,22
2025	132,40	-

Источник: данные ООН, Росстат (с 2025 года Росстат ограничил публикацию детальной демографической статистики)

Таблица 1

Другая статистика

Распространенность задержки роста (одного из основных маркеров хронического недоедания) составила в 2024 году 150,2 млн случаев. Кроме того, в 2024 году выявлено 42,8 млн случаев истощения у детей младше пяти лет, говорится в публикациях ВОЗ[5]. Избыточная масса тела среди детей до пяти лет встречалась в 35,5 млн случаев. В старшей возрастной группе (5—19 лет) избыточный вес выявили у 390 млн детей и подростков.

Вакцинация

Дети получают медицинскую помощь с самого рождения. С первых дней жизни ребенок в роддоме проходит плановую вакцинацию для формирования иммунитета от опасных инфекционных заболеваний.

В Национальный календарь профилактических прививок входят[6] плановые профилактические прививки против 12 инфекций: вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.

Российский союз педиатров составил собственный идеальный календарь иммунизации, добавив к действующим 12 вакцинам еще восемь: от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, менингококковой инфекции, вирусного гепатита А, клещевого энцефалита, папилломавирусной, коронавирусной и респираторно-синцитиальной инфекции.

Включение вакцины от ротавирусной инфекции перенесено на 2029 год, от ветряной оспы — на 2031 год, от вируса папилломы человека и менингококковой инфекции — на 2027-й.

Неонатальный скрининг

Помимо вакцинации во время пребывания в роддоме новорожденные проходят расширенный скрининг[7] для раннего выявления редких наследственных патологий. В апреле 2026 года →



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»*

в программу расширенного неонатального скрининга включили еще два заболевания, и теперь она включает 38 патологий (табл. 2).

Самые распространенные заболевания у детей

Самая частая причина[8] обращения за медицинской помощью у детей — это острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается у детей от 3 до 14 лет. Частота заболеваемости ОРВИ уменьшается с возрастом, что связано с особенностями иммунной системы у детей младшей возрастной группы. Помимо ОРВИ наиболее распространенные[9] инфекции у детей — корь, краснуха, ветряная оспа, коклюш, эпидемический паротит, энтеровирусные и паразитарные инфекции (гельминтозы).

Орфанные заболевания у детей

В России к орфанным относят[10] заболевания с распространенностью не более 10 случаев на 100 тыс., или 0,2 на 2 тыс. населения (для сравнения — в США болезнь считается редкой, если ее распространенность составляет 0,6 случая на 1 тыс. населения).

В настоящее время в мире известно до 8 тыс. редких заболеваний, а число пациентов с такими патологиями составляет 6—8% от всего населения. В России зарегистрировано около 17,5 тыс. больных с 24 жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями. Более половины всех пациентов с орфанными заболеваниями — это дети, поскольку большинство таких патологий манифестирует в детском возрасте. Около 30% детей с редкими (орфанными) заболеваниями не доживают до пяти лет.

Синдром Филдс считается одним из самых редких в мире — зарегистрировано всего несколько случаев (сестры-близнецы Филдс из Уэльса и еще один случай). Это прогрессирующее

Программа расширенного неонатального скрининга

Название патологии	Код по МКБ-10
Врожденный гипотиреоз	E03.0
Адреногенитальный синдром	E25.0
Галактоземия	E74.2
Муковисцидоз	E84.9
Фенилкетонурия	E70.0
Дефицит синтеза биоптерина (тетрагидробиоптерина)	E70.1
Дефицит реактивации биоптерина (тетрагидробиоптерина)	E70.1
Тирозинемия, тип I	E70.2
Болезнь с запахом кленового сиропа мочи	E71.0
Гомоцистинурия	E72.1
Пропионовая ацидемия	E71.1
Метилмалоновая ацидемия (метилмалонил КоА-мутазы недостаточность)	E71.1
Метилмалоновая ацидемия (недостаточность кобаламина C)	E71.1
Метилмалоновая ацидемия (недостаточность кобаламина A)	E71.1
Метилмалоновая ацидемия (недостаточность кобаламина B)	E71.1
Метилмалоновая ацидемия (дефицит метилмалонил КоА-эпимеразы)	E71.1
Метилмалоновая ацидемия (недостаточность кобаламина D)	E71.1
Изовалериановая ацидемия	E71.1
Глутаровая ацидемия, тип I	E72.3
3-гидрокси-3-метилглутаровая недостаточность	E71.1
Глутаровая ацидемия, тип II	E71.3
Первичная карнитиновая недостаточность	E71.3
Среднецепочечная ацил-КоА дегидрогеназная недостаточность	E71.3
Длинноцепочечная 3-ОН ацил-КоА дегидрогеназная недостаточность	E71.3
Очень длинноцепочечная ацил-КоА дегидрогеназная недостаточность	E71.3
Недостаточность митохондриального трифункционального белка	E71.3
Недостаточность карнитин-пальмитоилтрансферазы, тип I	E71.3
Недостаточность карнитин-пальмитоилтрансферазы, тип II	E71.3
Недостаточность карнитин-ацилкарнитинтранслоказы	E71.3
Цитруллинемия, тип I	E72.2
Аргиназная недостаточность	E72.2
Недостаточность синтетазы голокарбоксилаз	E53.8
Бета-кетотиолазная недостаточность	E71.1
Дефицит биотинидазы	E53.8
Спинальная мышечная атрофия	G12.0 G12.1 G12.9
Первичные иммунодефициты	D80-D84
Дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот	E70.8
Х-сцепленная адренолейкодистрофия	E71.3

Источник: Минздрав РФ

Таблица 2

нервно-мышечное заболевание, которое приводит к постепенной дегенерации мышц.

MPPH-синдром — крайне редкий врожденный порок развития центральной нервной системы, сочетающий макроцефалию, полимикрогирию (большое количество мелких извилин), постаксиальную полидактилию (лишние пальцы на руках или ногах) и гидроцефалию.

Врожденная генерализованная липодистрофия — наследственное заболевание, для которого характерно генерализованное отсутствие подкожно-жирового слоя. Распространенность составляет от 1:10 млн населения в США до 1:500 тыс. в Португалии.

Врожденное нарушение гликозилирования 1b типа — наследственное заболевание, в основе которого лежит недостаточность фермента фосфоманнозаизомеразы, которая приводит к изменению физико-химических свойств гликопротеинов и нарушению их функций в организме. Встречается реже, чем у одного человека на 1 млн населения. Проявляется, начиная с трехмесячного возраста, энтеропатией, хронической диареей, рвотой, гепатомегалией с исходом в фиброз и цирроз. Характерна склонность к кровотечениям.

Болезнь Пелицеуса—Мерцбахера — это Х-сцепленное, прогрессирующее, дегенеративное заболевание. Характеризуется замедлением и затем полной преждевременной остановкой миелинизации. Встречается у одного из 500 тыс. новорожденных. Чаще всего первые признаки заболевания появляются в младенчестве в виде нистагма, блуждающего взгляда, тремора головы и стридора. С возрастом присоединяется атетоз, хореоформные движения, атаксия, интенционный тремор, частые рвоты и трудности с кормлением. Характерна атрофия глазного нерва и эпилепсия.

Лекарственным обеспечением детей с редкими (орфанными) заболеваниями в России занимается фонд «Круг добра».

Динамика заболеваемости детей в России

С 2014-го по 2023 год первичная заболеваемость детей 0—14 лет снизилась на 7%, следует из данных Минздрава России[11]. В 2023 году показатель составил 170,7 тыс. случаев на 100 тыс. детей. Общая заболеваемость также снизилась примерно на 0,9% и составила 221 тыс. на 100 тыс. При этом первичная заболеваемость подростков 15—17 лет выросла на 3,5%; общая — на 1,6%.

У детей 0—14 лет ведущими патологиями стали болезни органов дыхания (55%), ЖКТ (5,7%) и болезни глаз (5,4%). Среди подростков 15—17 лет на первом месте по распространенности также оказались болезни органов дыхания (35%), за ними следуют патологии глаз (9,6%) и ЖКТ (8%).

Отмечен рост заболеваемости ожирением среди детей младше 14 лет (примерно на 2,3% в год) и у подростков (на 3,3% в год). Также выросла заболеваемость диабетом 1-го типа у детей (на 6,3% в год) и подростков (на 4,1% в год). Заболеваемость диабетом 2-го типа увеличилась в старшей возрастной группе (на 9,2% в год). ФВ

На 7%
снизилась первичная заболеваемость детей 0—14 лет в России с 2014-го по 2023 год, по данным Минздрава РФ

[1] UN World fertility report 2024.
[2] Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World, Annual Reviews of Economics, Aug 10, 2026.
[3] ЕМИСС государственная статистика, число зарегистрированных родившихся (оперативные данные).
[4] United Nations Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME), Report 2024, Mar 24, 2025.
[5] UNICEF-WHO-World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates (JME) 2025.
[6] Информация для педиатров, Союз педиатров России.
[7] Программа расширенного неонатального скрининга на наличие наследственных и врожденных заболеваний, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.
[8] Острые респираторные инфекции у часто болеющих детей: рациональная этиотропная терапия, РМЖ.
[9] Самые распространенные детские инфекции. Меры профилактики, Роспотребнадзор.
[10] Распространенность и вопросы диагностики редких (орфанных) заболеваний среди детского населения Российской Федерации. Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. 2020.
[11] Информационно-аналитические материалы по заболеваемости детей в динамике за 2014—2023 гг., Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора.



ИРИНА ЗАХАРОВА:

«ПЕДИАТРАМ ПРИХОДИТСЯ БЫТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫМИ»



ТЕКСТ: Анжелика Дун ФОТО: Олег Кирюшкин

Современные педиатры отмечают изменение не только здоровья детей, но и модели поведения родителей. Почему врачам стало сложнее выстраивать отношения с мамами пациентов, какие изменения в здоровье детей вызывают обеспокоенность и есть ли решение проблемы нехватки лекарственных форм для детей с эозинофильным эзофагитом, рассказала в интервью «ФВ» заведующая кафедрой педиатрии им. акад. Г.Н. Сперанского РМАНПО, докт. мед. наук, проф., заслуженный врач РФ Ирина ЗАХАРОВА.

— Какие вызовы стоят перед современной педиатрией?

— Главная мечта — сохранить клиническое мышление врачей. Доктор должен учиться круглогодично в любом возрасте. В 1960-х годах основатель нашей кафедры **Георгий Сперанский** говорил: «Чтобы врачу не опоздать, нужно в день читать 16 статей». Сейчас наука настолько ушла вперед, что теперь это невозможно. Поэтому очень важно слушать лекции преподавателей, которые собирают, анализируют и передают научные знания.

С 2020 года мы почти каждый рабочий день проводим школу клинического мышления, независимую, без участия спонсоров. К ней подключаются до 100 врачей со всей страны в качестве слушателей и докладчиков. В рамках проекта разбираются тяжелые клинические случаи, часто уникальные. Например, заведующая онкологическим отделением НМИЦ им. В.А. Алмазова несколько лет назад показала нам ребенка с нетипичным течением ботулизма. Ему не могли поставить диагноз в нескольких больницах, в том числе московских.

Были уникальные случаи детей после трансплантации сердца и почек. Во время пандемии мы знакомились со случаями мультисистемного воспалительного синдрома у детей с коронавирусной инфекцией, и вся страна использовала наши данные.

Заведующий отделением реанимации в клиническом центре «Коммунарка» разбирал три случая детей с коклюшем. К сожалению, они не выжили. Эта трагедия подчеркивает, что врач-педиатр не имеет права быть антиваксером. Поэтому мы проводим колоссальную работу по пропаганде вакцинации.

— Наставничество поможет поддержать такую преемственность?

— Последние 18 лет я заведую кафедрой педиатрии имени академика Сперанского, где проработала 38 лет, начиная с ординатуры. В течение 29 лет ей руководил сам Георгий Сперанский. Ученики его учеников стали моими преподавателями. А я пытаюсь передать их опыт молодому поколению. Сегодня это называют наставничеством, но такая практика была всегда.

Каждый год у нас проходят обучение 50—60 клинических ординаторов. Практика остается основой образования, наши ординаторы лечат больных под руководством ассистентов, доцентов, профессоров. Важно научить врача не только профессионализму, но и отношению к каждому больному, как к своему близкому родственнику. Эти принципы мы передали своим выпускникам. Например, все заведующие отделениями нашей основной клинической базы, Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, были учениками кафедры Георгия Сперанского. Также наши ученики работают в разных регионах страны, передают наш опыт своим молодым коллегам.

— Как изменились сами пациенты?

— Меняется прежде всего мама, ее психология. Я сопрезидент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Статус Презенс» и отвечаю за направление педиатрии. В рамках этого проекта был подготовлен доклад академика **Виктора Радзинского** «Портрет современной женщины на приеме гинеколога». Это вдохновило меня на создание такой же работы, но уже о матери на приеме педиатра.

К акушеру-гинекологу женщина приходит с уважением, чего, к сожалению, нельзя сказать об обращении к педиатру. Женщина часто ведет себя неадекватно и порой ее мнение опасно для здоровья ребенка. Женщины сегодня психологически не всегда готовы к рождению детей. Например, одной из моих коллег из центра лечения послеродовой депрессии пациентка рассказала, что во время беременности ее все окружили вниманием, а после родов вся забота перешла на ребенка. Из-за этого у нее и появились симптомы депрессии. Получается, что женщина сама еще ребенок.

Родители меньше говорят с детьми. Раньше у девочек появлялась речь в 15—18 месяцев,

16–18%

детей в России рождаются путем кесарева сечения, по данным академика Виктора Радзинского

РОДИТЕЛИ МЕНЬШЕ ГОВОРЯТ С ДЕТЬМИ. РАНЬШЕ У ДЕВОЧЕК ПОЯВЛЯЛАСЬ РЕЧЬ В 15—18 МЕСЯЦЕВ, У МАЛЬЧИКОВ — В 18—20 МЕСЯЦЕВ, А ТЕПЕРЬ ДЕТИ МОЛЧАТ И В 2,5 ГОДА. НЕКОТОРЫЕ НАЧИНАЮТ ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО В 4,5 ГОДА. ПРИЧИНЫ ЭТОГО МЫ ИЗУЧАЕМ В ИССЛЕДОВАНИИ «МОЛЧАЛИВОЕ ДЕТСТВО». ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН МОЖЕТ БЫТЬ ТО, ЧТО ЖЕНЩИНЫ МЕНЬШЕ ТРАТЯТ ВРЕМЕНИ НА БЫТ, НА РЕБЕНКА И БОЛЬШЕ НА СЕБЯ.



у мальчиков — в 18—20 месяцев, а теперь дети молчат и в 2,5 года. Некоторые начинают говорить только в 4,5 года. Причины этого мы изучаем в исследовании «Молчаливое детство». Одной из причин может быть то, что женщины меньше тратят времени на быт, на ребенка и больше на себя.

Также женщины перестали кормить грудью. Проводя дородовые патронажи в одном из центров, мы узнали, что приблизительно 10% женщин планировали отказаться от грудного вскармливания (ГВ) из-за установленных имплантов. Хотя они не влияют на возможность ГВ, женщины все же боялись обвисания железистой ткани. Вдобавок мамы заявляют о желании курить, пить вино с мужем, поехать в клуб, ведь все девять месяцев беременности им приходилось отказываться от этого. Многие даже останавливают лактацию медикаментозно.

Проблему проведения кесарева сечения по желанию родителей удалось смягчить. Операцию теперь почти не проводят без показаний. Это важно, поскольку кесарево повышает риски аллергии, аутизма, ожирения, воспалительных заболеваний кишечника и других расстройств у детей. Еще недавно в 29% случаев дети в России рождались путем кесарева сечения. По данным академика Виктора Радзинского, сейчас этот показатель составляет 16—18%, то есть мы приблизились к рекомендации Всемирной организации здравоохранения в 14% или менее.

Женщины сегодня психологически не всегда готовы к рождению детей. Например, одной из моих коллег из центра лечения послеродовой депрессии пациентка рассказала, что во время беременности ее все окружили вниманием, а после родов вся забота перешла на ребенка. Из-за этого у нее и появились симптомы депрессии. Получается, что женщина сама еще ребенок.

— А что касается структуры заболеваемости детей?

— Недавно заместитель председателя Правительства РФ **Татьяна Голикова** сообщила, что к 2030 году практически 70 млн россиян будут иметь избыточную массу тела или ожирение. Для детей это очень опасно из-за рисков сахарного диабета 2-го типа, ряда воспалительных заболеваний, гормональных нарушений. Мы с коллегами уже выпустили обзор исследований связи микропластика и различных заболеваний, в том числе он играет не последнюю роль в распространении ожирения.

Фертильность также страдает от загрязнения окружающей среды: микропластик уже обнаруживается в сперме. Коллеги-урологи подтверждают, что более чем в половине случаев причины бесплодия связаны с мужским здоровьем. Но первые 18 лет жизни мальчика за ним наблюдает педиатр. Поэтому на нас лежит большая доля ответственности за сохранение фертильности. В частности, важно производить полный осмотр ребенка. Недопустимо, когда половые органы проверяются только на первом году жизни, а затем в 15 лет при отборе для военной службы.

Акушеры-гинекологи говорят о том, что средний овариальный резерв также снижается. Рекомендации по действиям педиатров для сохранения фертильности девочек мы планируем представить на семинарах.

— Что могут сделать родители для здоровья своих детей?

— Ограничить использование подгузников, поскольку яички должны находиться в подвешенном состоянии и не перегреваться. Нужно чаще менять подгузники, использовать дышащие изделия. Например, есть многоразовые изделия с вкладышами из марли. Это еще и значительно дешевле одноразовых подгузников.

— Чего вы ждете от фармацевтической промышленности?

— Хочется того, чего не будет: разрешения назначать детям некоторые препараты для взрослых. К счастью, есть возможность применять такие лекарства по решению консилиума.

Примером служит эозинофильный эзофагит у детей. У нас наблюдается более 300 пациентов с этим диагнозом. Такого количества больных в России больше нет нигде. Понятно, что наша главная цель при ведении таких пациентов — убрать из рациона белок молока и обеспечить поступление всех аминокислот. И все же есть потребность в орофарингеальных формах будесонида, которые дольше, хотя бы полчаса, остаются в пищеводе, обволакивая его. Такие препараты есть только в Италии.

Педиатрам приходится быть изобретательными. Если ребенок страдает тяжелой болезнью, нам надо его лечить. Поэтому мы сейчас придумываем носители, с которыми можно смешивать будесонид для детей. Уже пробовали несколько видов сиропов, но препарат моментально пролетал. Орофарингельная форма заметно упростила бы нам жизнь. ФВ

Сколько на рынке педиатрических лекарств

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО

ТЕКСТ: Елена Калиновская



Молодые мамы — одна из постоянных категорий посетителей аптек. Дети чаще простужаются, у них болят горло и уши, нередко у них возникают расстройства ЖКТ. При этом рынок средств, применяемых у детей, неоднороден: в нем соседствуют рецептурные и безрецептурные лекарства, БАД, медицинские изделия и гигиеническая продукция. «ФВ» проанализировал, какие средства разрешены для применения в педиатрической практике в наиболее популярных терапевтических областях.

Как мы искали детские лекарства

Клинические испытания с участием детей имеют ряд особенностей. Пациентам младшего возраста необходимы специальные лекарственные формы, фармакокинетика лекарств различается из-за особенностей метаболизма, возможны отдаленные побочные эффекты, которые могут повлиять на физическое и когнитивное развитие, а для большинства хронических заболеваний речь идет о меньшем размере популяции. Поэтому, несмотря на кажущуюся популярность лекарств для детей, отдельных педиатрических препаратов на рынке немного. К тому же, препараты для взрослых можно использовать у детей с 12 лет. В рамках данного анализа к педиатрическим были отнесены препараты, в инструкциях которых прямо предусмотрено применение у детей до 12 лет.

Основным источником информации для поиска детских лекарств была инструкция по медицинскому применению. Педиатрические препараты отличаются от взрослых не только лекарственной формой, но и дозировками, а также кратностью введения. Иногда дозировка разрешена для всех возрастных групп, но форма для детей отличается. Некоторые сосудосуживающие средства у детей раннего возраста применяются только в каплях, а спреи не рекомендованы.

Для исследования в одних сегментах использовались бренды, в других — только торговые наименования*. Это связано с тем, что у одного бренда могут быть несколько линеек препаратов для детей. Поэтому в таких случаях логично было использовать бренд, ограничив выборку дозировкой или лекарственной формой.

Госзакупки «ФВ» не анализировал, поскольку подавляющее большинство этих препаратов реализуется в розничном сегменте.

Средства от боли и жара

В педиатрической практике для обезболивания и в качестве жаропонижающих средств можно использовать ибупрофен и парацетамол. Это, например, следует из клинических рекомендаций Минздрава РФ по лечению гриппа у детей.

В августе 2025-го — июле 2026 года на рынке, согласно данным «АльфаРМ», обращались жаропонижающие средства 16 производителей в лекарственных формах, которые, как правило, предназначены для детей. К таким формам отнесены сиропы, растворы для приема внутрь, суспензии и суппозитории. У многих производителей в портфеле есть и детский ибупрофен, и детский парацетамол: например, у «Татхимфармпрепаратов», «Фармстандарта», «Биннофарм Групп», Тульской фармфабрики и др.

Часть компаний не создают для этих препаратов специальный бренд и выпускают их под наименованием МНН. В частности, к такой тактике прибегли «Алвилс», «Дальхимфарм», «Озон», индийская компания Jivdhara Pharma.

За 12 месяцев, с августа 2025 года по июль 2026 года, продано 20,6 млн упаковок педиатрических форм парацетамола и ибупрофена на 3,7 млрд руб. В этом сегменте продажи снизились на 3% в рублях и на 2% в упаковках. Большая часть продаж пришлась на ибупрофен: 85,1% — в рублях; 67,6% — в упаковках.

Продажи ибупрофена составили 13,9 млн упаковок на 3,1 млрд руб., парацетамола — 6,7 млн упаковок на 548,2 млн руб.

Всего за 12 месяцев на рынке обращалось 16 торговых наименований. При этом под наименованием «Ибупрофен» препараты выпускали шесть производителей, под наименованием «Парацетамол» — три.

Наибольший прирост показал препарат «Ибупирин кидс» компании Danhson. Вероятно, это связано не с увеличением рыночной доли, а с продажей оставшихся в стране запасов. Согласно информации Росздравнадзора, в последний раз препарат с этим торговым наименованием вводился в оборот весной 2022 года, как и таблетки «Ибупирин».

У препарата «Ибупрофен ВП» прирост превысил 300%; возможно, здесь наблюдается та же ситуация. Препарат производит болгарская компания

СПИСОК ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ДЕТСКИХ ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ СРЕДСТВ МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ. ПРОДАЖИ НЕКОТОРЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК, КАК ВЫЯСНИЛ «ФВ», ПОКАЗАЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ, ПРИ ЭТОМ ИХ ПОСЛЕДНЯЯ ПАРТИЯ ВВОДИЛАСЬ В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ В 2022—2024 ГОДАХ. А РОСТ СВЯЗАН С РАСПРОДАЖЕЙ ОСТАВШИХСЯ В СТРАНЕ ЗАПАСОВ.



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»*

20,6
млн упаковок

педиатрических форм парацетамола и ибупрофена на 3,7 млрд руб. продано с августа 2025 года по июль 2026 года, по данным «АльфаРМ»

Vetprom, входящая в холдинг Danhson; препарат с этим торговым наименованием в последний раз вводился в гражданский оборот в мае 2024 года.

Аналогичная ситуация сложилась с раствором для приема внутрь «Эффералган»: он в последний раз вводился в оборот в июне 2023 года. В то же время взрослые формы в виде шипучих таблеток были введены в оборот в сентябре 2026 года.

Прирост на 143% показало средство «Нурофактор» Тульской фармфабрики. Препарат с таким торговым наименованием присутствует на рынке с 2019 года, но в поставках был перерыв с февраля 2024 года по март 2026 года.

Суспензия «Ибупрофен-АКОС», продажи которой выросли на 104%, в последний раз вводилась в оборот в 2023 году. Здесь также может идти речь о распродаже запасов.

Таким образом, через некоторое время список торговых наименований детских жаропонижающих средств может сократиться, если производители не возобновят ввод этих препаратов в гражданский оборот.

Среди производителей лидирует Reckitt, на втором месте — «Фармстандарт», третью строчку занимает компания «Нижфарм».

Чем лечить горло

В этой категории препаратов для детей мало: в основном лекарство может назначаться и взрослым, и детям, а различаются лишь способ применения, дозировка и кратность приема. «ФВ» проанализировал торговые наименования препаратов группы второго уровня классификации EphMRA «Препараты для лечения заболеваний горла» и отобрал препараты, в инструкциях к которым разрешено применение у детей.

За 12 месяцев, с августа 2025 года по июль 2026 года, на рынке продавались 35 торговых наименований препаратов для лечения горла, разрешенных к применению в педиатрической практике, от 26 производителей. Общий объем составил 65,1 млн упаковок на 27,6 млрд руб. В рублях продажи снизились на 2%, в упаковках — на 12%.

В аптечном сегменте среди препаратов для лечения заболеваний горла, разрешенных для применения у детей, по приросту лидирует препарат «Тантум Верде» — 11% за анализируемый период. На втором месте — «Лизобакт», на третьем — «Септолете Тотал». У остальных торговых наименований продажи либо снизились, либо остались на уровне предыдущего периода.

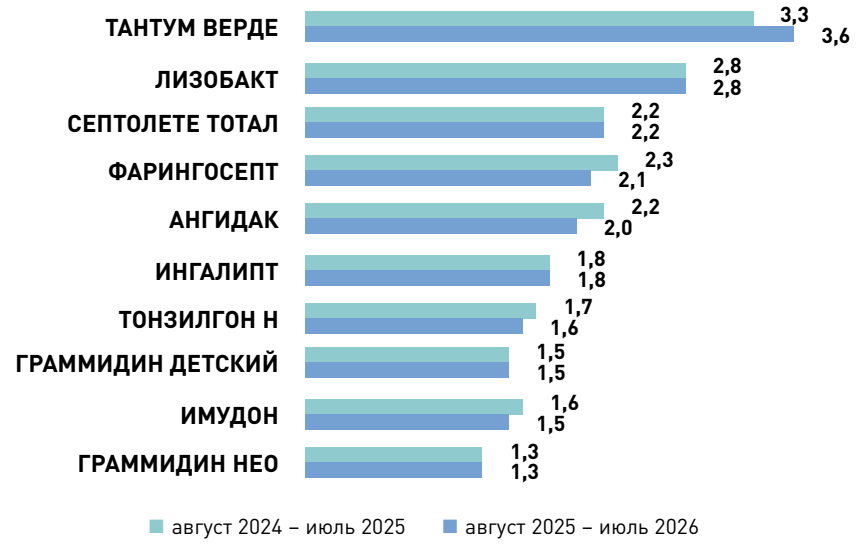
Среди производителей по доле рынка в лидерах «Валента Фармацевтика», у которой есть четыре торговых наименования, разрешенных к применению у детей. Компания занимает 15,4% сегмента в рублевом выражении. На втором месте Angelini Pharma (13,2%), на третьем — Bosnalijek (10,2%). →

Рейтинг торговых наименований жаропонижающих средств для детей

Торговое наименование	Объем продаж, млн руб.		Динамика, %
	август 2024 года — июль 2025 года	август 2025 года — июль 2026 года	
«Нурофен для детей»	2 812,9	2 732,4	↓ 3
«Парацетамол детский»	312,4	311,3	0
«Ибупрофен»	230,1	239,4	↑ 4
«Цефекон Д»	223,7	200,4	↓ 10
«Ибупрофен форте»	135,0	114,2	↓ 15
«Парацетамол-АКОС»	16,4	17,3	↑ 5
«Ибупрофен-АКОС»	7,5	15,3	↑ 104
«Нурофактор»	3,5	8,5	↑ 143
«Ибупрофен ВП»	1,5	7,3	↑ 376
«Парацетамол Фортекидс»	7,1	7,2	↑ 1
«Ибупрофен Фармасинтез»	6,1	7,1	↑ 17
«Парацетамол»	3,3	5,7	↑ 73
«Эффералган»	0,6	2,5	↑ 328
«Парацетамол-ЭКОлаб»	8,5	2,1	↓ 76
«Парацетамол-Альтфарм»	3,0	1,8	↓ 41
«Ибупирин кидс»	0,0	1,4	↑ 3 017

Источник: база компании «АльфаРМ» «Розничный аудит аптечных продаж ЛС и БАД в РФ», в ценах конечного потребления, расчеты «ФВ» Таблица

ТОП-10 ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА, РАЗРЕШЕННЫХ В ПЕДИАТРИИ, ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ, МЛРД РУБ.



Источник: база компании «АльфаРМ» «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ», в ценах конечного потребления, расчеты «ФВ»

Рис. 1

Средства от насморка

В августе 2025 года — июле 2026 года на рынке продавалось 426 торговых наименований средств для лечения насморка от 151 производителя. Это наиболее популярная у производителей категория. Все препараты можно разделить на средства для промывания носа и препараты, содержащие лекарственные действующие вещества; наиболее популярные из последних — сосудосуживающие средства.

Средства для промывания носа часто регистрируются как медицинские изделия, но есть и зарегистрированные лекарственные препараты, также встречаются косметические и гигиенические средства. Основной их состав — солевой раствор. Для анализа взяты спреи и капли для промывания носа, которые зарегистрированы как лекарства и в инструкциях к которым прямо указан детский возраст. Однако не исключено, что родители покупают солевой раствор для детей, не обращая внимания на возрастные указания в инструкции.

Сосудосуживающие средства часто не имеют отдельных детских форм. Например, ксилометазолин, который в упаковках занимает 59% рынка средств для лечения заболеваний носа, в дозировке 0,05% разрешен с двух лет, а в дозировке 0,1% — с шести лет и применяется как у детей, так и у взрослых.

Окончательная выборка средств для лечения заболеваний носа у детей формировалась с учетом дозировки (если она была указана), формы выпуска и производителя. Эти данные сопоставлялись с инструкцией по медицинскому применению.

В анализируемый период на рынке обращались 158 торговых наименований средств для лечения заболеваний носа с прямым указанием на возможность применения у детей от 94 производителей. Объем продаж составил 349,3 млн упаковок на 71,2 млрд руб. Прирост в рублях к августу 2024 -го — июлю 2025 года составил 6%, в упаковках было снижение на 1%. Прирост всего сегмента, включающего средства для взрослых и детей, также составил 5% в рублях, а продажи в упаковках снизились на 1%.

В аптеках лидировали продажи разрешенных для детей ксилометазолина (27,9 млрд руб.), мометазона (8,5 млрд) и оксиметазолина (7,5 млрд). На четвертом месте — препараты, не имеющие МНН, как правило, средства для промывания носа, с продажами 6 млрд руб.

Некоторые компании имеют несколько торговых наименований, которые можно применять в педиатрии, поэтому составлен рейтинг брендов, среди которых лидирует «Отривин», показавший динамику 20%. Чуть больше увеличились продажи «Ксилена» — на 21%; он оказался на десятом месте по объему продаж. На 13% выросли продажи «Ринонорма», занявшего третье место, на 10% — «Синупрета» (2-е место), на 9% — «Тизина» (7-е место).

«Нижфарм» — первый среди производителей препаратов от насморка; его доля в сегменте разрешенных для детей средств составляет 15,2%. Вторую строку занимает Haleon (13,3%), третью — Teva (9,4%).

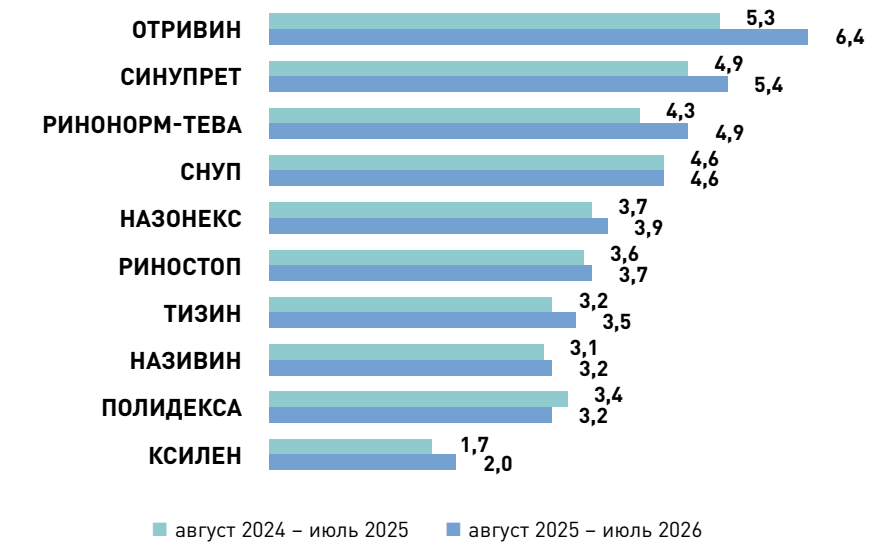
Чем лечить уши

Как правило, лечение отитов у детей препаратами для заболеваний уха отличается меньшей кратностью введения, чем у взрослых. В группе «ушных» средств также есть гигиенические препараты, которые не зарегистрированы как лекарственные. У большинства из них отсутствует указание на возможность применения у детей, поэтому в анализе они не учитывались.

Препараты для лечения заболеваний уха условно можно разделить на три группы: обезболивающие, противовоспалительные и антибактериальные, применяемые наружно, то есть их закапывают в ухо.

Самое популярное обезболивающее средство — комбинация лидокаина и феназона. Из 23 торговых

ТОП-10 БРЕНДОВ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА, РАЗРЕШЕННЫХ В ПЕДИАТРИИ, ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ, МЛРД РУБ.



Источник: база компании «АльфаРМ» «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ», в ценах конечного потребления, расчеты «ФВ»

Рис. 2

На 2,5 млрд руб.

продано препаратов для улучшения микрофлоры у детей в августе 2025 года — июле 2026 года, по данным «АльфаРМ»

наименований препаратов для лечения заболеваний уха, разрешенных в педиатрии, 11 содержат эти действующие вещества. Еще одно обезболивающее средство — нестероидный противовоспалительный препарат холина салицилат (только одно торговое наименование на рынке). Противовоспалительные вещества беклометазон и дексаметазон входят в комбинации с антибиотиками хлорамфениколом, полимиксином B, неомицином, грамицидином и др. Также представлены монопрепараты-антибиотики: норфлоксацин, офлоксацин, рифамицин.

На первом месте среди торговых наименований — обезболивающий препарат «Отипакс». Далее следуют комбинации противовоспалительных препаратов с антибиотиками и другими компонентами — «Кандибиотик» и «Комбинил», который также применяется в офтальмологии.

Для живота и бодрости духа

В области ЖКТ и витаминов препаратов для детей значительно больше. Многие из них регистрируются как биологически активные добавки, поэтому в этом сегменте поиск детских препаратов велся не столько по инструкциям, сколько по названиям. В названия витаминов, пробиотиков и пребиотиков часто включают слова «бэби» («беби»), «кидс», «малыш», «юниор» и др.

Сорбенты, применяемые при кишечных расстройствах, регистрируются и как лекарства, и как БАД. В педиатрии, как и при лечении взрослых, популярны смектит диоктаэдрический, кремния диоксид коллоидный, полиметилсилоксана полигидрат.

На рынке представлено более 30 брендов сорбентов. Конкуренция стимулирует производителей выделять свои продукты на фоне других, поэтому к сорбентам часто добавляют дополнительные действующие вещества, например янтарную кислоту, микрокристаллическую целлюлозу, инулин и др. При этом в добавках для детей не используется янтарная кислота.

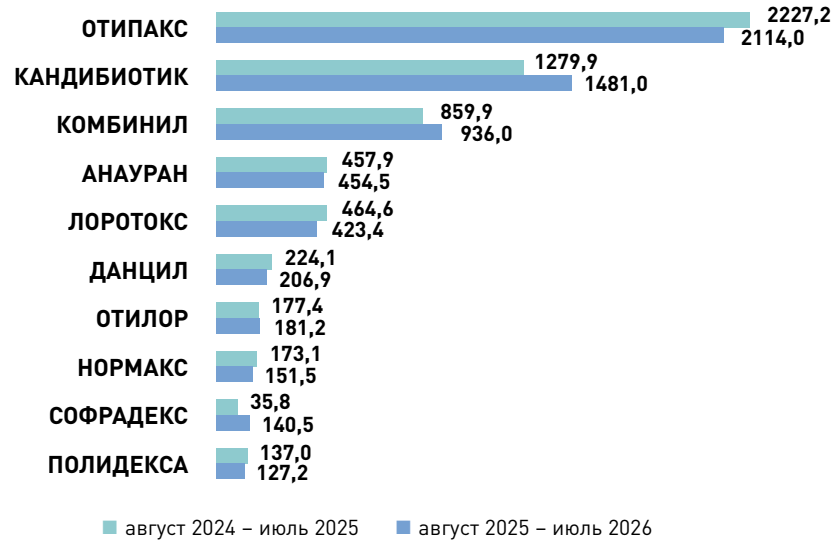
Всего сорбентов для детей в августе 2025-го — июле 2026 года было продано на 10,5 млрд руб.; по сравнению с аналогичным периодом 2024—2025 годов продажи снизились на 1%.

По объему продаж на рынке лидируют «Энтеросгель» — 4,5 млрд руб., «Полисорб» — 3,4 млрд руб. и «Смекта» — 1,7 млрд руб. В первую десятку сорбентов также вошли бренды «Солосорб» (полиметилсилоксана полигидрат), «Будь здоров» (кремния диоксид и целлюлоза микрокристаллическая), «Алесорб» (кремния диоксид коллоидный), «Энтерумин» (алюминия оксид и активированный уголь), «Консумед» (кремния диоксид коллоидный), «Пепидол» (3%-ный водный раствор пектина), «Минералдетокс» (комбинации смектита диоктаэдрического с инулином, магния карбонатом, лактулозой). Общие продажи этих брендов составили 740,4 млн руб.

Еще одна востребованная группа — средства от обезвоживания. В анализируемом периоде на рынке обращалось 34 бренда. Препараты содержат декстрозу, калия хлорид, натрия хлорид, натрия цитрат. Здесь компании также добавляют другие вещества, чаще всего кремния диоксид, цинка лактат, лактобактерии реутери.

Общий объем продаж регидрантов, которые можно применять в педиатрии, вырос на 12% и составил 1,2 млрд руб. На первом месте — «Регидрон» с продажами 614 млн руб., на втором — «Адиарин» с 290 млн руб., на третьем — «РегидроВит» с 102,3 млн руб. В первую десятку вошли бренды «Будь здоров», «Югмедфарм», «Витамир», «Импловит», «Эркафарм», «Консумед», «Полигидрин»; их общие продажи составили 130,4 млн руб.

ТОП-10 ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ УХА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ, ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ, МЛН РУБ.



Источник: база компании «АльфаРМ» «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ», в ценах конечного потребления, расчеты «ФВ»

Рис. 3

Третье популярное направление среди желудочно-кишечных препаратов у детей — препараты, уменьшающие газообразование. Они содержат либо симетикон, либо растительное сырье — чаще всего плоды фенхеля обыкновенного или укропную воду. Общие продажи педиатрических ветрогонных и пеногасителей составили 2,8 млрд руб., прирост — 21%. На первом месте — «Эспумизан» с продажами 959,3 млн руб., затем «Дантинорм бэби» с чуть меньшим объемом — 918,5 млн руб., третью строчку занял «Боботик» с 579,6 млн руб.

Еще два востребованных сегмента в педиатрической практике — про- и пребиотики, а также комплексные витамины. Препаратов для улучшения микрофлоры у детей в августе 2025 года — июле 2026 года продано на 2,5 млрд руб., что на 5% больше по сравнению с предыдущим периодом. Лидирует «Бак-Сет бэби» с долей 48,6% и продажами 1,2 млрд руб. На втором месте — «Максилак бэби» с 198,3 млн руб., на третьем — «Бицифин бэби» с 180,5 млн руб.

Детских поливитаминов за 12 месяцев было продано на 1,8 млрд руб., что на 6% меньше, чем в предыдущем периоде. На первом месте — «Витрум», у которого несколько детских линеек; объем продаж составил 567,6 млн руб. Затем идет «Бэби Формула Мишки»: в этой категории представлены два торговых наименования, продажи составили 345,9 млн руб. Третье место занял бренд «Мульти-табс» с четырьмя линейками и продажами 316,7 млн руб. ФВ

* Бренд — коммерческое обозначение продуктовой линейки, объединяющее несколько лекарственных препаратов или их вариантов, воспринимаемых рынком как единая марка.
Торговое наименование — конкретное название лекарственного препарата, используемое при его регистрации и реализации.

От профилактики респираторно-синцитиальной инфекции до лечения редких заболеваний

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПЕДИАТРИИ



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»*

ТЕКСТ: Надежда Синицына

В ноябре 2025 года ВОЗ опубликовала новую глобальную повестку исследований в области педиатрии[1]. Документ определяет 172 приоритетных направления, охватывающих инфекционные и неинфекционные заболевания, здоровье новорожденных и питание, с акцентом на устранение пробелов в доказательной базе для детей в странах с низким и средним уровнем дохода.

Исследования, посвященные профилактике инфекционных заболеваний

Профилактика респираторно-синцитиальной инфекции

Одним из наиболее важных направлений остается профилактика инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Исследования 2025 года подтвердили высокую эффективность моноклональных антител при профилактике тяжелых инфекций, вызванных RSV, в реальной клинической практике.

В ходе исследования III фазы ученые из Университета Колорадо оценили эффективность клесровимаба (clesrovimab), моноклонального антитела с увеличенным периодом полувыведения, которое связывается с участком IV фузионного белка RSV, обеспечивая защиту при однократном введении на один сезон[2]. Клесровимаб показал 60%-ную эффективность в отношении RSV-ассоциированных инфекций нижних дыхательных путей, потребовавших обращения за медицинской помощью, и 84%-ную — в отношении RSV-ассоциированных госпитализаций у здоровых недоношенных и доношенных детей. Анализ данных, полученных после регистрации, показал, что клесровимаб эффективен на 88% в профилактике инфекций нижних дыхательных путей, потребовавших обращения за медицинской помощью. Профиль безопасности в группе клесровимаба и плацебо оказался сопоставим, число нежелательных явлений не увеличилось.

Кроме того, ученые из Йоркского университета в Торонто провели метаанализ 15 реальных исследований (с участием более 236 тыс. детей), который подтверждает эффективность нирсевимаба (nirsevimab) в реальных условиях[3]. Частота госпитализаций из-за инфекций нижних дыхательных путей снизилась на 62%, частота обращений за неотложной помощью в связи с такими инфекциями — на 48%. Также на 76% сократилась частота обращений за неотложной помощью из-за специфичных для RSV инфекций нижних дыхательных путей.

Эксперты отмечают, что эти результаты подтверждают целесообразность включения моноклональных антител в программы иммунизации детей младшего возраста.

На 62%

снизилась частота госпитализаций из-за инфекций нижних дыхательных путей — подтвердил метаанализ 15 исследований эффективности нирсевимаба в реальных условиях

Исследование новых вакцин против пневмококковой инфекции

Весной 2026 года компания Pfizer объявила об успешном завершении II фазы исследования 25-валентной вакцины против пневмококковой инфекции у детей[4]. Согласно полученным данным, кандидатная вакцина 25vPnC усиливает защиту от серотипа 3 в сравнении с вакциной PREVNAR 20. Через месяц после введения третьей дозы 25vPnC средние титры антител для серотипа 3 были выше в 8,8 раза, а спустя месяц после четвертой иммунизации — выше примерно в 15 раз в сравнении с группой PREVNAR 20. Ожидается, что вакцина сможет защитить от 90% серотипов, которые вызывают пневмококковую инфекцию у детей младше пяти лет. 25vPnC основана на 20 серотипах, которые входят в PREVNAR 20, с добавлением 15A, 23A, 23B, 24F и 35B, что обеспечивает дополнительные 25% охвата случаев инвазивного пневмококкового заболевания.

В настоящее время проводятся испытания III фазы. Параллельно компания планирует исследовать 35-валентную вакцину пятого поколения для взрослых.

Исследование влияния антибиотиков

Раннее назначение антибиотиков повышает риск избыточного веса у детей

Ученые из Тель-Авивского университета выяснили, что назначение антибиотиков в первые два года жизни может быть связано с повышенным риском избыточного веса и ожирения в детстве и подростковом возрасте[5].



Более
70%
детей, участвовавших в исследовании нового метода лечения аллергии на арахис в виде пластыря VP250 VIASKIN Peanut, отреагировали на лечение

Анализ показал, что у детей, получавших антибиотики в первые два года жизни, средний процентиль индекса массы тела в детстве был выше и составил 57,8 по сравнению с 55,0 у детей из контрольной группы. В раннем подростковом возрасте этот показатель также оказался выше — 58,2 против 55,1. В позднем подростковом возрасте средний процентиль индекса массы тела составил 57,4 у подвергавшихся воздействию антибиотиков и 55,0 у остальных детей. Все различия были статистически значимыми.

Анализ показал наличие зависимости «доза-эффект» для антибиотиков узкого спектра действия: отношение шансов развития избыточного веса или ожирения увеличивалось с 1,15 при приеме одной-двух упаковок до 1,52 при приеме более 10 упаковок. Для препаратов широкого спектра действия такая взаимосвязь не подтвердилась.

Анализировали данные 76 840 детей, из которых 65 280 получали антибиотики в первые два года жизни, а 11 560 не подвергались такому воздействию. Антибиотики разделяли на препараты узкого и широкого спектра действия.

Опровергнуто влияние антибиотиков на развитие аутоиммунных заболеваний

Другое исследование, проведенное учеными из Университета Сонгюнгван в Корее, не выявило связи между применением антибиотиков во время беременности или раннего детства и риском аутоиммунных заболеваний у детей, в частности диабета 1-го типа, ювенильного артрита или воспалительных заболеваний кишечника[6].

Так, относительный риск (ОР) для диабета 1-го типа составил 1,14; для ювенильного артрита и язвенного колита — 1,02; для болезни Крона — 1,16. Для системной красной волчанки этот показатель составил 0,70; для тиреоидита Хашимото — 1,06.

Частота развития аутоиммунных заболеваний среди детей, получавших антибиотики в течение первых шести месяцев жизни, и тех, кто не подвергался такому воздействию, существенно не отличалась. Для диабета 1-го типа ОР составил 1,05; для ювенильного артрита — 1,11. Для язвенного колита этот показатель равнялся 0,95; для болезни Крона — 1,07; для системной красной волчанки — 1,46; для тиреоидита Хашимото — 1,14.

Анализировали данные более 4 млн детей. Для снижения влияния сопутствующих факторов применялись методы обратного взвешивания вероятности лечения и анализ соответствия братьев и сестер. В качестве исходов учитывали развитие аутоиммунных заболеваний в среднем за 7—12 лет наблюдения.

Профилактика кровотечения у новорожденных

Внутримышечное введение витамина К при рождении было связано с наиболее низким риском кровотечений у новорожденных в течение первых шести месяцев жизни, выяснили ученые из Каролинского института в Стокгольме[7]. Анализ показал, что у новорожденных, которым не вводили витамин К внутримышечно, риск любого кровотечения в течение первых шести месяцев жизни был выше на 52%, а риск внутричерепного кровоизлияния — почти в три раза по сравнению с детьми, получившими внутримышечную профилактику. В течение первых 28 дней жизни вероятность любого кровотечения была выше в 2,62 раза, а внутричерепного кровоизлияния — в 2,9 раза.

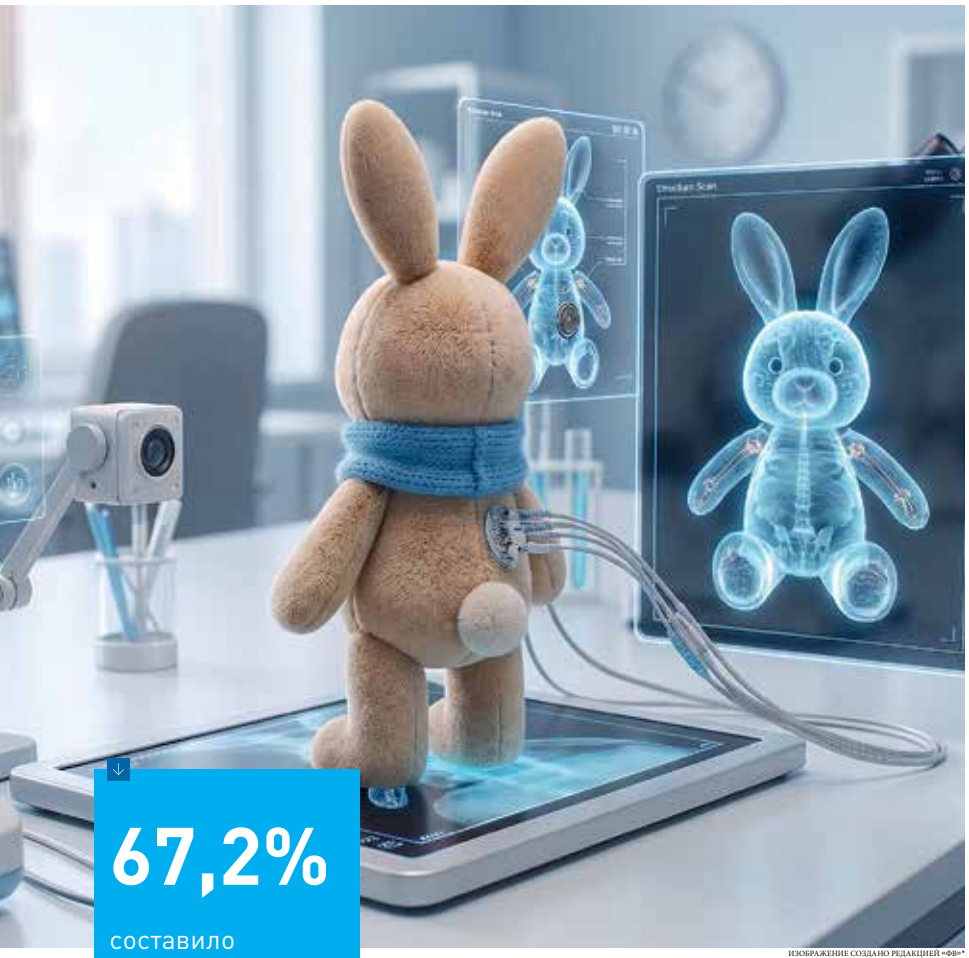
При этом пероральное применение витамина К не обеспечивало такой же защиты, как внутримышечное введение. У детей, получавших витамин К перорально, риск любого кровотечения в первые шесть месяцев жизни был выше в 2,26 раза по сравнению с детьми, которым препарат вводили внутримышечно.

Анализировали данные более 2 млн новорожденных, родившихся в Швеции на сроке беременности не менее 35 недель. Основным критерием оценки было развитие любого кровотечения в течение первых шести месяцев жизни, дополнительными — внутричерепное кровоизлияние в течение полугода и кровотечения в первые 28 дней после рождения.

Терапия редких заболеваний почек

В 2025 году FDA одобрило пэгцетакоплан, который ранее применялся для терапии пароксизмальной ночной гемоглобинурии, для лечения гломерулопатии С3 и первичного иммунокомплексного мембранопролиферативного гломерулонефрита. Из-за гиперактивации системы комплемента эти патологии приводят к отложению С3 в клубочках и необратимому повреждению почек.

Основанием для одобрения послужили результаты исследования VALIANT, в котором приняли →



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»*

67,2%

составило снижение протеинурии среди 124 участников исследования VALIANT, которые получали пэгцетакоплан

участие 124 пациента[8]. В течение первых шести месяцев относительное снижение протеинурии составило 67,2% среди участников, которые получали препарат. В группе плацебо протеинурия увеличилась на 2,9%. Кроме того, на фоне приема пэгцетакоплана отмечены стабилизация расчетной скорости клубочковой фильтрации и снижение соотношения белок/креатинин в моче. При этом частота нежелательных явлений в группе препарата и плацебо существенно не отличалась.

Гастроэнтерология и неотложная помощь

Назначение противорвотного препарата ондансетрон в течение 48 часов после выписки снижает риск повторного появления симптомов острого гастроэнтерита у детей на 50% и вероятность повторного обращения за медицинской помощью[9].

В исследовании, проведенном в педиатрических отделениях неотложной помощи в Канаде, приняли участие более 1 тыс. детей, выписанных с диагнозом «острый гастроэнтерит». Участники получали либо плацебо, либо до шести доз ондансетрона в течение первых 48 часов после выписки.

Новый подход к реабилитации после сотрясения мозга

Подход к лечению сотрясения мозга у детей существенно изменился за последние годы: от длительного строгого покоя перешли к ранней активизации, ориентированной на симптомы. Однако ранняя активизация не означает неограниченную активность.

Мультицентровое исследование с участием 239 детей опровергло пользу ранней чрезмерной активности после сотрясения мозга[10]. Детям, которым рекомендовали проходить до 10 тыс. шагов в день сразу после травмы, требовалось больше времени на восстановление (10 дней против пяти), чем тем, кто следовал симптом-ориентированному режиму.

Авторы подчеркнули, что детям следует постепенно возобновлять активность на уровне ниже порога, при котором симптомы появляются или усиливаются. Стандартизированные рекомендации по быстрому наращиванию нагрузки независимо от симптомов могут фактически продлить период восстановления.

Новые способы доставки лекарств: пластырь при аллергии

Новый метод лечения аллергии на арахис в виде пластыря, который накладывают между лопатками, показал положительные результаты после многолетнего исследования, сообщили ученые из Детской больницы Колорадо[11]. Пластырь VP250 VIASKIN Peanut от компании DBV Technologies содержит около 250 мкг белка арахиса (эквивалентно 1/1000 части арахиса).

В исследовании PEPITES участвовали 356 детей от 4 до 11 лет, которые ежедневно получали VP250 или плацебо в течение года. Во второй части исследования 87 пациентов получали VP250 еще 60 месяцев.

Уже после года лечения, в ходе которого в общей сложности использовалось всего 125 мг арахисового белка, почти три четверти пациентов смогли переносить от одного до пяти арахисовых орешков. По итогам 60-месячного исследования более 70% участвовавших в нем детей отреагировали на лечение. Авторы исследования отметили снижение уровня специфичного для арахиса IgE и повышение специфического IgG4, что соотносится с результатами других методов аллерген-специфической иммунотерапии.

Какие результаты только ожидаются

В 2026 году ученые начали проведение сразу нескольких исследований, посвященных лечению постковидного синдрома у детей[12].

Так, в ходе исследования RECOVER-TLC с участием 1,3 тыс. детей и молодых взрослых (от 6 до 25 лет) изучат эффективность налтрексона для лечения усталости — одного из самых распространенных симптомов постковидного синдрома. Параллельно проводятся испытания ларозитида (larazotide) и таурина при постковидном синдроме у детей. ФВ

---

[1] The future of paediatric clinical trials — setting research priorities for child health, BO3, Oct 28, 2025.
[2] Clesrovimab for Prevention of RSV Disease in Healthy Infants, N Engl J Med, Sep 17, 2025.
[3] Nirsevimab Against Hospitalizations and Emergency Department Visits for Lower Respiratory Tract Infection in Infants, JAMA Pediatr, Dec 22, 2025.
[4] Pfizer Advances Pivotal Pediatric Pneumococcal Vaccine Program Following Strong Positive Phase 2 Results, Press Release, May 20, 2026.
[5] The association between antibiotic use in infancy and overweight during childhood and adolescence: a historical cohort study, Int J Obes, Nov 29, 2025.
[6] Exposure to antibiotics during pregnancy or early infancy and the risk of autoimmune disease in children: A nationwide cohort study in Korea, PLOS Med, Aug 21, 2025.
[7] Vitamin K Prophylaxis in Newborns and Bleeding in Infancy, JAMA Pediatr, Jul 13, 2026.
[8] Trial of Pegcetacoplan in C3 Glomerulopathy and Immune-Complex MPGN, N Engl J Med, Dec 3, 2025.
[9] Multidose Ondansetron after Emergency Visits in Children with Gastroenteritis, N Engl J Med, Jul 16, 2025.
[10] After Concussion, More Activity Is Not Necessarily Better, Quomi, Aug 2026.
[11] Response to peanut patch treatment increases through 60 months, Healio, Mar 05, 2025.
[12] Long COVID affects millions of children. The largest pediatric trial so far launches this year, The Sick Times, Feb 3, 2026.

Что изменилось в клинических рекомендациях 2026 года

О РОЛИ ЭТИОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ В ТЕРАПИИ ОРВИ У ДЕТЕЙ

В новых клинических рекомендациях по лечению ОРВИ у детей список рекомендованных противовирусных препаратов (МНН) увеличен на две позиции и пересмотрен подход к применению различных противовирусных и иммуномодулирующих средств.



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»*

Обновленные клинические рекомендации «Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)» для возрастной категории «Дети» (разработаны Союзом педиатров России в сотрудничестве с Межрегиональной ассоциацией по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии и Российским обществом скорой медицинской помощи), утвержденные Минздравом России 4 сентября 2026 года, пришли на смену версии 2022 года.

Этиотропные препараты: список расширен, но остается коротким

В раздел этиотропной терапии (в добавление к осельтамивиру и занамивиру, которые действуют преимущественно на вирусы, содержащие нейраминидазы) впервые включены два МНН[1]:

- балоксавир марбоксил — избирательно действует на вирус гриппа;
- умифеновир — рекомендуется детям старше двух лет в первые 24—48 часов болезни как при гриппе, так и при ОРВИ другой этиологии, с целью снижения репликации вирусов.

В новых рекомендациях говорится, что при применении ингибиторов нейраминидазы при гриппе риск нежелательных явлений превышает потенциальную пользу при нетяжелом течении заболевания, а широкое применение препаратов формирует резистентность[2], поэтому применять осельтамивир и занамивир можно у пациентов групп риска с подозрением на грипп или пациентам при подтвержденном гриппе А и В с осторожностью, учитывая баланс между пользой и вредом.

Ключевая особенность: умифеновир — МНН, который возможно применять при ОРВИ различной этиологии, а не только при лабораторно подтвержденном гриппе[3]. В общем, список этиотропных средств с обоснованием «для широкого круга возбудителей ОРВИ» у детей остается коротким и предметным — это фактически одна позиция.

Фокус — на целесообразность

Медицинское сообщество делает акцент на противовирусные препараты, действующие непосредственно на вирусы с целью их уничтожения и/или прекращения размножения. И это обосновано, так как ОРВИ (простуда) — это вирусная инфекция.

Медицинское сообщество делает акцент на противовирусные препараты, действующие непосредственно на вирусы с целью их уничтожения.

В отношении различных противовирусных и иммуномодулирующих средств формулировка документа выглядит так:

«Различные препараты с противовирусным и иммуномодулирующим действием, получившие широкое распространение в РФ, не имеют достаточного объема доказательств эффективности и безопасности... Следует рассмотреть необходимость применения препаратов, исключив избыточность назначений, полипрагмазии и лекарственных взаимодействий, оценив ожидаемую пользу и риск нежелательных явлений. Необходимо соблюдать осторожность и не использовать их рутинно».

То есть говорится о необходимости обоснования каждого назначения — с прямой оговоркой об ограниченности доказательной базы и об отказе от рутинного применения.

В то же время в отношении умифеновира говорится, что рекомендуется его селективное назначение в первые 24—48 часов болезни пациентам старше двух лет с гриппом или ОРВИ другой этиологии, в т.ч. неопределенной этиологии ОРВИ.

Включение умифеновира в клинические рекомендации позволяет первостольнику информировать о нем покупателей с запросом на средство «от простуды»[4]. Умифеновир имеет благоприятный профиль безопасности.

[1] Клинические рекомендации «Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)» для возрастной группы «Дети», 2026.
[2] Jefferson T, Jones MA, Doshi P, Del Mar CB, Hama R, Thompson MJ, Spencer EA, Onakpoya I, Mahtani KR, Nunan D, Howick J, Heneghan CJ. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in adults and children. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Apr 10;2014(4):CD008965 / Джефферсон Т., Джонс М. А., Доши П., Дел Мар К. Б., Хама Р., Томпсон М. Дж., Спенсер Е. А., Онакпоя И., Махтани К. Р., Нунан Д., Хоуик Дж., Хенеган К. Дж. Ингибиторы нейраминидазы для профилактики и лечения гриппа у взрослых и детей. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Apr 10;2014(4):CD008965.
[3] Инструкция ЛП-№(005105)-(РГ-RU).
[4] Инструкция ЛП-№(007642)-(РГ-RU).

РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЭКСПЕРТ

ПАТЕНТНАЯ НЕРАЗБЕРИХА: КОМУ ВЫГОДНО?



ДМИТРИЙ КРАВЧЕНКО,
ведущий эксперт Комитета по инновационной фармацевтике Ассоциации «Национальные чемпионы» (экосистема иннопрактики)

Интеллектуальная собственность — фундамент инновационной фармацевтики. Без патентной охраны никто не будет вкладывать миллиарды в разработку новых биологически активных молекул. Однако патенты — это еще и инструмент баланса между интересами разработчика и общества. В России этот баланс оказался под угрозой, и во многом из-за того, что патентное регулирование находится в руках двух структур: национального Роспатента и наднационального Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ). У процесса два регулятора, их подходы не синхронизированы, а требования зачастую противоречат друг другу. Именно эта правовая неразбериха создает зону, где процветают злоупотребления, блокируется конкуренция и страдают пациенты. Ситуацию усугубляет внешнее давление.

5 лет

— максимальный срок продления российского патента на лекарства

Борьба на патентном поле в последнее время серьезно обострилась, в том числе на межгосударственном уровне. Европа перестала выдавать патенты на российские изобретения, ввела санкции против наших инноваций.

В этих условиях особенно важно, чтобы механизмы патентования изобретений, охраняемых на территории России, работали на Россию, а не против нее. Однако мы наблюдаем обратное.

В практике патентования изобретений сложились две ключевые зоны риска, требующие безотлагательного анализа. Первая касается порядка продления патентов, вторая зона — это Евразийский фармацевтический реестр, придание которому официального правового статуса на территории России сопряжено с административными и правовыми коллизиями.

Цена этого вопроса — не только деньги, в том числе наполнение или опустошение государственного бюджета, но также жизни людей и лекарственный суверенитет нашей страны — ее способность самостоятельно производить современные лекарства, а не быть вечным рынком сбыта для чужих разработок.

ПРОБЛЕМА 1.

Расхождение в требованиях к формуле изобретения при продлении патентов (ЕАПВ vs РФ)

Как российское, так и евразийское законодательство позволяет продлить на срок до пяти лет патент на изобретение, относящееся к лекарственному средству.

При этом мы четко понимаем: «корневые» патенты на действующие вещества нарушать нельзя — это основа инновационного развития. Тем не менее продление сроков действия патентов должно осуществляться строго по национальным правилам Российской Федерации, а не по правилам наднациональных структур, которые не учитывают интересы российских разработчиков.

Однако Евразийское патентное ведомство, в отличие от Роспатента, выдает свидетельство о продлении срока действия патента без указания формулы изобретения, в отношении которого продлевается срок охраны. Вместо этого ЕАПВ просто перечисляет пункты формулы изобретения исходного патента, и зачастую эти пункты охраняют не только изобретения, используемые в лекарственном препарате, но и другие, альтернативные разработки.

Однако формула изобретения — единственное, что определяет объем его правовой охраны. Без нее госзаказчик не понимает, в отношении какого именно изобретения продлен срок действия исключительного права. В лучшем случае он парализован страхом, в худшем — ошибочно блокирует закупки дженериков, не разбираясь,

использовано ли в них охраняемое патентом изобретение или нет.

Это не техническая оплошность, а прямое противоречие требованиям ст.1363 Гражданского кодекса РФ.

И наличие этой коллизии не является тайной. Представители ЕАПВ публично признают несоответствие их процедуры продления требованиям российского законодательства. Но вместо устранения пробела они ссылаются на сложность внесения изменений в свои регламенты.

Свидетельство о продлении патента удостоверяет факт продления срока охраны изобретения, и этот документ не может быть неполным. Пока мы миримся с этой практикой, мы соглашаемся на правовую неопределенность на ключевом участке регулирования фармацевтического рынка.

Важно понимать: сохранение этой практики — не просто техническая неточность или недоработка. Зарубежные фармацевтические компании, на долю которых приходится подавляющее большинство евразийских патентов, прямо заинтересованы в том, чтобы объем правовой охраны оставался «размытым». Чем

СТРАНЫ БРИКС — КИТАЙ, ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ — УЖЕ АДАПТИРОВАЛИ ПАТЕНТНЫЕ ПРАВИЛА ПОД СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ. ОНИ НЕ БОЯТСЯ ЗАЩИЩАТЬ СВОЙ РЫНОК ОТ ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ ПРОТИВ НИХ.

меньше ясности, тем больше возможностей для блокировки вывода на рынок конкурентов. Именно поэтому любые попытки навести порядок в этой сфере наталкиваются на глухое сопротивление.

ПРОБЛЕМА 2.
Правовой статус Евразийского фармацевтического реестра

Евразийский фармацевтический реестр начал свою работу 1 марта 2021 года. У этого реестра три системных порока, которые делают его не просто бесполезным, а вредным для России.

Порок первый — отсутствие легитимного статуса. Фармреестр не предусмотрен Евразийской патентной конвенцией. Он создан и функционирует на основании внутреннего решения Административного совета ЕАПО, которое не является международным договором, ратифицированным Российской Федерацией.

Порок второй — внесение сведений в реестр без проверки. Евразийское патентное ведомство включает в фармреестр сведения по заявлению патентообладателя. При этом проводится единственная экспертиза — проверка соответствия международного непатентованного наименования охраняемому патентом фармакологически активному веществу. Никто не проверяет, действительно ли изобретение реализовано в лекарственном препарате с этим МНН. Ответственность за недостоверность таких сведений отсутствует.

Порок третий — включение в фармреестр любых вторичных патентов. В реестр попадают не только патенты на действующее вещество, но и на композиции, способы получения, медицинские применения. Это создает иллюзию «патентной стены», которая на поверку часто не имеет отношения к возможности производства более дешевого аналога.

Арбитражные суды уже неоднократно указывали: сам по себе факт нахождения патента в фармреестре не доказывает его использование в конкретном препарате. То есть реестр есть, а доказательной силы — ноль.

Кому это выгодно? И почему это продвигается?

Вот главный вопрос: кому это выгодно?

И ответ очевиден: только исключительно зарубежным компаниям. Как показывают исследования, иностранные компании доминируют в структуре патентов ЕАПВ. Именно они — главные бенефициары и «размытой» формы продления срока действия патента, и фармреестра, что позволяет им неправомерно удерживать монополию на рынке.

Фармреестр — это инструмент для запугивания госзаказчиков и блокировки вывода на рынок российских аналогов. Его легализация напрямую противоречит задачам технологического суверенитета России. И ровно так же работает продление срока действия исключительного права на изобретения без четко установленных границ изобретения, определяемых совокупностью признаков его формулы: неопределенность выгодна тем, кто хочет сохранить монополию, а не тем, кто хочет развивать конкуренцию.

И здесь мы подходим к тревожному факту. Если реестр вреден для России, если он выгоден только иностранным компаниям, то почему так настойчиво продвигается его легализация? В том числе усилиями Минэкономразвития России, что само по себе выглядит странно, ведь это ведомство должно защищать в первую очередь национальные интересы.

Мы видим систематические попытки на государственном уровне продавить решения, выгодные иностранному бизнесу. Отдельные игроки, прикрываясь «интересами инноваций», лоббируют правила, которые блокируют российскую фарму и открывают рынок для зарубежных монополистов.

Придание фармреестру статуса официального источника сведений о патентной защите МНН сделает недееспособной государственную программу «продукт на полку». Регистрация любого дженерика в России будет отложена до истечения срока действия всех сомнительных вторичных патентов. Вместо

→

«скорой помощи» для рынка мы получим еще один барьер.

Сегодня вопрос стоит ребром: либо мы осознаем, что за продвижением фармреестра и сохранением порочной практики продления стоят силы, заинтересованные в зависимости России от импортных лекарств, либо мы продолжаем делать вид, что это «просто технические вопросы». Но технических вопросов, которые подрывают суверенитет страны, не бывает.

Принудительные лицензии — пример работающего баланса

Механизм принудительного лицензирования, предусмотренный ст.1362 ГК РФ, — это российский инструмент защиты общественных интересов, основанный на судебных процедурах. За 2022—2026 годы суды рассмотрели более 40 таких дел.

Статья предусматривает два основания.

Первое — недостаточное использование изобретения в течение четырех лет с даты выдачи патента. Конституционный суд РФ в своем Постановлении № 13-П от 12 марта 2026 года разъяснил условия выдачи принудительных лицензий на изобретения, реализованные в лекарственных препаратах. Суд установил, что такая исключительная мера допустима при неиспользовании или недостаточном использовании изобретения по патенту. Такое неиспользование может выражаться в дефиците лекарства, вызванном неучастием производителя оригинального лекарственного препарата в объявленном аукционе.

Второе — наличие патента на зависимое изобретение (п.2 ст.1362 ГК РФ). Однако в этом случае закон использует только оценочные категории — «важное техническое достижение» и «существенные экономические преимущества», устойчивая судебная практика по их толкованию отсутствует. Что считать «важным»? Что значит «существенное»?

Кто мог бы избавить нас от этой правовой неопределенности? Очевидно, что ключевой экспертизой обладают специалисты Роспатента и ЕАПВ. Выходит, сам факт выдачи зависимого патента уже является признанием его «важным техническим достижением». А «существенное экономическое преимущество»? Понятие вполне предметное: при регистрации цены на первый дженерик она всегда становится ниже как минимум на 40%.

КАК ПОКАЗЫВАЮТ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ ДОМИНИРУЮТ В СТРУКТУРЕ ПАТЕНТОВ ЕАПВ. ИМЕННО ОНИ — ГЛАВНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ И «РАЗМЫТОЙ» ФОРМЫ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА, И ФАРМРЕЕСТРА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИМ НЕПРАВОМЕРНО УДЕРЖИВАТЬ МОНОПОЛИЮ НА РЫНКЕ.

Условия выдачи принудительной лицензии определяет суд. Но механизм станет по-настоящему рабочим только тогда, когда будет сформировано единообразное понимание всех критериев, ведущих к его получению.

Полезные для безопасности страны инструменты нужно развивать, а не подменять наднациональными реестрами и внесудебными процедурами.

Что делать? Три шага для защиты суверенитета

Ситуация требует принципиальных решений.

Первое. Завершить реформу продления срока действия патента на изобретение: обязать ЕАПВ включать в свидетельство о продлении полную формулу изобретения. Это прямое требование ст.1363 ГК РФ, и оно должно исполняться.

Второе. Признать, что легализация фармреестра противоречит интересам технологического суверенитета РФ. Только судебное обсуждение каждого отдельного патента и случая в состязательном формате приведет к принятию законного, честного и сбалансированного решения. При этом «вторичные» патенты не должны блокировать коммерческую реализацию после истечения срока действия основного патента, такие дела также должны разбираться в суде.

Третье. Правило «лекарство на рынке»: если в течение четырех лет с даты выдачи патента лекарственный препарат, охраняемый таким патентом, не был зарегистрирован и введен в обращение в РФ, исключительные права по такому патенту не подлежат защите, а патент должен передаваться в общественное достояние.

Страны БРИКС — Китай, Индия, Бразилия — уже адаптировали патентные правила под свои национальные интересы. Они не боятся защищать свой рынок от инструментов, которые работают против них.

Мы имеем полное право и обязаны сделать то же самое. Порочная практика продления патентов без приложения формулы изобретения и легализация Евразийского фармацевтического реестра не имеет отношения к инновациям и направлена исключительно на сохранение зависимости от иностранных производителей. ФВ

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ СУД. НО МЕХАНИЗМ СТАНЕТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ РАБОЧИМ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА БУДЕТ СФОРМИРОВАНО ЕДИНООБРАЗНОЕ ПОНИМАНИЕ ВСЕХ КРИТЕРИЕВ, ВЕДУЩИХ К ЕГО ПОЛУЧЕНИЮ.

Более 40

дел по принудительному лицензированию рассмотрели суды за 2022—2026 годы

Как работает стартап, где основной сотрудник — искусственный интеллект

КОДОВОЕ СЛОВО



ТЕКСТ: Екатерина Погонцева

Сотни файлов, несколько языков, требования разных регуляторов и дедлайн подачи регистрационного досье — все это сопровождает любой лонч лекарственного средства. В этой ситуации искусственный интеллект может взять на себя рутинные операции и значительно ускорить работу. Речь не о замене регуляторного специалиста, а о том, чтобы освободить его от механической работы. «ФВ» разобрался, готова ли отрасль делегировать полномочия ИИ.

85%

достигает точность автоматической классификации данных в системе «ФарМозг»

Найти нишу

Разработчиков ИИ-решений для R&D в мире множество, а компаний, инвестирующих в разработку лекарств, на отечественном рынке единицы. В поисках уникального предложения партнеры **Константин Кошечкин** и **Руслан Калашников** предлагали ИИ для решения задач системы обеспечения качества. Но выяснилось, что индустрии гораздо нужнее помощь при проверке документов в составе регистрационного досье: комплектности, содержания, формулировок и соответствия законодательству. Поэтому стартап «ФарМозг» решил сфокусироваться на менее конкурентной нише — регуляторном контуре и работе с регистрационным досье.

Система помогает загружать документы, извлекать из них метаданные, классифицировать по разделам CTD[1], формировать структуру досье, проверять комплектность и соответствие регуляторным требованиям, а также готовить eCTD-пакет[2]. Точность автоматической классификации достигает 85%, но экономический эффект оцифровать сложнее. По оценкам бизнес-партнеров, если специалист раньше тратил часы на просмотр и распределение сотен документов, то ИИ превращает значительную часть этой работы в задачу на минуты.

Константин КОШЕЧКИН: «Мы не заменяем специалиста по регуляторным вопросам — мы освобождаем его от перетаскивания файла из папки А в папку Б. Если процесс можно автоматизировать, рано или поздно кто-нибудь обязательно автоматизирует его в Excel. Мы же предлагаем сделать это чуть умнее».

Фармкомпании работают в разных юрисдикциях, поэтому им приходится переводить собственную документацию и документы иностранных поставщиков. Отраслевых переводчиков немного, особенно переводчиков с китайского языка, поэтому ИИ может быть востребован и здесь.

Сейчас у «ФарМозга» идет несколько пилотных проектов и предварительных переговоров о продаже по разным тематикам: от контроля качества регистрационного досье до машинного перевода фармацевтической документации.



Константин КОШЕЧКИН — доктор фармацевтических наук, в прошлом сотрудник Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России. Он занимался разработкой IT-систем, связанных с регистрацией лекарственных средств, и руководит IT-направлением в лабораторном центре Оксфордского университета, который разрабатывает онковакцины с использованием технологий ИИ.



Руслан КАЛАШНИКОВ — практикующий эксперт в области внедрения компьютеризированных систем. Бизнес-партнеры преподают в рамках программы переподготовки Евразийской академии надлежащих практик и в магистратуре Сеченовского университета — ведут проектную деятельность и курс по ИИ в фармацевтике.

→



10 тыс. руб.

в месяц составляют инфраструктурные затраты стартапа — это аренда виртуальных машин «Яндекса»

Как все устроено внутри

Компания «ФарМозг» была зарегистрирована в ноябре 2025 года. Константин Кошечкин и Руслан Калашников — единственные штатные сотрудники стартапа. Чтобы со временем не заменять сотрудников ИИ-агентами, бизнес-партнеры сразу сделали ставку на «беспилотную» организацию.

«Идеальная ситуация — когда нас так и останется двое, потому что всю основную разработку и тестирование мы ведем с помощью ИИ. Фактически разработчик сегодня превращается в оператора, который руководит комплексом ИИ-агентов. Так что в штате требуется все меньше людей», — говорит Руслан Калашников.

Преподавательская деятельность дает возможность находить талантливую молодежь, обучать ее и привлекать к проектам. Это выгодно и стартапу, и студентам: первые получают дополнительный ресурс, вторые — практический опыт и материал для научной работы.

Стартапу не нужен не только большой штат сотрудников, но и офис с сопутствующими операционными расходами. Инфраструктурные затраты составляют 10 тыс. руб. в месяц — это аренда виртуальных машин «Яндекса». Для разработки ИИ-решений этого достаточно, уверяют основатели компании.

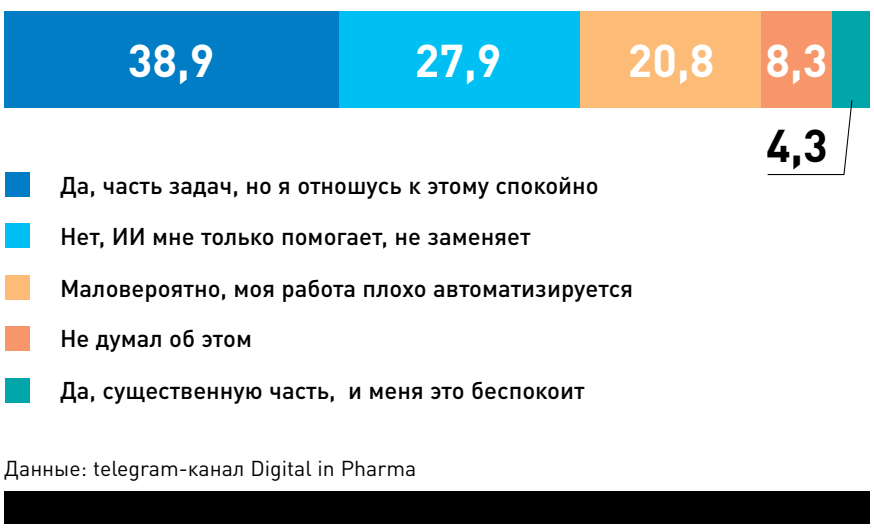
Фармкомпании хотят работать в закрытом контуре, поэтому после приобретения софта заказчики сами обеспечивают необходимую вычислительную инфраструктуру.

«На этапе разработки модели работают по API, поэтому плата за трафик минимальна. Есть небольшие организационные расходы. Все остальное — это код», — объясняет Руслан Калашников.

Стартап практикует две модели оплаты: продажу готового ПО, при которой заказчик получает лицензию и техподдержку, или выполнение проекта заказной разработки. Разработчик договорился об интеграции с ведущими вендорами корпоративных систем документооборота, что позволяет бесшовно встроить ИИ в привычный интерфейс пользователей фармкомпаний.

ЗАМЕНИТ ЛИ ИИ ФАРМСПЕЦИАЛИСТОВ

ВОПРОС: «СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ИИ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ЧАСТЬ ВАШИХ ЗАДАЧ В БЛИЖАЙШИЕ ДВА-ТРИ ГОДА?»



Данные: telegram-канал Digital in Pharma



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»

Стартап развивается на собственные средства основателей. У них есть другие рентабельные проекты, которые позволяют зарабатывать, инвестировать в развитие бизнеса и содержать семьи. На самоокупаемость «ФарМозг» пока не вышел, потому что рынок ИИ только формируется.

Что тормозит и стимулирует ИИ-рынок

Есть три основных сдерживающих фактора. Самый неожиданный из них — скорость развития самих моделей, говорит Константин Кошечкин. «Мы можем потратить полгода на согласование ТЗ и интеграцию одной модели, а через три месяца появляется новая, которая делает то же самое лучше и дешевле. Поэтому я считаю ошибкой строить фармацевтическую ИИ-систему вокруг одной конкретной LLM. Модель должна быть сменным компонентом, а не фундаментом всей архитектуры», — уточняет эксперт.

По его мнению, не каждая задача требует отправки данных во внешнюю LLM. Иногда для классификации документа достаточно небольшой локальной модели. Большую модель можно использовать только там, где действительно требуется сложное рассуждение — reasoning.

«Мой подход: не нужен Ferrari, чтобы ездить за хлебом. Если задачу прекрасно решает локальная модель на 14 млрд параметров, зачем отправлять конфиденциальный документ в огромную внешнюю модель?» — задает риторический вопрос сооснователь стартапа.

Второй фактор — регуляторика, которая традиционно не поспевает за технологиями. Фарма — очень зарегулированная и специфическая отрасль, констатирует эксперт. В обычном бизнесе, если ИИ ошибся в письме клиенту, это неприятно. В фарме цена ошибки может быть совершенно другой.

«Поэтому нам недостаточно сказать: «Модель показала точность 95%». Нужно понимать, где именно она ошиблась, почему она ошиблась и можно ли доказать, что результат был получен корректно», — конкретизирует Константин Кошечкин.

Преимущество «ФарМозга» Константин Кошечкин видит не столько в самой модели ИИ, сколько в предметной логике вокруг нее. Стартап продает не еще один чат с LLM, а ИИ-инфраструктуру для конкретного фармацевтического процесса.

Третий сдерживающий фактор — доверие. Есть руководители фармкомпаний, которые готовы пробовать новое, а есть те, кто предпочитает подождать. Все зависит от конкретного человека, принимающего решения, резюмирует Руслан Калашников. В том числе поэтому партнеры тратят много сил на просветительскую и образовательную деятельность — чтобы повысить осведомленность участников рынка.

Основной драйвер, по его словам, — мощная поддержка ИИ со стороны руководства страны. По крайней мере морально это стимулирует. ФВ

[1] CTD (от англ. Common Technical Document — общий технический документ) — стандартизированная структура регистрационного досье лекарственного препарата, используемая при его регистрации.
[2] eCTD-пакет (electronic Common Technical Document) — электронный формат подготовки и подачи регистрационного досье на лекарственные средства в регуляторные органы; цифровой аналог бумажного CTD.

Согласно прогнозу компании-разработчика DDi, по мере того как фармацевтические и биотехнологические компании внедряют цифровые технологии, ИИ в регуляторной сфере может эволюционировать от автоматизации отдельных задач к поддержке стратегических решений. DDi, в частности, описывает такие потенциальные направления развития: автоматическую классификацию и маркировку документов, извлечение метаданных, проверку формата и соответствия требованиям перед подачей, а также мониторинг регуляторных изменений.

- ИИ как помощник регуляторного специалиста. Системы могут помогать при подготовке заявок, выдавая рекомендации в режиме реального времени.
- Самообновляющиеся системы контроля соответствия. Платформы могут отслеживать изменения регуляторных требований в разных юрисдикциях и предупреждать команды о новых правилах.
- Голосовые помощники по регуляторным вопросам. Боты могут создавать отчеты и отвечать на типовые запросы голосом.
- ИИ в пострегистрационном надзоре. Системы могут автоматизировать мониторинг нежелательных явлений и регуляторных сигналов в разных странах.

Как закон о платформенной экономике изменит онлайн-торговлю в фарме

НОВАЯ ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ТЕКСТ: Таисия Кубрина

С 1 октября вступает в силу новый закон о платформенной экономике. Он устанавливает правовые рамки взаимодействия маркетплейсов, продавцов, потребителей и сопутствующей инфраструктуры. Фармотрасль ожидает, что новые правила создадут правовые барьеры для контрафакта и товаров, маскирующихся под фармацевтические. «ФВ» разобрался, какие барьеры появятся для нелегальных продавцов и какие обязанности лягут на плечи онлайн-витрин.

С чистого листа

Активное развитие электронной коммерции потребовало установить понятные правила для ее участников. С 1 октября вступает в силу Федеральный закон № 289-ФЗ от 31.07.2025 «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации».

Ключевая задача новелл — создать защищенную экосистему, в которую входят цифровые платформы, их владельцы, продавцы, покупатели и необходимая им инфраструктура.

Оптимистичные ожидания бизнеса связаны в первую очередь с потребностью минимизировать онлайн-поток «серых» товаров, в том числе БАД и пищевых добавок под видом лекарств. Платформы также должны обеспечивать единые, недискриминационные условия доступа для партнеров и владельцев пунктов выдачи.

В правовой контур нового закона не попали онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы, онлайн-сервисы банков и некредитных организаций, электронные площадки для госзакупок, частные интернет-магазины, сайты госорганов и муниципалитетов для предоставления услуг и ряд других платформ.

Посреднические цифровые платформы

Маркетплейс, который сводит аптеку или дистрибьютора с покупателем, получает статус «посреднической цифровой платформы». Закон устанавливает для нее обязательные и дополнительные критерии. Для получения этого статуса платформа должна:

- обеспечивать цифровое взаимодействие оператора, партнеров и пользователей с целью заключения сделок (рис.);
- предоставлять технические возможности для размещения карточек товаров, заказов и проведения оплаты;
- быть включена в специальный реестр.

Дополнительно она должна обеспечивать ежегодный поток более 100 тыс. пользователей, как минимум 10 тыс. из которых закрыли какую-либо сделку или совокупно потратили более 50 млрд руб. на ней[1].

Запреты и ограничения

Закон запрещает платформам создавать дискриминационные условия для продавцов одной категории и гарантирует свободный доступ пользователей к правилам сервиса.

Владельцы платформ должны пресекать их использование для совершения уголовных преступлений, размещения запрещенного контента, разглашения государственной тайны и иных конфиденциальных сведений. Контент не должен дискриминировать людей по личностным признакам, ущемлять их честь и достоинство, а также причинять вред деловой репутации участников оборота.

Владельцы платформ также обязаны обеспечивать кибербезопасность и защищать персональные данные от утечек.

За нарушение этих правил с 1 октября для маркетплейсов вводятся штрафы (ст.14.69 КоАП РФ): от 20 тыс. руб. (за отсутствие технической возможности размещения сведений о партнере) до 500 тыс. руб. (за игнорирование жалоб партнеров)[2].

Проверка партнеров

Закон впервые урегулировал договорные отношения между операторами и партнерами или владельцами пунктов выдачи заказов. Перечень сведений, которые оператор должен проверить до заключения договора, представлен в таблице.

Заявитель может направить оператору сведения для проверки несколькими способами: направить электронное заявление, подписанное УКЭП, а для граждан — простой электронной подписью; внести идентификационный платеж с последующим возвратом; пройти идентификацию в личном

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМАХ



Источник: составлено «ФВ» по ФЗ-289

Рис.

ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»*

Перечень сведений, которые оператор должен проверить до заключения договора

Российские организации	Российские предприниматели	Филиалы / представительства иностранных организаций	Иностранные организации
Полное и сокращенное наименование	ФИО	Полное и сокращенное наименование	Полное и сокращенное наименование
Юридический адрес	—	Адрес нахождения в РФ	—
ИНН	ИНН + справка самозанятого (при наличии)	ИНН	ИНН или аналог в стране регистрации
ОГРН	ОГРНИП	—	Регистрационный номер в стране регистрации
Код причины постановки на учет	—	Код причины постановки на учет	—

Источник: составлено «ФВ» по Постановлению Правительства РФ № 768 от 20.06.2026

Таблица

кабинете через авторизованные сервисы, например портал госуслуг.

Закон также определяет перечень обязательных условий, которые должен содержать договор с партнером или владельцем пункта выдачи. Он должен храниться в личном кабинете не менее трех лет.

Вводится обязательный порядок урегулирования споров. Продавец сначала обязан подать жалобу через встроенную систему платформы и, только получив отказ, может идти в суд.

Скидки, услуги

Закон регулирует порядок предоставления маркетплейсами услуг и установления скидок на продукцию и услуги партнеров.

Операторы маркетплейсов вправе на недискриминационной основе предоставлять партнерам услуги по приоритетной поисковой выдаче. Если пользователь установил фильтры (критерии сортировки), то поисковая выдача должна проводиться в рамках заданных фильтров.

Площадки больше не смогут проводить промоакции за счет поставщика. Снизить цену товара или услуги можно только с согласия партнера и при условии его уведомления за пять рабочих дней до начала акции. Партнер также может отозвать согласие в любое время или установить запрет на предоставление скидок.

Отдельное согласие не требуется, если партнер в личном кабинете установит минимальную цену на свои товары, срок действия предложения и количество товаров. Маркетплейс в любом случае не вправе снизить цену ниже минимальной.

Отказ от скидок не может использоваться для дискриминации партнера, ограничения его доступа к системе, снижения рейтинга, прекращения размещения карточки или изменения порядка ее выдачи.

Любые изменения договора, ведущие к увеличению вознаграждения оператора, должны анонсироваться минимум за 45 дней.

За нарушение условий предоставления скидок оператору также грозит штраф до 300 тыс. руб., а за нарушение запрета на скидки — до 400 тыс. руб. Минэкономразвития РФ в середине сентября предложило учитывать все скидки, как за счет партнеров, так и за счет маркетплейсов.

Карточки товаров

Отдельное внимание закон уделяет порядку оформления карточек товаров. Оператор обязан указать в карточке товара, что сама площадка не является продавцом.

В карточке товара должна указываться обязательная для потребителей информация:

- о партнере, включая данные о лицензиях, сертификатах и прочих разрешениях на ведение партнером торговой деятельности;
- о товаре, работе, услугах;
- о наличии обязательной маркировки товаров, регистрации продавца в системах маркировки товаров или МДЛП и передаче сведений в них при продаже;
- ссылка на реестр деклараций и сертификатов соответствия, где размещены соответствующие документы на товары;
- ссылка на единый реестр свидетельств о государственной регистрации, где содержится СГР на товары;
- о возможности использования специальных электронных сертификатов для оплаты товаров, например средств реабилитации.

Маркетплейс должен проводить обязательную премодерацию карточек. Нельзя размещать карточки с информацией о продаже:

- изъятых товаров;
- незарегистрированных пестицидов и агрохимикатов;
- незарегистрированных лекарств и медизделий;
- товаров без подтверждения их соответствия требованиям техрегламентов (без ссылки на реестр деклараций и сертификатов);
- товаров без обязательной маркировки (если она требуется) или без регистрации партнера в системе «Честный знак».

Если БАД или аптечную косметику продает зарубежный партнер, платформа обязана предупредить об этом покупателя и разъяснить специфику такой покупки.

Премодерацию карточки маркетплейс должен провести в течение трех рабочих дней с момента внесения всех данных или изменения карточки. Повторная модерация и актуализация сведений на карточке должна проводиться каждые 10 рабочих дней. Все правила осуществления проверки карточек закреплены Постановлением Правительства РФ № 821 от 02.07.2026.

Маркетплейс может скрыть карточку товара или заблокировать личный кабинет продавца для соблюдения требований законодательства, выполнения решения суда или госоргана, а также в соответствии с условиями договора между ним и партнером (пунктом выдачи заказов). Заявление на блокировку карточки могут подать правообладатели товарных знаков, патентов и других объектов интеллектуальной собственности в случае нарушения их прав. ФВ

От 20 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

составят штрафы для маркетплейсов за нарушение правил, которые вступают в силу с 1 октября, согласно ФЗ № 289 от 31.07.2025

[1] Постановление Правительства РФ № 54 от 28.01.2026.
[2] Федеральный закон № 295-ФЗ от 04.08.2026.

Почему будущее фармрынка — за самовывозом, а не за доставкой

ЦИФРОВАЯ АПТЕКА-2030

ТЕКСТ: Алексей Петров, Илья Народицкий

Аналитический отчет «Цифровая аптека-2030»* компании «АльфаРМ» описывает парадоксальную картину российского фармацевтического e-com. Вопреки расхожему мнению, что онлайн-торговля неизбежно ведет к доминированию курьерской доставки, рынок демонстрирует уникальную модель: интернет становится главным инструментом поиска и выбора, но физический отпуск препарата по-прежнему остается в аптеке. Главная интрига до 2030 года — сможет ли электронный рецепт стать межрегиональным и превратится ли это в основу для контролируемого маршрута покупки рецептурных препаратов.

Рынок сегодня: деньги растут быстрее упаковок

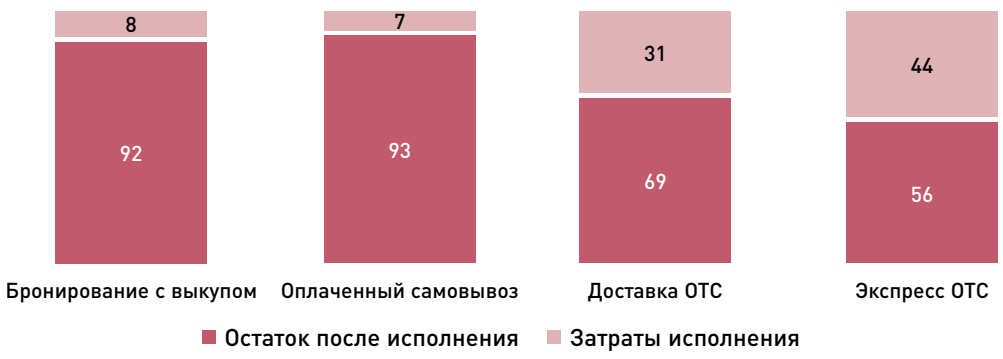
Ключевой тренд 2025—2026 годов для аптечного канала e-com лекарственного рынка — разрыв между денежной и натуральной динамикой. В первом полугодии 2026 года онлайн-продажи лекарств выросли на 20% в рублях, но лишь на 2% в упаковках. При этом средняя цена онлайн-заказа (666 руб.) значительно выше офлайн-чека (391 руб.). Это означает, что цифровой канал перетягивает на себя не столько массовый спрос, сколько дорогие покупки: хроническую терапию, редкие препараты и сложные дозировки. Яркий пример — категория для лечения диабета и ожирения, где онлайн-продажи выросли на 133 и 104% соответственно. Покупатель идет в интернет не за экономией на упаковке, а за возможностью найти нужный препарат и сравнить цены в условиях ограниченного наличия.

Самовывоз как экономический фундамент

Центральный вывод отчета: **самовывоз останется основой рынка до 2030 года**. Это не временное явление, а устойчивая экономическая модель. Бронирование без предоплаты создает риски невыкупа, но предоплаченный самовывоз (оплата онлайн, получение в аптеке) становится золотым стандартом. Он сочетает низкую стоимость исполнения для аптеки, управляемость остатков и удобство для покупателя.

Экспресс-доставка, напротив, остается дорогой нишей. Ее экономика требует либо высокой платы, либо крупной корзины, что в условиях низкого среднего чека на безрецептурные препараты (OTC) делает ее малорентабельной. В регионах, где плотность заказов ниже, доставка проигрывает ближайшей аптеке практически всегда.

ЗАТРАТЫ НА ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЗАКАЗОВ ЛС В КАНАЛЕ E-COM, УСЛ. ЕД.



Сравнительная экономика исполнения: индекс выручки заказа = 100
Экспертная модель отчета на основе структуры операций самовывоза и доставки. Не является отраслевой бухгалтерской статистикой.
Единицы: условные единицы; экспертная модель
Источник: «АльфаРМ»

Регуляторный тупик и прорыв

Самый острый вопрос — возможная легализация дистанционной продажи рецептурных препаратов (Rx). Эксперимент 2023—2026 годов в Москве, Подмосковье и Белгородской области провалился: всего 9,7 тыс. заказов за три года. Причина — узкий перечень препаратов, сложная идентификация и отсутствие инфраструктуры электронного рецепта.

Новый проект Минздрава РФ, предложенный в июле 2026 года, меняет подход. Вместо доставки Rx он фокусируется **на межрегиональном электронном рецепте**. Пилот (декабрь 2026 — ноябрь 2027) должен связать региональные системы, федеральный контур и систему маркировки. Если рецепт, выписанный в одном регионе, можно будет погасить в другом, это откроет путь к единому маршруту обслуживания пациентов для федеральных сетей. Однако даже успешный пилот не гарантирует разрешение массовой доставки Rx-препаратов — для этого потребуется отдельный постоянный режим. Это, кстати, еще один фактор, который цементирует перспективу самовывоза со всеми плюсами и минусами для товаропроводящей цепочки.

Консолидация розницы: победа федеральных сетей как процесс

Цифровизация ускоряет консолидацию аптечного рынка. В первом полугодии 2026 года федеральные сети показали рост выручки на 11%, тогда как все остальные типы аптек (региональные, локальные, одиночные) потеряли от 3 до 14%. Доля федеральных сетей достигла 68,9% и, по прогнозам, вырастет до 77—79% к 2030 году.

Причины очевидны: цифровой заказ требует IT-платформы, интеграции остатков и логистики, что окупается только на масштабе. Малые сети и одиночные аптеки либо становятся точками выдачи для агрегаторов, либо уходят с рынка. Для производителей это означает рост стоимости доступа к полке: маркетинговые платежи и конкуренция с собственными торговыми марками сетей становятся ключевыми вызовами.

Прогноз: три сценария до 2030 года

Отчет предлагает три сценария развития рынка:

1. Консервативный. Электронный рецепт не масштабируется, доставка Rx отсутствует. Объем e-com канала достигнет 870—990 млрд руб. за счет роста чека (частота заказов, рост цен, рост корзины).

2. Базовый (55%). Межрегиональный рецепт работает в части регионов, доставка Rx остается пилотной. Объем канала e-com будет находиться в диапазоне 995—1150 млрд руб.

3. Ускоренный (20%). Федеральный электронный рецепт и постоянный режим доставки Rx. Объем канала e-com будет находиться в диапазоне 1255—1480 млрд руб., но требует снижения стоимости последней мили и стандартизации идентификации.

Главные вызовы развития канала e-com на ближайшие три-четыре года для его основных участников

Для аптечных сетей главный вызов — не доставка, а управление остатками и качество данных. Ошибка в обещанном остатке рушит доверие покупателя. Для производителей — необходимость адаптироваться к росту собственных марок сетей и цифровой прозрачности цен. Для платформ и агрегаторов — усиление ответственности за проверку карточек и партнеров.

Главный вывод: цифровая аптека 2030 года — это не торжество курьеров, а эволюция аптеки как точки выдачи. Интернет становится началом покупки, но физический отпуск остается финалом. Кто сможет соединить цифровое удобство с надежностью офлайн-точки, тот и выиграет гонку. ФВ

*Подготовлено по материалам отчета «Цифровая фарма-2030: Российский рынок: прогноз объемов и структуры, модели продаж и изменение ролей участников», выпущенного компанией «АльфаРМ» в сентябре 2026 года.



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»*

Три сценария развития аптечного e-com: прогноз на 2030 год

Параметр 2030	Сценарий		
	консервативный	базовый	ускоренный
Онлайн Rx + OTC	870–990 млрд руб.	995–1150 млрд руб.	1255–1480 млрд руб.
Rx-доставка	Отсутствует	Пилоты, менее 3% Rx-онлайна	Постоянный режим, 15–30% Rx-онлайна
Самовывоз	73–83%	69–77%	55–66%
Торговые площадки, интерфейс	14–18%	20–25%	28–35%
Роль аптечных сетей	Доминируют во всех звеньях	Контролируют исполнение и лояльность	Теряют часть трафика, сохраняют лицензию и выдачу
Основной риск	Стагнация и маржинальное давление	Зависимость от платформ	Регуляторные нарушения и концентрация данных

Источник: «АльфаРМ»

АЛЬФАРМ
ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

Хотите иметь полное понимание того, как развивается аптечный e-com канал? Альфарм подготовил для Вас два предложения!

База данных Альфарм «Розничный аудит продаж ЛС и БАД в РФ (канал E-COM)*»:

- Определить важность канала для Ваших продуктов и продуктов конкурентов
- Получить оперативные данные об изменении динамики продаж в канале
- Обнаружить региональные особенности аптечного e-com
- Понять тренды e-com для ЛС и БАД, которые меняют рынок

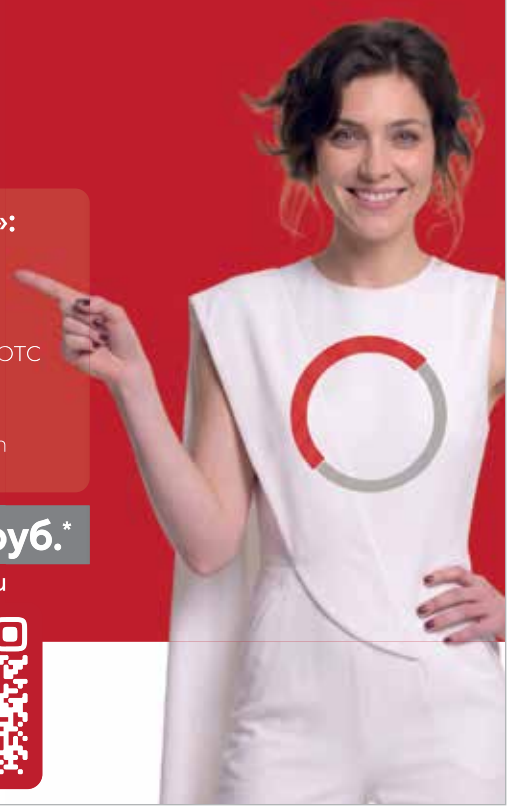
Для новых подписчиков на базу по продажам ЛС и БАД в e-com канале при одновременном приобретении отчета «Цифровая аптека 2030» действует специальное предложение – узнайте о нем у своего менеджера или направьте запрос на эл. адрес a.report@alpharm.ru.

Отчет «Цифровая аптека 2030»:

- Основные факторы, влияющие на фарм e-com сегодня и завтра
- Категории ЛС, для которых важен e-com
- Модели электронной торговли для Rx и OTC
- Драйверы, ограничения и риски для аптечного e-com
- Прогноз развития лекарственного e-com канала до 2030 г. включительно

Приобрести отчет по специальной цене можно, написав на a.report@alpharm.ru или перейдя по QR-коду:

99 000 руб.*



ООО «АльфаРМ», Москва,
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2,
+ 7 (495) 645-00-30, info@alpharm.ru

*Срок действия предложения до 31.10.2026. С 01.11.2026 стоимость отчета составит 149 000 руб. Без учета НДС (22%).

РЕКЛАМА

Какие вызовы встают перед фармрынком в сфере кибербезопасности

СЛАБОЕ ЗВЕНО



ТЕКСТ: Мария Гордеева

Фармрынок сталкивается с регулярными кибератаками, при этом защита упирается в дефицит ИБ-специалистов. Две трети работодателей испытывают дефицит кадров, а квалификация кандидатов оставляет желать лучшего. При этом судебная практика показывает, что кибератаки все чаще не признаются форс-мажором — суды рассматривают их как предпринимательский риск и требуют доказательств реальных мер защиты.

Кто и зачем атакует

В 2025—2026 годах было выявлено около 600 значимых угроз со стороны различных типов атакующих, направленных на компании из здравоохранения, фармацевтической и торговой отраслей, сообщила компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F6. Это означает, что в среднем раз в один-два дня эти отрасли становились целью киберпреступников.

За атаками стоят минимум восемь APT-групп (Advanced Persistent Threat — продвинутая устойчивая угроза), но мотивация у них разная: политическая — для крупных компаний, финансовая — для малого и среднего бизнеса. Аптечные сети уже неоднократно становились публичной мишенью политически мотивированных атакующих (хактивистов).

«Их основная задача — получить крупный выкуп и привлечь повышенное внимание к своим действиям. Группировки преимущественно ориентируются на малый и средний бизнес, ограничиваясь сравнительно небольшими выкупами за расшифровку данных. Политически мотивированные злоумышленники чаще всего не используют новые уникальные программы, обходясь готовыми решениями на основе утекших в публичный доступ билдеров и исходных кодов», — сообщили в департаменте киберразведки компании F6 на запрос «ФВ».

Были выявлены неоднократные случаи атак на аптечные сети, о которых политически мотивированные атакующие (хактивисты, термин hacktivism образован от английских hack — «взлом» и activism — «активизм») сообщали в своих telegram-каналах. Так, в начале 2025 года группа BlackHunt атаковала одну из российских медицинских организаций.

ГРУППЫ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКУ: REZET, UNICORN, PHANTOMCORE, SILVER FOX, MYTHIC LIKHO, HEARTLESSSOUL, PSEUDOSTICKY, REAVERBITS

Помимо групп, действующих по политическим мотивам, угрозу для ритейла и фармацевтики составляют финансово мотивированные кибергруппы, действующие как в России, так и глобально. «Такой класс угроз редко меняет TTPs (техники, тактики и процедуры), предпочитая использовать долгое время одни и те же инструменты», — рассказали в F6.

ГРУППЫ-ВЫМОГАТЕЛИ, НАИБОЛЕЕ АКТИВНО РАБОТАВШИЕ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В 2025-М — ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2026 ГОДА: WEREWOLVES, ROOM155, BO TEAM, BEARLYFY, VANTACORE

Отдельно меняется и технологический арсенал атакующих. Главный тренд — стремительное проникновение искусственного интеллекта в кибератаки*. Что касается России, то здесь, несмотря на ажиотаж вокруг темы ИИ, нейросети пока не стали полноценным инструментом хакеров. ИИ-инструменты позволяют киберпреступникам автоматизировать и удешевить создание фишингового контента, упростить масштабирование и улучшить процессы разведки.

«Следы использования ИИ заметны у все большего числа атакующих Россию группировок, однако количество автономных атак с использованием ИИ без или с минимальным участием человека по-прежнему пренебрежимо мало. Тренд на автономное использование ИИ в 2026 году начал набирать популярность на глобальном рынке, а в атаках по России ИИ используется



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»*

Около 600

значимых угроз, направленных на компании из здравоохранения, фармацевтической и торговой отраслей, было выявлено в 2025—2026 годах, по данным компании F6

чаще в разведывательных целях или в рамках разработки ПО», — рассказали в F6.

В компании также говорят, что в ближайшее время существенно вырастет сложность, скрытность и целевой характер кибератак. Успех защиты будет зависеть не только от скорости обнаружения и устранения известных уязвимостей, но и от фундаментального перехода от реактивной к проактивной модели защиты. Критически важной станет способность не просто реагировать на инциденты, но и активно выявлять скрытые угрозы через поиск аномалий в активности, анализ поведения пользователей и сущностей, а также непрерывный мониторинг и тестирование безопасности инфраструктуры на опережение.

Кто противостоит атакам

С февраля 2026 года информационные системы фарморганизаций отнесены к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), с этого момента ИБ-функции стали регуляторно значимыми. «Изменения в законодательстве в текущей ситуации мы воспринимаем как логичную меру. Это повод еще раз провести диагностику мер по защите информационной инфраструктуры для компаний, в фокусе которых кибербезопасность ранее не значилась», — комментирует технический директор «Здравсити.ру» **Андрей Пунин**.

По его словам, универсального рецепта, как создавать свой штат ИБ-специалистов или искать их на аутсорсе, не существует — все зависит от имеющейся инфраструктуры компании, ее состояния, целей и объемов. «Малым компаниям, только погружающимся в тему, выгоднее привлекать внешних специалистов с готовыми методиками и инструментами. Крупным — строить комплексную внутреннюю команду, причем не только из «айтишников», но и из представителей смежных подразделений — обеспечение безопасности требует большой комплексной работы», — говорит Андрей Пунин.

Однако нанять квалифицированных специалистов сегодня непросто, и это одинаково справедливо как для внутренней команды, так и для оценки внешних подрядчиков. Две трети работодателей, по данным опросов hh.ru, сегодня испытывают ощутимую нехватку кадров в сфере ИБ, что отражает и динамика предлагаемых зарплат. →

РЫНОК ТРУДА В ИБ:

Всего открыто

13 700 вакансий в сфере информационной безопасности

Чаще всего требуются:

специалисты по защите данных и ИТ-инфраструктуры — **42%**

директора по ИБ — **32%**

В топ-5 по востребованности: DevSecOps/AppSec-специалисты (9%), архитекторы ИБ (7%), разработчики ИБ (5%).

Данные hh.ru, первое полугодие 2026 года



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»*

ЗАРПЛАТЫ В ИБ

DevSecOps/ AppSec-специалисты	Руководители и директора по ИБ	Архитекторы ИБ
до 275 тыс. руб. (+20% за год)	от 390 тыс. руб. (+7% за год)	237 тыс. руб.

Данные hh.ru, первое полугодие 2026 года

«Сейчас мы видим интересную картину. Так, если осенью 2025 года на одну вакансию специалиста по ИБ приходилось в целом по стране порядка девяти резюме, то теперь уже 16. Но это совсем не значит, что компаниям стало легче нанимать специалистов. Картина показывает, что кандидатов стало больше, а вот насколько их квалификация соответствует требованиям работодателей — это вопрос», — рассказала директор hh.ru по исследованиям **Мария Игнатова**.

По данным опроса hh.ru среди более чем 250 российских компаний, лишь 7% ставят 5 баллов из 5, оценивая уровень профессиональной подготовки кандидатов. Средняя оценка навыков соискателей, по мнению работодателей, сейчас 3 балла из 5. «Перед компаниями, которые нанимают специалистов, в том числе по ИБ, стоит сложная задача: среди массы откликов найти квалифицированного специалиста с релевантными навыками», — говорит Мария Игнатова.

Какие юридические сложности

Параллельно отрасль сталкивается с регуляторным давлением: переход на отечественное ПО стал обязательным для субъектов КИИ. Однако, как отмечают в F6, это незначительно повлияло на ландшафт угроз. В компании напоминают, что в течение последних лет злоумышленники эксплуатировали уязвимости в популярном отечественном ПО, которое использовалось компаниями еще до геополитического конфликта. Случаи атак на новое импортозамещенное ПО наблюдаются значительно реже — его исследование и выявление новых уязвимостей требуют значительных трудоресурсов и времени.

«Основную угрозу для России составляют группы, старающиеся максимально быстро и просто добиться своей цели без необходимости действовать скрытно, поэтому они не тратят время на изучение работы ПО и поиск уязвимостей в нем, а вместо этого предпочитают использовать уже известные уязвимости в других, более популярных продуктах», — считают в компании.

Но даже если новые отечественные решения не являются массовой мишенью, это не отменяет другого рода рисков — договорных. Суды все чаще отказываются признавать хакерские атаки обстоятельством непреодолимой силы.

«ИТ-компании при предоставлении доступа к своим продуктам нередко, используя договорные механизмы, ограничивают свою ответственность и квалифицируют кибератаки форс-мажором. Суды же в ряде недавних дел отказывались признавать хакерские атаки форс-мажором, поскольку в последнее время они являются обычным и ожидаемым, а не чрезвычайным явлением для ИТ-компаний», — рассказала старший юрист практики «Фармацевтика и здравоохранение» «Пепеляев Групп» **Таисия Кубрина**.

По словам эксперта, возможность хакерской атаки рассматривается судами как их предпринимательский риск. ИТ-компания не может быть освобождена от ответственности, если не доказала, что приняла все меры защиты своих продуктов и сервисов. Ограничение ответственности за утрату данных может не сработать, если ИТ-компания не настроила эффективную работу по их дублированию и резервному копированию.

«С точки зрения видов убытков через суд больше перспектив взыскать с ИТ-подрядчика реальный ущерб, например, затраты на восстановление баз данных, ИТ-аудит и сверхурочные выплаты сотрудникам, занимавшимся восстановлением информационной инфраструктуры. Значительно меньше шансов взыскать упущенную выгоду, поскольку суды, как правило, требуют доказательств, что атака была единственной причиной убытков», — говорит Таисия Кубрина.

Поскольку фарморганизации теперь относятся к субъектам КИИ, а атаки на отрасль происходят регулярно, риски судебных споров с ИТ-подрядчиками будут только расти. Выбирая поставщика или заключая договор, фармкомпаниям стоит заранее проверять, какие реальные меры защиты он применяет, иначе в случае инцидента взыскать убытки будет проблематично. ФВ

*Глобальное исследование «F6 2025—2026 Cyber Threat Landscape Report» («Ландшафт киберугроз 2025—2026»).



Стоимость взлома хакеру обходится в 500—1000 долл., тогда как компания может тратить миллионы на защиту. К такому выводу пришли эксперты подкаста специалиста по информационной безопасности Дмитрия Беляева. В эту сумму входит подписка на продвинутую LLM без «моральных» ограничений, подписка на несколько VPN, чтобы сложнее было ловить, и необходимое оборудование. При этом злоумышленник получит деньги и от заказчика взлома, и от жертвы в виде выкупа. «Это вечная тема: платить или не платить выкуп. Но платят очень-очень многие, особенно средний бизнес. Очень многим это проще сделать. Когда мы берем большой бизнес, там нет смысла, наверное, платить. Тем более, здесь наверняка участвуют какие-то национальные или политические проекты», — рассказал директор по информационной безопасности и технической защите маркетплейса аптек АСНА Борис Евдокимов.

Что российской фарме обещает рынок королевства

МАРОККАНСКОЕ ВРЕМЯ

ТЕКСТ: Екатерина Погонцева

Марокканским временем в шутку называют местную привычку начинать дела позже запланированного. Эту особенность культуры необходимо учитывать при выходе на местный рынок. Марокко наращивает локальное производство лекарств и стремится сократить импортозависимость, но одновременно сохраняет потребность в импортных препаратах и технологиях. Минпромторг РФ считает королевство перспективным для экспорта российских лекарств. Марокко может быть не только рынком сбыта, но и площадкой для локализации и дальнейших поставок в страны Африки.



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»*

38,4 МЛН ЧЕЛОВЕК — общая численность населения

ПРИМЕРНО 25,5 МЛН ЧЕЛ. — Трудоспособное население (люди в возрасте 15—64 лет) (66,4% от общей численности населения)

30,8 ГОДА — Медианный возраст

Данные: GeoRank.org — Morocco Median Age & Demographics; данные Всемирного банка и ООН (World Population Prospects), 2025 год

Что представляет собой фармрынок

Фармпромышленность Марокко обеспечивает лекарствами местное население численностью около 38 млн человек, которая увеличится до 43,3 млн к 2060 году, согласно прогнозу Верховной комиссии по планированию — главного статистического органа страны. Благодаря росту населения и расширению доступа к медицинскому обслуживанию внутренний фармрынок стабильно увеличивается на 5—7% в год; наиболее высокие темпы роста наблюдаются в сегменте лекарств от хронических заболеваний, следует из отчета аналитической компании Haiba Alghaiouan Consulting (HAC) за январь 2026 года.

В стране насчитывается свыше 60 предприятий, производящих фармпродукцию в соответствии с европейскими и американскими стандартами и дающих работу более 15 тыс. человек, сообщает NorthAfricaPost. →



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»*

0,5%
в ВВП Марокко вносит фармсектор, по данным НАС

Объем марокканского фармрынка — примерно 2 млрд долл. в год, по данным НАС. Местное производство покрывает около 70% потребностей. На рынке доминируют дженерики, занимающие примерно 60% объема продаж в упаковках. Оригинальные препараты занимают меньшую долю в абсолютных числах, но более значительную в денежном выражении.

В июне 2026 года марокканская фармацевтическая ГК Laprophan завершила приобретение швейцарской Rivopharm. Президент Laprophan **Фарид Беннис** назвал сделку ключевым моментом в истории компании. По его словам, она «открывает новую главу в стремлении создать международную фармацевтическую группу из Марокко, опирающуюся на производственные мощности, научный опыт и долгосрочную приверженность улучшению доступа к качественным лекарствам» (цитата по Morocco World News).

Регулятор и регуляторика

Министерство здравоохранения Марокко контролирует все аспекты производства, распространения и контроля качества лекарств. В его подчинении находится Управление по лекарственным средствам и фармацевтике, занимающееся лицензированием, инспекциями и обеспечением соблюдения законодательства. Для модернизации регулирования индустрии было создано Национальное агентство по лекарственным средствам и продуктам здравоохранения (AMMPS, учреждено в июле 2023 года, фактически приступило к работе в июне 2025-го). Его задача — привести марокканские стандарты в соответствие с передовой международной практикой, включая рекомендации ВОЗ и требования GMP. В конце 2025 года совет директоров AMMPS утвердил «дорожную карту» на 2026—2028 годы, ориентированную на форсированную локализацию производств, технологический суверенитет и интеграцию Марокко как главного фармацевтического хаба на рынке Африки.

Курс на снижение зависимости от импорта лекарственных препаратов королевство взяло сразу после обретения независимости (от Франции и Испании) в 1956 году, следует из отчета НАС. Значительное число проектов по локализации пришлось на 1990-е годы, когда



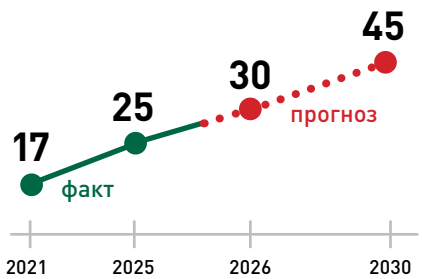
БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



рост в 2,2 раза

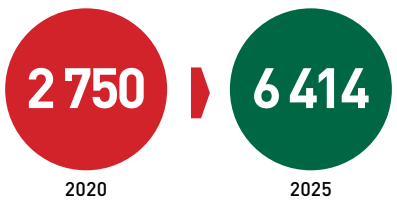


ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕДРАБОТНИКАМИ НА 10 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ





КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В МЕДВУЗАХ



рост в 2,3 раза

Данные официального представителя Правительства Марокко Мустафы Баитаса

западные компании обеспечили приток передовых технологий и международных стандартов качества. Сейчас в стране расположены производственные и дистрибьюторские филиалы более 30 международных фармбрендов.

Правительство Марокко оказывает господдержку фармпроизводителям: субсидирует покупку земельных участков, предоставляет по сниженным ценам участки в индустриальных парках, частично компенсирует расходы на обучение персонала, освобождает от уплаты корпоративного налога на пять лет при открытии новых производств. Компании, инвестирующие в НИОКР, могут претендовать на налоговые вычеты, говорится в отчете НАС.

В Марокко один фармацевт может владеть только одной аптекой и обязан лично ею управлять. Поэтому классическая модель аптечных сетей в стране отсутствует, а вывод препарата требует работы с большим числом независимых точек.

Экспорт фармпродукции

В последние годы экспорт фармпродукции превысил 200 млн долл. в год, следует из отчета НАС. Среднегодовой темп роста не превышает 10%, тогда как правительство страны ставит цель довести этот показатель до 1 млрд долл. в год и стать центром поставок фармпродукции для всей Африки. Страна участвует в инициативах Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA), которые включают региональную гармонизацию законодательства, чтобы упростить регистрацию и продажу лекарств в границах континента.

В 2025 году Марокко импортировало из ЕС медицинскую и фармацевтическую продукцию на сумму более 660 млн евро, тогда как объем экспорта в страны ЕС составил немногим более 21,5 млн евро, следует из данных Евростата.

По разным данным, королевство экспортирует фармпродукцию в 50 стран. В июне этого года российское представительство марокканской Galenica «Фармацевтическая лаборатория Галеника» завершила первую поставку препаратов в Россию в партнерстве с Asia Pharm Group.

Российско-марокканское сотрудничество

Galenica стала первой марокканской, арабской и африканской компанией, получившей разрешение на выход на рынок ЕАЭС благодаря сертификату GMP союза, пишет Morocco World News. Торговый представитель России в Марокко **Алексей Андреев** сказал, что поставка открывает «новые перспективы для расширения российско-марокканского сотрудничества».

Издание My Morocco Observer тоже увидело массу перспектив: «увеличение экспорта фармпродукции, укрепление промышленного авторитета, углубление суверенитета в сфере здравоохранения, создание высокооплачиваемых рабочих мест и диверсификация экспортной базы Марокко», но также и риск, «что первая поставка так и останется символом» и у нее не будет продолжения.

Всего в ГРЛС зарегистрировано три препарата из Марокко (два из них имеют по две лекформы). Это антацидное средство в таблетках и суспензии алгелдрат + магния гидроксид, у которого на российском рынке имеется с десяток аналогов, противомикробное средство нитрофуроксазид в капсулах и суспензии (его также выпускают четыре российские и одна белорусская компания), противодиарейный препарат аттапулгит (аналогов на российском рынке нет, вместе с тем в США его перестали производить и использовать из-за серьезных побочных явлений). Держателем одного РУ указана российская «Торговая компания Азия», двух других — Galenica. Она же производит все три продукта. «ФВ» направил запрос «Торговой компании Азия», но ответа не получил.

Минпромторг РФ относит Марокко к числу наиболее перспективных рынков для экспорта лекарств и считает целесообразной проработку взаимного признания сертификатов GMP ЕАЭС, следует из презентации ведомства на форуме «Биопром» в октябре 2025 года. «ФВ» направил запрос с просьбой прокомментировать, как далеко продвинулись стороны в этом вопросе.

С позицией министерства согласны в «Герофарме». К положительным факторам относят растущий спрос и доступные регуляторные требования. Регистрационный маршрут в этой стране сравнительно понятен, отсутствует требование о наличии GMP ЕС или США (принимают GMP страны происхождения). При этом в компании указывают, что процедура регистрации включает экспертизу и лабораторный контроль, поэтому на практике она остается длительной.

В 2024 году компания «Герофарм» осуществила первую поставку в Марокко инсулина гларгин — 97 тыс. предварительно заполненных шприц-ручек. Продукт вошел в систему возмещения стоимости лекарств, и в 2025 году объем вырос до 108 тыс. По данным IQVIA за II квартал 2025 года, доля препарата в сегменте инсулина гларгин достигла 6,4% в натуральном и 4,8% в денежном выражении. План на 2026 год составляет 180 тыс. К концу года совокупные поставки за три года могут достичь 385 тыс. шприц-ручек.

«Биокад» сотрудничает с Марокко с 2013 года, сообщили «ФВ» в пресс-службе компании. В партнерстве с местной компанией был реализован трансфер технологии производства препаратов на основе моноклональных антител, применяемых в терапии онкологических заболеваний: ритуксимаба, бевацизумаба и трастузумаба.

По оценке компании, локализация производства позволяет выпускать на территории Марокко сложные биотехнологические и онкологические препараты, сокращая зависимость поставок от внешних логистических и иных рисков.

В «Биокаде» также указывают на удачное географическое положение Марокко и действующие соглашения о свободной торговле. Производственная площадка в стране может использоваться для поставок высокотехнологичной продукции на рынки государств Африки к югу от Сахары. ФВ



Канд.мед.наук, доц. кафедры общей и клинической фармакологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Ольга Бутранова:

— Фармрынок стран Африки — одно из традиционных направлений экспорта для российских производителей лекарственных средств и медизделий. Распространение в стране системы обязательного медицинского страхования (AMO, Assurance Maladie Obligatoire) — причина растущего спроса на широкий перечень препаратов, в том числе необходимых для терапии хронических заболеваний и профилактики инфекций, большая часть их относится к группе генно-инженерно-биологических препаратов, технологии для полного цикла производства которых в Марокко в настоящий момент практически не представлены (в ряде случаев отмечается лишь фасовка готовых препаратов, поступающих из-за рубежа).

Марокко активно наращивает импорт таких групп препаратов, как моноклональные антитела, препараты для таргетной клеточной терапии, сложные биосимиляры, вакцины; именно эта ниша является наиболее привлекательной для российских производителей, чьи мощности характеризуются полным циклом производства перечисленных категорий лекарств.

С мая 2026 года в королевстве введена новая система «санитарной визы» для импортных лекарств: срок рассмотрения сокращается до 30 дней (в экстренных случаях — до 7 дней), электронная подача может упростить процедуру регистрации и снизить институциональные издержки входа для российских компаний.

Ограничивающие факторы — отсутствие между Россией и Марокко преференциальных торговых соглашений. Таможенные пошлины на готовые препараты могут быть достаточно высокими, поэтому дополнительным вариантом развития может быть создание локального производства или использование партнерства с местными марокканскими фармкомпаниями. Плюсом данной стратегии будет установление долгосрочного присутствия российских производителей на рынке Марокко и постепенное расширение каналов поставок в другие африканские страны.

Как новые условия работы с маркетплейсами повлияют на продажу БАД

НЕКУДА МИГРИРОВАТЬ

ТЕКСТ: Ольга Коберник

Производители БАД пожаловались, что маркетплейсы начали повышать комиссии для селлеров. Это вынуждает их пересматривать каналы продаж. Отказываться от сотрудничества с маркетплейсами они не планируют, но индивидуальные условия работы становятся ключевым фактором при определении приоритетных партнеров. Перейдет ли аптекам доля продаж, которая сегодня приходится на e-com, разобрался «ФВ».

До 49%

повысил комиссию Ozon в категории БАД с 28 августа

Как изменились комиссии маркетплейсов

Многие производители и импортеры БАД задумались о перераспределении каналов продаж, рассказал «ФВ» исполнительный директор Союза производителей БАД **Александр Жестков**. Изменения в структуре продаж будут связаны не столько с логистическими сложностями, сколько с повышением комиссий на некоторых онлайн-площадках.

Маркетплейсы начали менять условия работы с селлерами после серии пожаров на складах и последующих сложностях с логистикой. В частности, Ozon с 28 августа повысил комиссию в категории БАД с 27 до 49%, уведомив селлеров за 45 дней, отметил Александр Жестков.

Комиссия перестала зависеть от схемы работы поставки товара, но зависит от его цены, пишут профильные СМИ для маркетплейсов. На товары свыше 300 руб. теперь действует единая ставка категории (всего у маркетплейса более 9 тыс. категорий). Больше всего выросла комиссия на те типы товаров, у которых ставка FBO (Fulfillment by Ozon — схема, при которой продавец привозит товар на склад Ozon, а маркетплейс берет на себя почти всю логистику) была низкой. Самое драматичное повышение произошло у четырех категорий: «БАД и витамины» (+22 п.п.), «Гематоген, парафармацевтика» (+22 п.п.), «Медицинские холодильники» (+16 п.п.) и «Спортивные добавки» (+15 п.п.).

В пресс-службе Ozon отметили, что размер комиссии за продажу, указанный в открытой базе знаний компании, — номинальное значение. «Компания начисляет продавцу баллы и таким образом предоставляет ему значимые скидки на свои услуги, что и дает невысокий размер фактической комиссии», — сообщили в компании.

Маркетплейс предоставил справку за первые семь месяцев 2026 года, которые не отражают сути изменений в конце августа.

В пресс-службе Wildberries не смогли назвать конкретных цифр по комиссии. «Что касается размера комиссии в категории БАД на платформе, то она продолжает оставаться на рыночном уровне, а невысокая комиссия сохраняется в том числе для относительно новых для площадки моделей продаж — в частности, «доставка силами продавца», — сообщили в компании. Представители Wildberries лишь отметили, что в первом полугодии 2026 года общий оборот категории БАД увеличился на 49% год к году в рублях.

«МАССОВО «ПЕРЕХОДИТЬ» СЕЛЛЕРАМ ОСОБЕННО НЕКУДА: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАНАЛЫ НЕ СПОСОБНЫ БЫСТРО ПРИНЯТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ С МАРКЕТПЛЕЙСОВ».

МАРИЯ РУСИНОВА,
генеральный директор «ФармОушен»



Как отреагировали производители

«Компании начали рассматривать варианты развития альтернативных или собственных каналов e-com в силу того, что с осени повысились комиссии маркетплейсов. Производители и поставщики БАД начали вкладываться в создание собственных интернет-магазинов, развивать отношения с нишевыми онлайн-площадками. Аптеки были и остаются в фокусе — это все еще ключевой канал для распространения добавок», — пояснил Александр Жестков.

Несмотря на единые правила, крупные игроки, опрошенные «ФВ», сообщили, что у них имеются особые условия сотрудничества с маркетплейсами. «Наши условия сотрудничества с Wildberries пока не претерпели существенных изменений — у нас есть индивидуальные условия, и сейчас мы ждем от площадки пересмотра планов в связи с ситуацией на ее складах», — уточнила генеральный директор «ФармОушен» (бренд «Доктор Море») **Мария Русинова**.

На Ozon реальные затраты выросли примерно на 7% — это прямое следствие роста комиссии площадки. «Общее падение продаж на Wildberries не снижает приоритет площадки ввиду лучших условий по комиссии», — добавила Мария Русинова.

Вопрос уровня комиссии относится к числу чувствительных, признает директор по корпоративному управлению «Аквион Капитал Рус» **Максим Васюнин**.

«Действующий уровень комиссий позволяет нам развивать этот канал продаж. Номинальный рост комиссий наблюдается, однако он частично компенсируется инструментами, которые маркетплейсы предоставляют продавцам. При этом мы внимательно отслеживаем экономику канала, равно как и других каналов продаж: для «Аквиона» маркетплейсы являются одним из каналов, но не единственным», — пояснил он.

Доля маркетплейсов в продажах компании варьируется в зависимости от конкретного препарата и в среднем находится в диапазоне от 2 до 25%. «В случае дальнейшего существенного увеличения комиссий баланс между каналами может измениться. Все зависит от экономической эффективности каждого канала: на основе такого анализа мы принимаем решения о приоритетах и распределении ресурсов», — отметил Максим Васюнин.

Изменение условий сотрудничества с маркетплейсами оказало влияние на продажи производителей БАД, сообщил генеральный директор компании «Квадрат-С» **Олег Комаров**.

«Проблема с логистической структурой маркетплейсов негативно сказалась на количестве заказов и покупательской активности в целом. Мы, как и другие селлеры, вынуждены использовать сторонние логистические и складские мощности, что значительно увеличивает долю затрат на доставку товаров покупателям. Со стороны маркетплейсов за последний месяц не произошло значительных изменений в размере комиссии», — описал он текущую ситуацию на онлайн-площадках.

Прогнозы по продажам БАД на маркетплейсах

Участники рынка говорят, что есть «серые» игроки, которые не могут зайти в аптеки, и рост комиссий ударит по таким компаниям, которые сегодня на 100% зависят от маркетплейсов.

«Для многих производителей и брендов, не имеющих собственной системы контроля качества, лабораторий, аккредитации и даже необходимых сертификатов, это практически единственный доступный канал продаж», — говорит Олег Комаров.

При этом легальные участники рынка прогнозируют увеличение расходов и перестройку логистики, что приведет к изменениям в сегменте e-com.

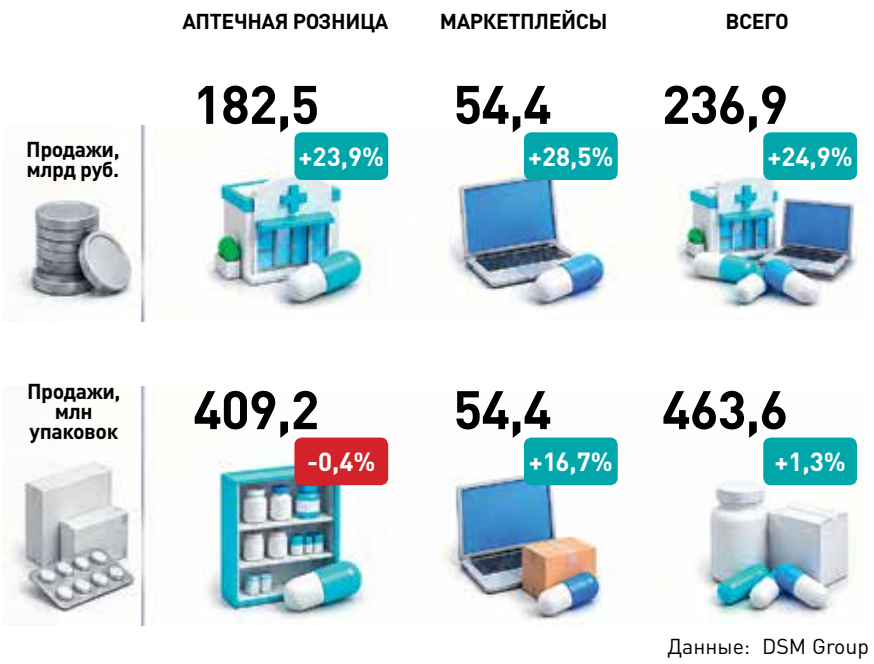
«Для «Аквиона» аптечный канал по-прежнему остается одним из каналов, важным, но не основным, и в этой ситуации наша компания находится в заметно более устойчивом положении», — отметил Максим Васюнин.

«ЧАСТЬ ЧИСТО «МАРКЕТПЛЕЙСНЫХ» ИГРОКОВ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫТЕСНЕНА С РЫНКА ИЛИ КАК МИНИМУМ С ПЛОЩАДОК МАРКЕТПЛЕЙСОВ».



МАКСИМ ВАСЮНИН,
директор по корпоративному управлению «Аквион Капитал Рус»

ПРОДАЖИ БАД В 2025 ГОДУ



Данные: DSM Group

РОЛЬ МАРКЕТПЛЕЙСОВ В ПРОДАЖЕ БАД

В 2025 году продажи БАД через маркетплейсы росли быстрее аптек и остального e-com и сформировали почти четверть рынка в деньгах — 23% совокупного денежного рынка и 12% продаж в упаковках, следует из данных DSM Group. За первые семь месяцев 2026 года объем продаж БАД на маркетплейсах составил 42,6 млрд руб., в аптечном канале (+остальной e-com) — 117,9 млрд руб. То есть маркетплейсы обеспечили около 26,5% совокупных продаж БАД в деньгах.

Компания «ФармОушен» будет пересматривать структуру продаж по каналам — менять пропорции в маркетинговом бюджете в пользу Wildberries и аптек. Но фокус бренда останется на развитии аптечного канала продаж.

«Массово «переходить» селлерам особенно некуда. Альтернативные каналы — аптеки (офлайн) и собственные интернет-магазины не способны быстро абсорбировать тот объем продаж, который сегодня идет через маркетплейсы. Поэтому реалистичный сценарий — не миграция, а прямые потери в продажах: часть селлеров просто не сможет компенсировать выросшие издержки и потеряет в объеме или марже», — прогнозирует Мария Русинова. ФВ



Что следует знать фармкомпаниям о том, как нейросети добывают информацию о лекарствах

ВОТ КАКОЙ РАССЕЯННЫЙ

ТЕКСТ: Екатерина Погонцева

При поиске информации о применении лекарств пользователи все чаще обращаются не к классическим поисковикам в интернете, а к искусственному интеллекту. Но даже промт, предполагающий краткий пересказ листка-вкладыша к препарату, не гарантирует верный ответ. «ФВ» и сервис Recomo провели тест на трех актуальных инструкциях лекарственных средств разных фармакологических категорий. Что показал тест и какие выводы стоит сделать индустрии и регулятору?

Треть пользователей регулярно обращаются к ИИ с вопросами, касающимися здоровья, а 64% участников проекта «Индекс Инвитро» отметили, что хотя бы раз обращались к ИИ с вопросами о здоровье. Почти 33% респондентов задают вопросы о лекарственных препаратах, а порядка 22% используют нейросети для подбора БАД и витаминов.
Опрос проводился среди 2 тыс. пользователей сайта «Инвитро».

Как проводился тест

По просьбе «ФВ» сервис Recomo* провел качественный пользовательский тест на материале трех актуальных инструкций к лекарственным препаратам разных фармакологических категорий. Названия препаратов, производителей и торговых марок в материале не раскрываются.

Для каждой инструкции были сформулированы бытовые вопросы: «Можно ли ребенку такой-то препарат?», «Сколько его надо принимать?», «Совместим ли с моими таблетками?»

Использовался один общедоступный генеративный сервис; его название сознательно не указывается, поскольку задача исследования — не рейтинг платформ, а разбор типовых потерь информации. Каждый ответ сопоставлялся с действующей официальной инструкцией по пяти критериям:

- правильно ли определены лекарственная форма и дозировка;
- сохранены ли ограничения по возрасту, массе тела и состоянию пациента;
- не потеряны ли исключения, противопоказания и условия применения;
- отделена ли информация из инструкции от общих медицинских знаний;
- указана ли граница, после которой надо обязательно обратиться к врачу.

Примеры ответов ИИ

Вопрос пользователя	Короткий ответ ИИ	Что потерялось	Как должен выглядеть безопасный ответ
Сколько принимать взрослому?	Выдал привычную разовую и суточную дозу	Не уточнил концентрацию, форму выпуска и цель применения; число выглядело как готовая схема, хотя инструкция разделяла несколько режимов	Сначала идентифицировать точный препарат, форму и дозировку; затем цитировать нужный раздел
Можно ли ребенку восьми лет?	Ответил, что действующее вещество в целом применяется у детей, и предложил расчет по массе	Для проверяемой лекарственной формы инструкция устанавливала другое возрастное ограничение. Система смешала сведения о веществе и конкретном продукте	Не переносить правила между сиропом, таблеткой, капсулой, раствором и наружной формой
Можно ли вместе с моими таблетками от давления?	Предупредил о возможном взаимодействии и посоветовал осторожность	Ответ звучал безопасно, но оставался непроверяемым: не были названы второй препарат, дозы, сопутствующие заболевания и раздел инструкции, на котором основан вывод	Запросить точные названия и не превращать общий классовый риск в персональную рекомендацию

Источник: качественный пользовательский тест Recomo, август 2026 Таблица

Что ИИ теряет при пересказе инструкции

В простых вопросах типа «для чего применяется препарат?» ИИ обычно воспроизводил ядро показаний достаточно уверенно. Потери начинались там, где ответ зависел не от одного факта, а от комбинации условий. В листке-вкладыше они прописаны в нескольких разделах. Генеративная же система стремится дать один связный и удобный ответ.

«Именно в этом переходе от регуляторного документа к короткой реплике возникает главный риск: модель сохраняет общий смысл, но теряет условия, которые делают этот смысл безопасным, — объясняет основатель и генеральный директор Recomo **Сергей Семенов**. — Одно и то же действующее вещество может выпускаться в разных формах, дозировках. Пользователь пишет только название, а модель выбирает наиболее вероятный вариант. Ответ может быть корректным для вещества вообще и неверным для конкретного случая».

В инструкции важные ограничения встроены прямо в текст: слова «если», «кроме», «только при», «не более», «после консультации» стоят рядом с действием, поэтому читатель сразу видит, когда и как можно применять препарат. В ответах ИИ эти же ограничения часто выносят в конец — после четкой цифры или уверенного «можно». Из-за этого человек запоминает главное действие, а оговорки «уплывают» и могут остаться незамеченными.

Наконец, актуальность документа остается невидимой. Дополнительно следует проверять происхождение факта, дату создания документа, из которого добыт ответ ИИ.

По опыту эксперта, российские и зарубежные модели могут по-разному формулировать ответ или отбирать источники, но в вопросах медицинской информации обе требуют одной и той же верификации по официальным реестрам и у профильных специалистов.

Рекомендации фармкомпаниям и регулятору

- У каждой публичной инструкции должны быть явные дата, версия, лекарственная форма, дозировка и статус документа.
- Критичные разделы нужно публиковать не только в PDF, но и в структурированном машинно-читаемом виде с устойчивой ссылкой на первоисточник.
- Архивные версии необходимо маркировать так, чтобы их нельзя было принять за действующие.

■ Фармкомпаниям стоит тестировать не только видимость бренда, но и пользовательские вопросы по инструкции: что система цитирует, какие условия опускает и откуда берет ответ.

Что думает об этом индустрия

Сегодня к ИИ правильнее относиться, скорее, как к «справочному бюро» — инструменту, где справку фактически формирует человек, просто оперирующий огромными массивами данных. Для пользователя это создает иллюзию универсального знания, хотя ответ ИИ ни в коем случае не истина в последней инстанции, считает директор по маркетингу компании «Озон Фармацевтика» **Валентина Милованова**. Эксперт напоминает, что все риски человеческого фактора — ошибки, гиперболизация, неполнота информации, искажение нюансов — могут проявиться в ответах ИИ в полной мере.

«ПРОБЛЕМУ НЕЛЬЗЯ РЕШАТЬ ТОЛЬКО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ, ЧТО ИИ МОЖЕТ ОШИБАТЬСЯ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ УЖЕ ПРИВЫК К РАЗГОВОРНОМУ ИНТЕРФЕЙСУ И БУДЕТ ОБРАЩАТЬСЯ К НЕМУ СНОВА. ЗНАЧИТ, ОТРАСЛИ НУЖЕН УПРАВЛЯЕМЫЙ СЛОЙ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВОКРУГ УТВЕРЖДЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ».



СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ,
основатель и генеральный директор Recomo

«То, что генеративные модели нередко утрачивают критически важные детали — дозировки, противопоказания, возрастные ограничения, — серьезный вызов для фармотрасли, который связан с самим «жанром» лекарственной инструкции, — констатирует Валентина Милованова. — Это «живой» документ, аккумулирующий многолетнюю практику исследований и наблюдений: в нем нет лишней информации — каждый пункт может быть важен для безопасного и эффективного применения препарата, а его структура и содержание выверены с учетом регуляторных стандартов и реальных рисков для пациента».

Чтобы минимизировать ситуации, нелишним будет провести внутренний аудит ответов популярных ИИ-сервисов на типовые вопросы о препарате — это поможет выявить «слепые зоны» и подготовить корректные данные для обучения моделей; совместно с регуляторами можно создать «рекомендуемый формат» публикации инструкций, где обязательные предупреждения будут четко отделены от вспомогательной информации, отмечает эксперт.

Как показывают недавние исследования, ИИ все чаще влияет на поведение пациента, комментирует тренд директор по экономике здравоохранения компании «Р-Фарм» **Александр Быков**. После обращения к ИИ пользователи могут изменить схему приема лекарств или отказаться от исследований, что может привести к нежелательным реакциям или ухудшению состояния.

«ИИ-модели при подготовке ответа могут опираться одновременно на различные по назначению источники: инструкции по медицинскому применению, клинические рекомендации, научные публикации, профессиональные справочные материалы, сайты медицинских организаций, — поясняет эксперт. — В результате пациент, задающий простой вопрос о назначенном ему препарате, может получить специфические сведения, предназначенные только для медицинского специалиста. С точки зрения восприятия пациентом ответ оказывается неадекватным».

«В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ ОТРАСЛИ — НЕ ТОЛЬКО СОЗДАВАТЬ И ТИРАЖИРОВАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, НО И ВЫСТРАИВАТЬ КОРРЕКТНЫЙ ЦИФРОВОЙ ДИАЛОГ О НИХ».



ВАЛЕНТИНА МИЛОВАНОВА,
директор по маркетингу компании «Озон Фармацевтика»

В этой ситуации задача регулятора и фармотрасли заключается прежде всего в формировании системы официальной информации о лекарствах, которая будет лучше распознаваться ИИ, предлагает Александр Быков. Одним из направлений, по его словам, может стать оптимизация официальных сайтов, государственных реестров и электронных инструкций по медицинскому применению с учетом их последующей ИИ-обработки.

Второе возможное направление — создание специализированных сервисов для пациентов, использующих только проверенные и регулярно обновляемые источники. Задачей такого сервиса должно быть правильное объяснение информации и определение необходимости обращения к специалисту, рассказывает эксперт. ФВ

*Сервис Recomo анализирует, какие цифровые доказательства использует ИИ и где возникают информационные искажения.

«ЦЕЛЕСООБРАЗНО СФОРМИРОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ГЕНЕРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ИИ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТСКИЕ ИСТОЧНИКИ, РАЗДЕЛЯТЬ ОБЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕПАРАТЕ И ИНДИВИДУАЛЬНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ, ПРЕДУПРЕЖДАТЬ О НЕДОПУСТИМОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОТМЕНЫ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРАПИИ И НАПРАВЛЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К МЕДРАБОТНИКУ В СИТУАЦИЯХ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ».



АЛЕКСАНДР БЫКОВ,
директор по экономике здравоохранения компании «Р-Фарм»

Умение интегрировать ИИ в науку стало главным критерием при подборе персонала в отрасли

ЭКСПЕРТ СО ЗНАНИЕМ БИОЛОГ-ИИ

ТЕКСТ: Владимир Заболотских

Искусственный интеллект меняет кадровый спрос в фармацевтике и биотехнологиях: компаниям нужны не просто программисты, биологи или дата-сайентисты, а специалисты, способные соединять машинное обучение с пониманием научных задач и биологических данных. Междисциплинарная экспертиза, а также умение наладить коммуникацию между исследователями и ИТ-командами становятся ключевыми критериями при найме в западных фармкомпаниях.



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»

Новая формула найма

Кадровый кризис в биотехнологической и фармацевтической отраслях приобретает новую форму: компаниям требуются не просто программисты или биологи, а специалисты, способные работать на стыке дисциплин, — те, кто одновременно владеет навыками машинного обучения и может работать с биологическими данными. Об этом порталу BioSpace рассказал основатель и генеральный директор рекрутингового агентства Recruits Lab **Даррен Нельсон**.

Конкуренция за экспертов узкого профиля существует давно. Организации, которая занимается разработкой генной терапии, препаратов от онкологических заболеваний или редких болезней, нужен профессионал, глубоко разбирающийся в конкретной научной области, — общей высокой квалификации здесь недостаточно. Внедрение ИИ в сфере разработки и исследований лекарств (R&D) только добавило новых сложностей.

Проблема не в отсутствии дата-сайентистов или биологов как таковых, а в нехватке кадров с междисциплинарной экспертизой: ученых, разбирающихся в машинном обучении, инженеров, понимающих специфику биологических данных, и технических руководителей, умеющих формулировать задачи для научных исследований в терминах, понятных команде ИИ-разработчиков.

Для работодателей сегодня важнее способность кандидата интегрировать научные знания с технологическими решениями, чем указанные в резюме достижения.

64%

фармкомпаний активно искали сотрудников с приоритетом на глубокое знание ИИ.

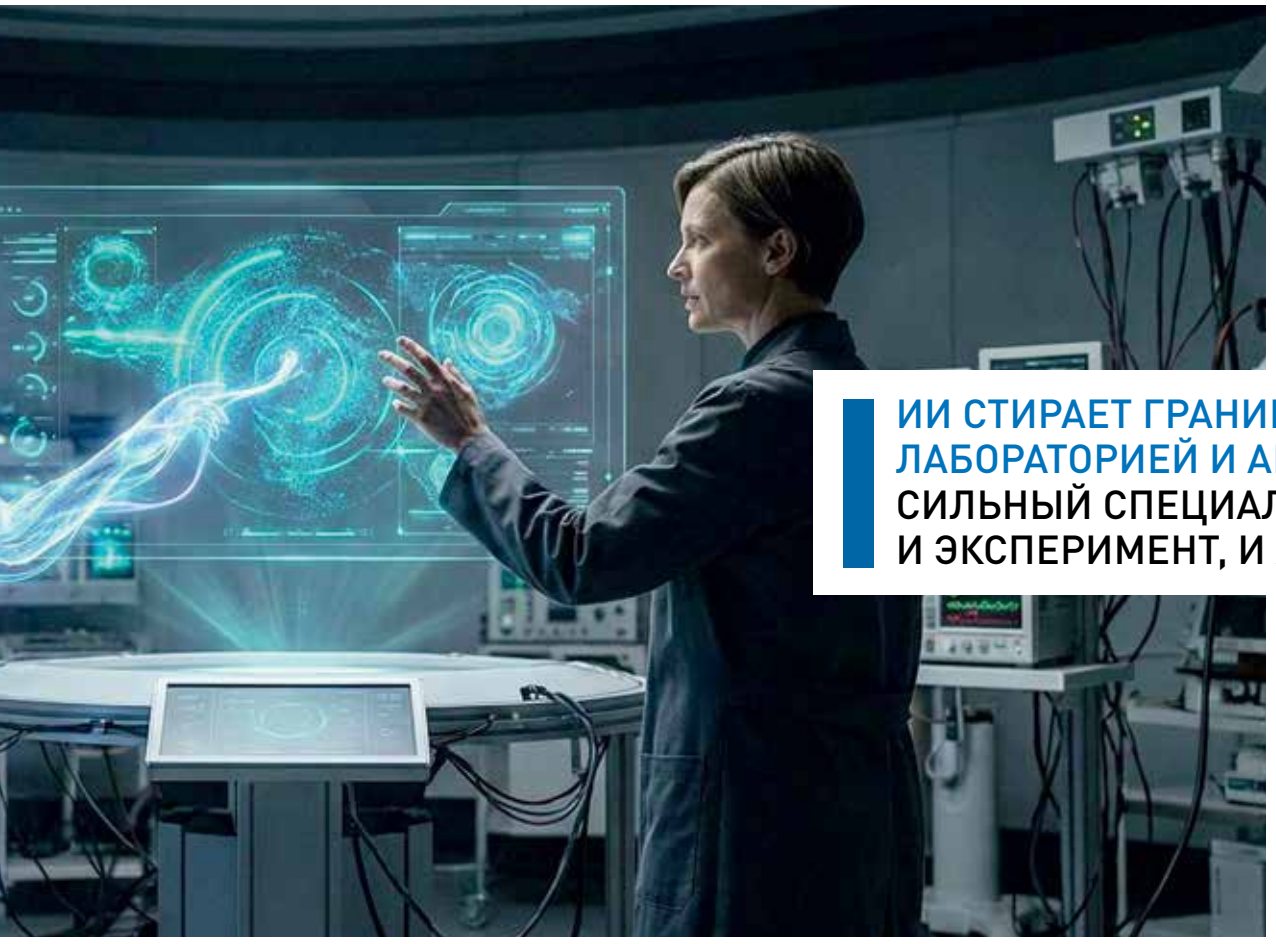
Данные: BioSpace, 2026

Две экспертизы вместо одной

Масштаб кадрового голода подтверждают два независимых исследования. Обзор американского рынка труда в сфере наук о жизни за 2026 год от BioSpace показал, что 64% опрошенных предприятий в конце прошлого года вели активный подбор сотрудников, выделяя в качестве одного из приоритетных направлений поиск специалистов по ИИ. Отчет 2026 Biotech AI Report от Benchling описывает аналогичную картину: среди 100 биотехнологических и биофармацевтических компаний, использующих ИИ, большинство в первую очередь ищут дата-сайентистов с экспертизой в биологических науках.

В этой индустрии мало добиться работоспособности ИИ-модели — нужно учитывать и научную, и техническую сторону. Инженер-программист может реализовать мощную систему машинного обучения и при этом упустить нечто существенное с научной точки зрения, а лабораторный ученый — прекрасно разбираться в биологии, но не имеет компетенций для оценки таких технических аспектов, как утечка информации, производительность модели, ограничения инфраструктуры или воспроизводимость эксперимента. По мнению Даррена Нельсона, самые ценные кадры понимают обе стороны процесса настолько, чтобы замечать потенциальные угрозы до того, как они нанесут значительный ущерб.

Показательный пример — вычислительная биология: профессия становится все более инженерной. По-прежнему сохраняется спрос на экспертов, корректно интерпретирующих биологические данные, но вдобавок от них все чаще требуют: выстраивать автоматические конвейеры обработки информации — цепочки программ, которые самостоятельно берут сырые лабораторные сведения, очищают их от шума (ошибок, помех, искажений и погрешностей), анализируют и выдают готовый результат; применять актуальные фреймворки машинного обучения — современные программные среды, вроде PyTorch



ИИ СТИРАЕТ ГРАНИЦУ МЕЖДУ «МОКРОЙ» ЛАБОРАТОРИЕЙ И АНАЛИЗОМ ДАННЫХ: СИЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ И ЭКСПЕРИМЕНТ, И АЛГОРИТМ.

или JAX; управлять масштабными массивами данных и тесно взаимодействовать с командами разработчиков ПО и инфраструктуры.

Параллельно ИИ-инженерия становится более узкоспециализированной. Хотя навыки разработки рекомендательных систем, потребительских сервисов или решений на базе больших языковых моделей могут быть полезны, они далеко не полностью закрывают потребности фармацевтического и биотехнологического бизнеса. Биологические данные обладают рядом характерных особенностей: они бывают зашумленными, разреженными, разнородными по типу, обходятся дорого при сборе. В таких условиях меняется и портрет сильного ИИ-специалиста применительно к отрасли — это не только тот, кто добивается высокой точности модели, но и тот, кто обеспечивает воспроизводимость результатов, четко понимает происхождение сведений.

Аналогичные изменения происходят в сфере автоматизации исследований. ИИ все активнее участвует в их организации — выдвигает гипотезы, проверяет их, а результаты автоматически использует для дообучения. Такая интеграция размывает привычную грань между «мокрой» и «сухой» лабораторией — физическими экспериментами и анализом данных. Поэтому особенно ценной считается двойная экспертиза: знать методологию проведения испытаний и на этой основе точно определять, какие данные целесообразно получить на следующем этапе, а вместе с этим понимать, как новая информация повлияет на параметры алгоритма и его будущие предсказания.

Статья в Nature Biotechnology за 2026 год «Агентные ИИ-системы и развитие виртуальных исследовательских групп в биомедицине» описывает ИИ-агентов, выполняющих всю цепочку исследований: от изучения научной литературы и выдвижения гипотез до самостоятельного написания кода для обработки сведений и объяснения своих выводов. Если эта тенденция продолжится, вырастет потребность в координаторах комплексных рабочих процессов, которые должны контролировать сложную архитектуру ПО, исключать нереалистичные с биологической точки зрения идеи, предложенные ИИ, и принимать обоснованные решения о целесообразности продолжения исследований.

Коммуникация как профессиональный навык

Отдельный навык, который, как подчеркивается, недооценивают при найме, — смысловая коммуникация между командами.

Проекты в области ИИ часто буксуют, так как команды описывают разные проблемы, хотя думают, что говорят об одном и том же. Кто-то должен переводить научный язык на технический, а затем, что не менее важно, объяснять ученым и руководству, какие ограничения есть у готовой модели.

Эту компетенцию сложно формализовать в должностной инструкции, поэтому опасно отбирать кандидатов по формальному стажу работы с ИИ: пять лет опыта в области машинного обучения вне биотехнологий или фармацевтики не гарантирует, что кандидат лучше подготовлен для работы, чем вычислительный биолог, который три года применял нейросети в исследованиях.

Для успешного подбора предлагается опираться на несколько практических вопросов: с какими биологическими данными работал соискатель, что именно разработал лично, использовали ли его решения и как была проведена проверка надежности модели, что происходило, когда она ошибалась, ее можно воспроизвести

Самые ценные специалисты способны увидеть научные и технические риски до того, как они приведут к серьезным потерям.

или это только опытный образец, способен ли он доносить мысли как до научных работников, так и до программистов.

В то же время компаниям не стоит полагать, что для каждого навыка обязательно нужно нанимать нового человека — скрытый талант часто находится внутри организации. Вычислительный биолог в штате, углубивший навыки в машинном обучении, принесет больше пользы, чем привлеченный универсальный специалист по ИИ, у которого уйдут годы на изучение предметной области. То же самое верно для ученых, осваивающих проектирование рабочих процессов на базе ИИ, или инженеров, которые всерьез погружаются в механизмы действия разрабатываемых медикаментов.

Иногда ИИ — повод не для появления нового отдела, а для пересмотра набора профессиональных навыков, которые компания считает обязательными для сотрудников. Ключевым фактором успешного перехода станет не число специалистов по ИИ в штате, а раскрытие потенциала собственного персонала и развитие умений применять технологии в реальной научной работе так, чтобы это помогало разрабатывать лекарства. ФВ

ОБЗОР ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РОССИИ ПРЕПАРАТОВ

в августе 2026 года

ТЕКСТ: Елена Калиновская



ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО РЕДАКЦИЕЙ «ФВ»*

Растет количество дженериков для контроля массы тела. В августе зарегистрированы два лекарственных препарата с МНН тирзепатид. Теперь препарат выпускают шесть производителей.



ЭКСПЕРТ МОНИТОРИНГА **Дмитрий БЕЛОУСОВ, генеральный директор Центра фармакоэкономических исследований**

Новые молекулы и первые дженерики

В августе Минздрав РФ выдал 179 регистрационных удостоверений (РУ) на лекарственные препараты. Из них 121 РУ выдано в рамках приведения в соответствие с нормами ЕАЭС, а 58 лекарств зарегистрированы впервые. В основном фармкомпании получили одобрение на дженерики или биоаналоги; пять МНН ранее в России не регистрировались.

Большинство новых молекул представила компания AstraZeneca. Первый препарат противоопухолевый — камизестрант из класса селективных деструкторов эстрогеновых рецепторов (SERD) для лечения гормон-рецептор-положительного (HR+) рака молочной железы (РМЖ).

Дмитрий Белоусов: «Препарат является первым в России пероральным представителем класса SERD. Он показан для лечения HR+, HER2-отрицательного РМЖ с мутацией в гене ESR1. Появление этого препарата в России дает пациентам с распространенным РМЖ доступ к инновационной пероральной терапии, которая воздействует на специфическую мутацию, развивающуюся на фоне стандартного гормонального лечения. Регистрация камизестранта может сместить парадигму лечения в сторону более персонализированного подхода, основанного на генетическом тестировании. Ожидается, что это создаст новый стандарт для пациентов, у которых прогрессирование заболевания связано с мутацией ESR1, и потребует более широкого внедрения молекулярно-генетического тестирования в рутинную практику».

Второй — баксдростат для лечения резистентной гипертензии. Это первый в своем классе селективный ингибитор альдостеронсинтазы, который блокирует выработку гормона альдостерона, играющего ключевую роль в развитии резистентной гипертензии.

Дмитрий Белоусов: «Препарат дает новую возможность для контроля артериального давления у пациентов с резистентной гипертензией, у которых стандартная терапия (включая диуретики) не обеспечивает достаточного эффекта. Он может стать важным дополнением к существующим схемам лечения. Внедрение баксдростата предоставит кардиологам новый мощный инструмент для лечения трудноконтролируемой гипертензии. Это может привести к пересмотру существующих клинических рекомендаций и более активному использованию комбинированной терапии с добавлением ингибиторов альдостеронсинтазы».

Третий препарат — гефурулимаб зарегистрировала дочерняя компания AstraZeneca, подразделение, занимающееся орфанными болезнями Alexion Europe SAS. Лекарство назначается для лечения генерализованной миастении гравис (гМГ) с положительным результатом теста на антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР). Это редкое хроническое аутоиммунное заболевание, при котором организм вырабатывает антитела, блокирующие передачу нервных импульсов к мышцам.

Дмитрий Белоусов: «Это новое биспецифическое гуманизированное моноклональное антитело, связывающее компонент комплемента С5 и альбумин; оно блокирует активацию С5 — ключевого механизма повреждения при генерализованной миастении гравис. Вводится подкожно один раз в неделю, что удобно для пациентов. Для пациентов с гМГ, положительных по АХР, этот препарат представляет собой новую высокоэффективную опцию таргетной терапии, которая может обеспечить быстрое улучшение состояния (уже на первой неделе). Регистрация гефурулимаба расширит арсенал неврологов для лечения гМГ. Ожидается, что он займет нишу препаратов для пациентов, требующих быстрого и стойкого контроля симптомов, и может быть использован как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими иммунодепрессантами».

Компания «Фармасинтез» зарегистрировала разработанный в Южной Корее препарат энавоглифлозин для лечения сахарного диабета 2-го типа. Он относится к ингибиторам натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2), которые, например, представлены дапаглифлозином, эмпаглифлозином.

Дмитрий Белоусов: «Это новый иНГЛТ-2, разработанный в Южной Корее для лечения сахарного диабета 2-го типа. Он эффективно снижает уровень гликированного гемоглобина и массу тела. Препарат расширяет выбор иНГЛТ-2, класса, который уже хорошо зарекомендовал себя, что дает пациентам и врачам еще одну альтернативу, в том числе с потенциально иной стоимостью после выхода на рынок. Появление очередного иНГЛТ-2 на российском рынке будет способствовать дальнейшему внедрению этого класса препаратов в клиническую практику, что может усилить конкуренцию и повысить доступность данной группы лекарств для пациентов с сахарным диабетом 2-го типа».

«Промомед Рус» получила одобрение на гивиностат. Он применяется при миодистрофии Дюшенна (МДД), разработан компанией Italfarmaco, в 2024 году одобрен в США, затем в Европе. В России компания-разработчик препарат не зарегистрировала.

Новые МНН, зарегистрированные в России в августе 2026 года

МНН	Бренд	Держатель РУ	Показания
Новые МНН			
Баксдростат	Баксфенди	АстраЗенека АБ	Артериальная гипертензия, в качестве дополнительной терапии на фоне приема трех и более антигипертензивных препаратов, когда другие антигипертензивные лекарственные препараты не обеспечивают достаточного снижения артериального давления
Гефурулимаб	Клигефа	Алексион Юроп САС	Генерализованная миастения гравис (гМГ) с положительным результатом теста на антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР)
Камизестрант	Иткама	АстраЗенека АБ	ГР+ (гормон-рецептор-положительный), HER2-отрицательный (с отрицательным статусом рецепторов эпидермального фактора роста человека 2 типа) местнораспространенный или метастатический рак молочной железы при выявлении мутации в гене ESR1 во время гормональной терапии первой линии
Гивиностат	Глевентра	Промомед Рус	У способных ходить пациентов в возрасте от 6 лет и старше для лечения мышечной дистрофии Дюшенна (МДД), получающих сопутствующее лечение кортикостероидами
Энавоглифлозин	Нексаглиф	Фармасинтез	Сахарный диабет 2-го типа
Первые дженерики или биоаналоги			
Венетоклакс	Венетоклакс-Промомед	Промомед Рус	Хронический лимфоцитарный лейкоз/лимфома из малых лимфоцитов, острый миелоидный лейкоз

Источник: ГРЛС, обработка «ФВ» Таблица

Дмитрий Белоусов: «Это пероральный ингибитор гистон-деацетилазы (HDAC), одобренный для лечения МДД у способных ходить пациентов в возрасте 6 лет и старше в сочетании с кортикостероидами. Это первый препарат в России для патогенетической терапии МДД. Он дает пациентам шанс замедлить прогрессирование заболевания и отсрочить потерю способности ходить, что является значительным прорывом в лечении этого тяжелого заболевания. Регистрация гивиностата может привести к созданию специализированных центров для лечения МДД и внедрению новых стандартов ведения пациентов. Ожидается, что это изменит подход к терапии МДД в России, сделав акцент на раннем начале лечения и комбинированной терапии с кортикостероидами».

Кто регистрировал препараты

РУ на новые препараты получили 40 производителей, из них 33 — из России. Также были три представителя Индии, по одному представителю из Швеции (AstraZeneca представляет единую группу компаний), Казахстана, Пакистана и Узбекистана.

По количеству выданных РУ лидирует «Фармасинтез» — у него пять РУ. Помимо энавоглифлозина компания получила одобрение на миорелаксанты цисатракурия безилат и толперизон, а также на альфа-адреноблокирующее средство ницерголин. У «Промомед Рус» четыре РУ; у «Озон» три РУ. Помимо нового гивиностата «Промомед Рус» зарегистрировала препараты для лечения муковисцидоза: комбинацию ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор (оригинальный препарат «Трикафта») и ивакафтор, а также противоопухолевый венетоклакс.

Дмитрий Белоусов: «Это первый российский дженерик венетоклакса, таргетного препарата (ингибитора BCL-2) для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза (ХЛЛ) и острого миелоидного лейкоза (ОМЛ). Появление дженерика на рынке может значительно повысить доступность этого жизненно важного препарата для пациентов с онкогематологическими заболеваниями за счет снижения стоимости. Выход дженерика будет способствовать более широкому применению венетоклакса в клинической практике, так как снижение стоимости откроет возможность для его использования у большего числа пациентов. Это особенно важно для лечения онкогематологических заболеваний, в том числе ХЛЛ, и для включения в программы государственных закупок».

Компания «Озон» получила РУ на противоопухолевый доцетаксел, средство для лечения преждевременной эякуляции у мужчин — дапоксетин — и гипогликемический препарат линаглиптин. У остальных компаний — по одному или два РУ. ФВ

ОБЗОР ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

в августе 2026 года

ТЕКСТ: Елена Калиновская

В августе разрешений на проведение клинических исследований было меньше по сравнению с июлем. Минздрав РФ одобрил 38 заявок против 47 в предыдущем месяце.

3
разрешения

на КИ препаратов, которые еще не зарегистрированы в России, выдал Минздрав РФ в августе

Какие новинки будут исследоваться

В августе Минздрав РФ выдал три разрешения на клинические исследования (КИ) препаратов, которые еще не зарегистрированы в России. Два из них — аналоги оригинальных лекарств, один — оригинальный.

Компания AstraZeneca планирует провести II фазу КИ противоопухолевого препарата торвутатуг самротекан. Он будет оцениваться в качестве монотерапии второй и последующих линий у взрослых пациенток с рецидивом платинорезистентного эпителиального рака яичников с высоким уровнем экспрессии фолатного рецептора альфа (FRα), а также в популяциях с различным уровнем экспрессии FRα. Фолатный рецептор альфа — это мембранный белок, который переносит фолаты (витамин B_9) внутрь клеток для синтеза ДНК и деления.

Завод «Медсинтез» планирует исследовать биоэквивалентность своего аналога инсулина икодек по сравнению с оригинальным препаратом Awiqli от Novo Nordisk. Это базальный инсулин сверхдлительного действия, который вводится один раз в неделю. Окончание КИ запланировано на май 2027 года. Novo Nordisk имеет два евразийских патента на инсулин икодек. Один — «Стабилированные по отношению к протеазам ацилированные аналоги инсулина» — действует до марта 2029 года, второй — «Фармацевтические композиции, содержащие инсулин» — до декабря 2037 года. Также у компании есть патент на комбинацию инсулина икодека и семаглутида, срок которого также декабрь 2037 года.

Компания «Амедарт» получила одобрение на исследование биоэквивалентности противовирусного препарата ленакапавир. Препарат сравнения не указан. Оригинальное лекарство Sunlenca принадлежит американской Gilead, которая имеет евразийский патент, действующий до февраля 2034 года. Ленакапавир относится к классу ингибиторов капсида, он остается активным даже в отношении вирусных штаммов с резистентностью ко всем ранним известным классам препаратов.

Кроме того, «Амедарт» может провести КИ омавелоксолона, который применяется для лечения наследственного заболевания нервной системы — атаксии Фридрейха у пациентов в возрасте от 16 лет. Заболевание приводит к потере координации, мышечной слабости и утомляемости. В России препарат не зарегистрирован. Оригинальный препарат Skyclarys выпускает американская Biogen. В Европейском патентном реестре соответствующего патента нет.

Какие препараты планируется исследовать

В августе по количеству разрешений на проведение КИ лидировали две области — кардиология и онкология (рис.). Из семи «кардиологических» КИ препараты известны только для трех. «ЮжФарм» планирует провести исследование лозартала, «Фармстандарт-Лекарственные средства» — комбинированного лекарства индапамид + периндоприл, ПФК «Обновление» — антикоагулянта апиксабана. Разрешения также получили «Промомед Рус» и Московский эндокринный завод, но их препараты неизвестны.

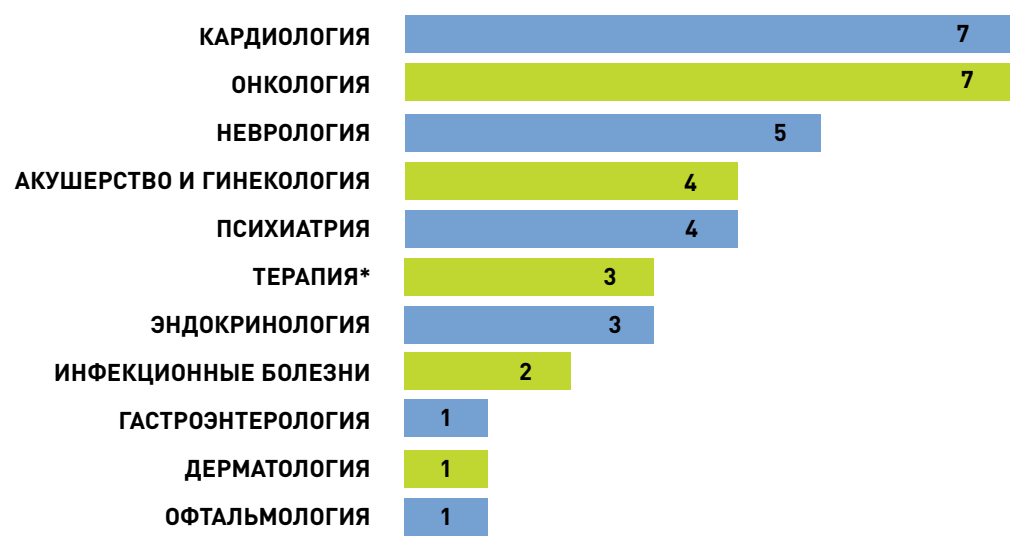
В сфере онкологии также планируется изучить семь молекул. «АксельФарм» получила разрешение на проведение исследования биоэквивалентности акалабрутиниба, «Амедарт» — на два препарата: энтректиниб и лорлатиниб, «ФармМентал групп» — на иматиниб, AstraZeneca — на торвутатуг самротекан. Исследования онкопрепаратов планируют также «Промомед Рус» и «Герофарм», но названия действующих веществ не раскрыты.

На втором месте неврология, в этой области компании собираются исследовать пять лекарств. Помимо упомянутого омавелоксолона предполагается изучение противоэпилептического ламотриджина, обезболивающего ацеклофенака, мелатонина и тразодона.

Какие компании исследуют препараты

Всего разрешения получили 26 компаний, из них 18 российские, две индийские и по одной из Великобритании, Болгарии, Германии, Испании, Израиля, Польши. Среди отечественных лидирует «Амедарт», у которой шесть разрешений на КИ, второе место делят «Промомед» и «Фармстандарт» — у них по три исследования. Затем идут «Герофарм», завод «Медсинтез» и Московский эндокринный завод — у них по три КИ. ФВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА КИ ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ОБЛАСТЯМ, ШТ.



*Простудные заболевания.
Источник: ГРЛС, расчеты «ФВ»

Рис.

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ ОДОБРЕНИЙ

за август 2026 года

ТЕКСТ: Владимир Заболотских

С 1 по 31 августа 2026 года регуляторы США, Европейского союза (ЕС), Китая и Японии одобрили 29 новых препаратов и расширили применение 11 уже зарегистрированных ранее методов лечения.



ЭКСПЕРТ МОНИТОРИНГА Герман КНОРРИНГ, канд. мед. наук, доц. кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи Российского университета медицины Минздрава РФ

США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) зарегистрировало 12 новых препаратов и расширило показания для четырех уже одобренных.

Orzeyful (овепорекстон) от Takeda стал первым в мире селективным агонистом рецепторов орексина-2 (OX2R) для лечения нарколепсии 1-го типа с катаплексией у взрослых. В отличие от классических стимуляторов и антидепрессантов, которые лишь маскируют симптомы, препарат замещает недостающий в мозге нейромедиатор орексин, напрямую активируя его рецепторы и стабилизируя циклы сна и бодрствования. В III фазе клинических испытаний (КИ) FirstLight (NCT06470828) и RadiantLight (NCT06505031) проводился тест MWT: добровольцы пытались не заснуть как можно дольше, сидя в тихой комнате и глядя перед собой. Среднее время удержания бодрствования выросло на 14,3—19,8 минуты, тогда как в группе плацебо оно, напротив, снизилось на 0,4—0,8 минуты. У большинства участников, получавших максимальную дозу, показатели восстановились до уровня нормы — они смогли продержаться не менее 20 минут из 40 возможных.

Герман Кнорринг: «Нарколепсия 1-го типа отмечается, согласно медицинской статистике, у 2—10 человек на 10 тыс. населения, при этом обращений с подозрением на этот диагноз стало больше: специалисты отмечают, что в 2025 году их число выросло примерно на 75%. Овепорекстон реализует новый механизм терапии нарколепсии, фактически восстанавливает недостающий сигнал в системе, регулирующей цикл сна и бодрствования».

mFLUSIVA (mRNA-1010) от Moderna — мРНК-вакцина от сезонного гриппа для взрослых старше 50 лет. Как и противоковидные аналоги, препарат доставляет в клетки генетический код вирусных белков, заставляя организм самостоятельно вырабатывать антигены против них. Ее ключевое преимущество — скорость производства (2—3 месяца, при классическом выращивании вирусов в куриных эмбрионах требуется 5—6 месяцев), позволяющая оперативно адаптировать состав под актуальные штаммы. В III фазе КИ NCT06602024 с участием более 40,8 тыс. человек в возрасте от 50 до 64 лет разработка оказалась на 26,6% эффективнее по сравнению со стандартными вакцинами (заболеваемость — 2,0% против 2,8% в контрольной группе). Для людей старше 65 лет применение вакцины допустимо, но окончательное решение будет вынесено после завершения III фазы КИ NCT05827978. Местные и общие реакции (боль в месте инъекции, утомляемость, головная боль) возникали чаще, чем после традиционных прививок, но носили временный характер. Случаев миокардита или перикардита не зафиксировано.

Герман Кнорринг: «Пандемия COVID-19 ярко продемонстрировала уязвимость систем здравоохранения большинства стран мира перед глобальными вызовами. Компания Moderna — один из лидеров в создании вакцин — радует нас очередным вариантом вакцины против гриппа. Очевидное преимущество — скорость создания актуальных сезонных вариантов под прогнозные штаммы вируса гриппа — расширит возможности профилактики сезонного гриппа».

Tudriqev (вусолимоген одерпарепвек) от Replimune — второй в истории медицины препарат на основе генетически модифицированного вируса простого герпеса 1-го типа. Его разрешено использовать при меланоме, прогрессировавшей после ингибиторов PD-1 (таких как пембролизумаб или ниволумаб). Он вводится непосредственно в опухолевые очаги, лавинообразно размножается в раковых клетках и буквально разрывает их изнутри. Одновременно с этим в окружающие ткани выбрасывается множество опухолевых антигенов (маркеров рака) и гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF) — белка, привлекающего дендритные и иммунные клетки к месту уничтожения новообразования. Регулятор дважды отклонял заявку на регистрацию лекарства и только в этот раз одобрил его применение вместе с ниволумабом (известен под брендом «Опдиво»).

Герман Кнорринг: «Вусолимоген одерпарепвек предлагает интереснейший механизм борьбы с опухолевыми клетками, который, возможно, будет тиражирован и на другие варианты злокачественных новообразований. Использование генетически модифицированного вируса, очевидно, вызывало опасения регулирующих органов, но включение в комбинацию ниволумаба сродни применению предохранителя в потенциально опасной схеме. Тем интереснее будут результаты клинических исследований эффективности нового препарата».

Zenbexus (ибердомид) от Bristol-Myers Squibb — первый в мире селективный модулятор цереблона (CELMoD). Молекула связывается с этим белком, который входит в состав ферментативного

→

комплекса лигазы E3, чтобы пометить транскрипционные факторы Ikaros (IKZF1) и Aiolos (IKZF3) убиквитином, дающим клетке команду их утилизировать. Без них внутри раковой клетки полностью блокируется сигнальный путь IRF4–MYC, благодаря которой клетки миеломы размножаются. Одновременно с этим усиливается выработка защитных цитокинов (таких как интерлейкин-2), что мощно стимулирует Т-клеточный иммунитет.

Pasatru (гаретосмаб) от Regeneron — первое в истории полностью человеческое моноклональное антитело класса IgG4 для патогенетического лечения прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазии, называемой также болезнью второго скелета. При этой патологии мышцы, сухожилия и связки постепенно и необратимо превращаются в костную ткань, полностью лишая человека способности двигаться. Как выяснилось, разрастание костной ткани происходит из-за мутации в гене ACVR1.

Герман Кнорринг: «Прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия — крайне редкое заболевание, и появление принципиально нового лекарства ценно по двум соображениям: имеющиеся подходы к терапии оссифицирующей фибродисплазии с применением ретиноидов пока не демонстрируют положительных результатов из-за высокой стоимости и серьезных побочных эффектов, а во-вторых — создание очередного моноклонального препарата расширяет представления о механизмах развития и прогрессирования тяжелых генетических заболеваний и, соответственно, дает надежду пациентам с подобными страданиями».

Ziihera (занидатамаб) от Jazz Pharmaceuticals, Zymeworks и BeOne Medicines — первое в истории биспецифическое моноклональное антитело, нацеленное на HER2, которое можно назначать в качестве первой линии лечения взрослых с аденокарциномой желудка, пищевода или пищеводно-желудочного перехода. В отличие от трастузумаба («Герцептин»), связывающегося только с одним участком рецептора, Ziihera одновременно атакует два эпитопа (домены ECD2 и ECD4), вызывая склеивание рецепторов в кластеры и блокируя сигналы роста опухоли.

Герман Кнорринг: «Инженерия моноклональных антител стремительно набирает скорость, число препаратов растет, добавляются новые интересные молекулы. Занидатамаб, блокируя два эпитопа HER2-позитивных опухолей желудка и пищевода, предоставляет новые инструменты терапии этой нередкой и опасной категории новообразований. Результаты КИ демонстрируют позитивные результаты с выживаемостью более двух лет и снижением риска смерти».

Препараты, одобренные в США в августе 2026 года

Бренд	МНН	Компания	Показание
Новые препараты			
Orzeyful	Овепорекстон	Takeda	Нарколепсия 1-го типа (с катаплексией) у взрослых
mFLUSIVA	мРНК-вакцина против гриппа	Moderna	Профилактика сезонного гриппа A и B у взрослых от 50 лет и старше (50–64 лет — полное одобрение; для лиц от 65 лет — ускоренное одобрение)
Tudriqev	Вусолимоген одерпарепвек	Replimune	Нерезектабельная прогрессирующая меланома кожи после курса лечения ингибиторами PD-1 (ускоренное одобрение)
Zenbexus + «Опдиво»	Ибердомид + ниволумаб	Bristol-Myers Squibb	Рецидивирующая/рефрактерная множественная миелома после ≥1 линии терапии (ускоренное одобрение)
Tauklarify	Флорквинитау F 18	Lantheus/ Cerveau	ПЭТ-визуализация тау-нейрофибриллярных клубков при обследовании взрослых на болезнь Альцгеймера
Pasatru	Гаретосмаб	Regeneron	Уменьшение уровня гетеротопической оссификации при прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазии
Ziihera + Tevimbra (или без него) + химиотерапия	Занидатамаб + тислелизумаб (или без него) + фторпиримидин + платиносодержащий препарат	Jazz/BeiGene	1-я линия лечения HER2+ местнораспространенной или давшей метастазы аденокарциномы желудка/пищевода (ускоренное одобрение)
Rasonque	Дараксонрасиб	Revolution Medicines	Давшая метастазы аденокарцинома поджелудочной железы у взрослых после ≥1 линии системного лечения
Lisraya	Брепоцитиниб	Priovant	Дерматомиозит у взрослых
Mimrylo	Русфертид	Protagonist/ Takeda	Эритроцитоз у взрослых с истинной полицитемией (polycythemia vera)
Bixlenvo	Биктегравир + ленакапавир	Gilead	ВИЧ-1 у взрослых, принимающих антиретровирусную терапию и имеющих неопределяемое количество вируса в крови
COMIRNATY XFG	Обновленная мРНК-вакцина	Pfizer/BioNTech	Сезонная профилактика COVID-19 в осенне-зимний период 2026–2027 гг.
Расширение показаний			
Mounjaro	Тирзепатид	Eli Lilly	Снижение риска инсульта, инфаркта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с сахарным диабетом 2-го типа и диагностированным сердечно-сосудистым заболеванием (3-е показание)
Besremi	Ропегинтерферон альфа-2b	PharmaEssentia	Эссенциальная тромбоцитемия у взрослых (2-е показание)
«Стелара»	Устекинумаб	Johnson & Johnson	Средняя или тяжелая степень активного язвенного колита у детей старше 2 лет (6-е показание)
Imaavy	Нипокалимаб	Johnson & Johnson	Аутоиммунная гемолитическая анемия с тепловыми антителами у лиц старше 12 лет (2-е показание)

Источник: пресс-релизы FDA и фармкомпаний

Таблица 1

Rasonque (дараксонрасиб) от Revolution Medicines — первый в мире пероральный мультиселективный ингибитор активной формы белков семейства RAS. В отличие от узконаправленных средств вроде сорафениба, он блокирует не одну, а множество мутаций (G12, G13, Q61), встречающихся у более чем 90% пациентов с раком поджелудочной железы. Препарат будут применять для лечения взрослых с метастатической аденокарциномой протоков поджелудочной железы, которые прошли хотя бы один курс системной терапии. Схема приема — одна таблетка в день.

Герман Кнорринг: «Ценность данного препарат состоит в том, что мутации в семействе генов RAS (KRAS, NRAS и HRAS) встречаются примерно в 20% случаев рака, или у 3,4 млн новых пациентов в мире ежегодно и не ограничены только раком поджелудочной железы. Эта группа белков имеет значение при немелкоклеточном раке легкого, колоректальном раке (KRAS); при меланомах и острых лейкозах (N-Ras); HRAS–мутации при раке мочевого пузыря и щитовидной железы. На протяжении многих лет белки RAS считались недоступными для таргетных лекарств из-за большой вариабельности концевых фрагментов белков. Дараксонрасиб блокирует не одну, а несколько мутаций (G12, G13, Q61), встречающихся у более чем 90% пациентов с раком поджелудочной железы. Из безусловных достоинств — также и пероральная форма: лекарство принимается в виде таблеток один раз в день, избавляя пациентов от необходимости постоянно находиться в стационаре под капельницами. В сентябре 2026 года FDA также присвоило дараксонрасибу статус «прорывной терапии» для использования в комбинации с химиотерапией уже в качестве первой линии лечения рака поджелудочной железы».

Lisraya (брепоцитиниб) от Priovant Therapeutics/Roivant Sciences — первый в мировой практике пероральный ингибитор JAK1 и TYK2 для патогенетического лечения дерматомиозита у взрослых. У больных развивается воспаление, которое приводит к разрушению мышц и повреждению кожного покрова. В III фазе КИ VALOR (NCT05437263) к 52-й неделе при пероральном приеме дозы в 30 мг зафиксировано существенное улучшение состояния по шкале TIS (оценивает эффективность лечения миозитов по шести параметрам: 0 баллов означает отсутствие изменений; 100 — достижение максимального терапевтического эффекта) — 46,5 балла, в группе плацебо — 31,2 балла.

Герман Кнорринг: «Биологические препараты — ингибиторы янус- и тирозиновых киназ — соревнуются с моноклональными антителами в терапии многих иммуноопосредованных заболеваний. Пока применение брепоцитиниба оставляет много вопросов — как в плане эффективности, так и, в большей степени, в плане безопасности в отношении кардиологической и онкологической патологии».

Mimrylo (русфертид) от Protagonist Therapeutics и Takeda — первый в мире синтетический миметик гепсидина, предназначенный для лечения эритроцитоза у взрослых с опухолью костного мозга. При истинной полицитемии избыток эритроцитов повышает вязкость крови и в четыре раза увеличивает риск инсультов и тромбозов. Новое лекарство блокирует белок-транспортер ферропортин, ограничивая поступление железа в кровоток и замедляя избыточное образование эритроцитов. Благодаря этому удается удерживать гематокрит ниже 45% и реже прибегать к кровопусканиям.

Герман Кнорринг: «Русфертид, как и многие другие участники сегодняшнего обзора, интересен не только сам по себе, но и в плане разработок новых терапевтических направлений, перспективных при широком круге нозологий. Очевидно, что способы контроля гепсидина и ферропортина найдут свое применение и при других заболеваниях системы кроветворения и патологии гемостаза».

Bixlenvo (биктегравир + ленакапавир) от Gilead Sciences — новая комбинированная схема лечения ВИЧ-1 у взрослых, уже получающих антиретровирусную терапию и имеющих неопределяемое количество вируса в крови. Одна таблетка содержит ленакапавир (блокирует формирование вирусной оболочки) и биктегравир (препятствует встраиванию ДНК вируса в геном человеческой клетки). Первый компонент входит в состав Sunlenka (на рынке с 2022 года) и Yeztugo (первое средство для доконтактной профилактики, которое вводится всего раз в шесть месяцев), второй — известен под брендом «Биктарви». Эффективность и безопасность подтверждены в III фазе двух КИ: ARTISTRY-1 (NCT05502341 — сравнивался со сложными многокомпонентными схемами) и ARTISTRY-2 (NCT06333808 — контрольная группа получала «Биктарви»). Вирусная нагрузка оставалась неопределяемой у 91—96% участников.

ЕС

Европейская комиссия (ЕК) одобрила четыре новые молекулы и расширила показания для пяти.

Onswik (инсулин эфситора альфа) от Eli Lilly — первый в ЕС базальный инсулин сверхдлительного действия для лечения сахарного диабета 2-го типа у взрослых. Молекула эфситора альфа имеет существенно более длительный период полувыведения по сравнению с классическими базальными инсулинами (например, гларгином или деглудеком), которые нужно вводить каждый день. Препарат представляет собой гибридный белок — слияние аналога инсулина с Fc-фрагментом IgG2, который медленно высвобождается в кровоток и обеспечивает стабильное снижение уровня глюкозы в течение недели. Это позволяет делать инъекции почти на 85% реже — с 365 уколов в год до 52. В III фазе КИ QWINT (NCT05662332, NCT05362058) у пациентов, ранее не получавших инсулин, снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) было таким же, что и в группе, которая получала ежедневно вводимые аналоги.

Герман Кнорринг: «Появление сверхдлительной формы базального инсулина с недельным высвобождением гормона обеспечивает значительное сокращение частоты инъекций. При необходимости пожизненного применения инсулина и трудностях с использованием инсулиновых помп инсулин эфситора альфа, конечно, станет востребованным продуктом, ограничить использование которого сможет только ценовой фактор».

Препараты, одобренные в ЕС в августе 2026 года

Бренд	МНН	Компания	Показание
Новые препараты			
Onswik	Инсулин эфситора альфа	Eli Lilly	Сахарный диабет 2-го типа у взрослых
Aujemflu	Инактивированная, адъювантная вакцина против гриппа	Seqirus	Профилактика сезонного гриппа у лиц старше 50 лет
Daybue	Трофинетид	Acadia / Neuren	Нейроповеденческие симптомы синдрома Ретта у лиц старше 5 лет
Hopledo	Леводопа + карбидопа	Zambon / Amneal	Болезнь Паркинсона у взрослых
Расширение показаний			
Tecvayli + «Дарзалекс»	Теклистамаб + даратумумаб	Johnson & Johnson	Рецидивирующая/рефрактерная множественная миелома у взрослых после ≥1 линии терапии (3-е показание)
Orladeyo	Беротралстат	BioCryst / Neopharmed Gentili	Профилактика приступов наследственного ангионевротического отека (НАО) у детей старше 2 лет и с массой тела не менее 5 кг (ранее назначался только лицам старше 12 лет)
Rezolsta	Дарунавир + кобицистат	Johnson & Johnson	ВИЧ-1 у детей старше 3 лет и весом не менее 15 кг (ранее назначался только лицам старше 12 лет)
Sivextro	Тедизолид фосфат	MSD (Merck & Co. — в США и Канаде)	Острые бактериальные инфекции кожи и мягких тканей у пациентов с момента рождения (ранее назначался только лицам старше 12 лет)
«Пикрэй» + «Фазлодекс»	Альпелисиб + фулвестрант	Novartis	HR+/HER2- распространенный или давший метастазы рак молочной железы у взрослых с мутацией в гене PIK3CA после прогрессирования заболевания на фоне гормональной терапии (ранее назначался только в качестве монотерапии после прогрессирования заболевания на фоне использования гормональных препаратов)

Источник: пресс-релизы ЕК и фармкомпаний

Таблица 2

Daybue (трофинетид) от Acadia и Neuren — первый в мире синтетический аналог глицин-пролин-глутамата (GPE) для лечения нейроповеденческих симптомов синдрома Ретта у лиц старше пяти лет. В отличие от стандартной симптоматической терапии, препарат нацелен на восстановление структуры поврежденных нейронов: стимулирует созревание дендритов, повышает синаптическую пластичность и блокирует гиперактивацию клеток микроглии, тем самым подавляя хроническое нейровоспаление в головном мозге.

Китай

Национальное управление медицинских продуктов (NMPA) утвердило восемь новых методов лечения и расширило показания для двух, одобренных ранее.

Yochanra (тиненготиниб) от TransThera Sciences — первый в мире ингибитор киназ, преодолевающий устойчивость холангиокарциномы (рака желчных протоков) к медикаментозному воздействию. Он одновременно блокирует FGFR1–3, VEGFR, Aurora A/B, JAK1/2 и CSF1R, уничтожая мутировавшие клетки, останавливая рост их сосудов и меняя микроокружение опухоли. Во II фазе КИ NCT06057571 препарат уменьшил размер опухоли более чем на треть у 28% участников, которым ранее не помогли химиотерапия и классические →

Препараты, одобренные в Китае в августе 2026 года

Бренд	МНН	Компания	Показание
Новые препараты			
Yochanra	Тиненготиниб	TransThera Sciences	Распространенная холангиокарцинома с мутациями FGFR2 у взрослых после системного лечения и получения ингибиторов FGFR первого поколения
Weiketuo	Велинатамиг	Shanghai Fosun Pharmaceutical/ YaoPharma	Рецидивирующая или рефрактерная множественная миелома у взрослых после ≥3 линий терапии
HengYouDa	Ликанкопан фумарат	Suncadia/Hengrui Pharmaceuticals	Пароксизмальная ночная гемоглобинурия у взрослых, ранее не получавших ингибиторы системы комплемента
Yisaina	Анфлекитуг	Sunshine Guojian/ 3SBio	Острые приступы подагрического артрита у взрослых при непереносимости или неэффективности стандартной терапии
—	Бессывороточная вакцина против бешенства	Sinovac Biotech	Постконтактная профилактика бешенства после укуса у человека по стандартной (5 доз) или усеченной (4 дозы) схеме ВОЗ
ATLED	Фанрегратиниб	HUTCHMED	Давшая метастазы, распространенная или неоперабельная внутрипеченочная холангиокарцинома на фоне слияния или перестройки гена FGFR2 у взрослых после ≥1 линии системного лечения
Kardorisso	Азандеутертиниб + деуцерониб мезилат	TYK Medicines	Первая линия лечения местнораспространенного или давшего метастазы немелкоклеточного рака легкого у взрослых с мутациями в гене EGFR (делеция в экзоне 19 или замена L858R) и метастазами в центральной нервной системе
Jingfei + иммуномодулятор + гормональный препарат	Фелзартамаб + леналидомид + дексаметазон	TJ Biopharma	Рецидивирующая или рефрактерная множественная миелома у взрослых после ≥1 линии лечения
Расширение показаний			
Yidafang + химиотерапия	Ивонесимаб + пеметрексед + карбоплатин	Akeso/Summit Therapeutics	Первая линия лечения распространенного плоскоклеточного немелкоклеточного рака легкого (3-е показание)
«Энхерту» + ингибитор HER2	Трастузумаб дерукстекан + пертузумаб	AstraZeneca/ Daiichi Sankyo	Первая линия лечения HER2+ неоперабельного или давшего метастазы рака молочной железы (8-е показание)

Источник: пресс-релизы NMPA и фармкомпаний

Таблица 3

блокаторы FGFR. Медиана выживаемости без прогрессирования среди всех принимавших 10 мг тиненготиниба достигла 20,7 месяца.

Герман Кнорринг: «Китайские ученые в последние годы стали «законодателями мод» в моделировании разнообразных вариантов ингибиторов клеточных киназ для лечения иммунопатологических и онкологических заболеваний. Сегодняшний герой, тиненготиниб, адресован онкологам и позволяет преодолевать устойчивость холангиокарциномы к стандартной химиотерапии и классическим блокаторам FGFR. КИ II фазы показывают обнадеживающие результаты, а молекулярные подходы китайских специалистов рисуют самые радужные перспективы».

Kardorisso (азандеутертиниб + деуцерониб мезилат) от TYK Medicines — первый в мире ингибитор EGFR третьего поколения. Его уникальность — включение в состав тяжелого водорода. Технология дейтерирования тормозит распад молекулы в организме, снижает ее токсичность и облегчает проникновение через гематоэнцефалический барьер. Модифицированная таким образом структура обеспечивает точное поражение вторичных опухолей в центральной нервной системе, что подтвердили данные II фазы КИ ESAONA (NCT05948813). Число добровольцев, у которых метастазы в головном мозге значительно уменьшились или полностью исчезли благодаря препарату, составило 95,5%, тогда как у текущего стандарта лечения — «Тагриссо» (осимертиниб) — 79,6%.

Герман Кнорринг: «Еще один шедевр молекулярной инженерии от китайских ученых — замена трех атомов водорода в известной молекуле (осимертинибе) — золотом стандарте лечения EGFR-позитивного рака легкого и его метастазов в ЦНС. Привычные атомы водорода 1H заменены на его стабильный, нерадиоактивный изотоп — дейтерий 2H, D, или «тяжелый водород», что обеспечивает целый ряд позитивных изменений. Химическая связь между углеродом и дейтерием (C-D) значительно прочнее и устойчивее к разрыву цитохромами печени, чем связь углерод-водород (C-H), что приводит к блокировке образования токсичного метаболита AZD5104. Благодаря снижению токсичности азандеутертиниб можно безопасно применять в более высоких дозах (в исследованиях стандартная доза составила 160 мг против 80 мг у осимертиниба). Это обеспечивает более высокую концентрацию исходного (полезного) вещества в плазме крови и тканях. Также за счет модификации тяжелым водородом препарат значительно увеличил способность проникновения через гематоэнцефалический барьер. Это критически важно, так как у 20—40% пациентов с EGFR-мутированным раком легкого развиваются метастазы в головной мозг».

Япония

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии (MHLW) одобрило пять новых препаратов. Главная новинка — бепировирсен.

Hibsago (бепировирсен) от GSK — первое в мире средство для лечения хронического гепатита B. Этот антисмысловой олигонуклеотид (ASO) целенаправленно снижает уровень вирусных белков. В III фазе КИ B-Well (NCT05630807, NCT05630820) у 19—20% участников ремиссия сохранялась в течение 24 недель после полугодового курса инъекций. В контрольной группе, которой давали плацебо и стандарт лечения (ежедневный прием таблеток от гепатита B — аналогов нуклеозидов/нуклеотидов, таких как тенофовир или энтекавир), подобного эффекта не наблюдалось ни у кого. ФВ

Препараты, одобренные в Японии в августе 2026 года

Бренд	МНН	Компания	Показание
Hibsago	Бепировирсен натрия	GSK	Хронический гепатит B
Brinsupri	Бренсокатиб гидрат	Insmed	Бронхоэктатическая болезнь, не связанная с муковисцидозом (у взрослых и подростков)
Hyrnuo	Севабертиниб гидрат	Bayer	Местнораспространенный или давший метастазы немелкоклеточный рак легкого с мутацией HER2
Orzeyful	Овепорекстон	Takeda Pharmaceutical	Нарколепсия 1-го типа у взрослых
Imcivree	Сетмеланотид ацетат	Rhythm Pharmaceuticals	Приобретенное гипоталамическое ожирение

Источник: пресс-релизы MHLW и фармкомпаний

Таблица 4



Ключевые решения сентября в фармотрасли: запущен эксперимент по продаже лекарств через передвижные аптеки, Минфин РФ предложил изменить правила национального режима при госзакупках, а Минздрав РФ — обновить правила ввоза препаратов в Россию.

1 ✓ Об изменении в положении о лицензировании производства лекарственных средств

Минпромторг РФ утвердил административный регламент по предоставлению госуслуги по выдаче документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса производства лекарств в ЕАЭС. Речь идет о так называемом СП 1,5. Предполагается, что с декабря 2026 появится уже новый административный регламент для выдачи СП 2.0, учитывающий сведения из системы прослеживаемости.

2 ? Об изменении правил национального режима при госзакупках

Минфин РФ предлагает изменить правила национального режима при госзакупках. Согласно проекту, планируется исключить срочные контракты с единственным поставщиком и уточнить требования по количеству производителей для каждого товара.

3 ✓ О проведении эксперимента по передвижным аптекам

В России с 1 сентября начался пилот по передвижным аптекам. Правительство РФ утвердило положение о проведении эксперимента по розничной продаже лекарств на отдаленных территориях. Участвовать смогут аптечные организации с лицензией не менее трех лет, при условии, что в регионе есть села без стационарных аптек.

4 ? О новых правилах ввоза лекарств в Россию

Минздрав РФ разработал проект новых правил ввоза лекарственных средств в Россию. Уточнены основания для отказа и порядок оформления протокола врачебной комиссии, а также правила ввоза незарегистрированных препаратов, используемых при производстве медизделий.

5 ✓ О новом регламенте по регистрации медизделий

Росздравнадзор утвердил новый административный регламент по предоставлению госуслуги по регистрации медизделий. Уточнен круг заявителей, изменены сроки и введены основания для отказа. Новый регламент будет действовать до конца 2028 года.

6 ? О форме заявки регионов на софинансирование закупки орфанных препаратов



Минздрав РФ разработал форму заявки, которую регионы должны подавать для получения допфинансирования на закупку орфанных препаратов. Документ состоит из пяти разделов.

7 ✓ О продлении эксперимента по маркировке ряда медизделий

Эксперимент по маркировке глюкометров, тест-полосок и экспресс-тестов продлен до 28 февраля 2027 года. II этап (глюкометры) объединен с III этапом (реагенты) — оба завершатся одновременно.

8 ? Об упрощенном декларировании ряда товаров аптечного ассортимента

Упрощенное декларирование ряда товаров аптечного ассортимента продлили еще на один год. Особый порядок будет распространяться на подгузники, изделия для ухода за детьми, зубные щетки и другую продукцию.

✓ Принятый ? Проект

ARISTO

КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ!

ПАРТНЕРСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

PHYSIOGEL®
HYPOALLERGENIC

ФИЗИОГЕЛЬ®

Сила науки на защите вашей кожи

Physiogel® — эмолент с уникальной технологией BioMimic³





ЭСКУЗАН®

Эсцин+тиамина гидрохлорид

Легкость в каждом шаге

ТОР-1000 препаратов в розничном сегменте рынка России²

БЛЕМАРЕН®

Калия гидрокарбонат+Лимонная кислота безводная+Натрия цитрат безводный

Камни только там, где им место

Лидер в категории цитратных смесей с долей рынка более 85%¹





АПИЗАРТРОН®

Яд пчелиный+Метилсалицилат+Аллилизотиоцианат

Природная помощь при боли в мышцах и суставах

ТОР-3 в группе разогревающих топических препаратов¹

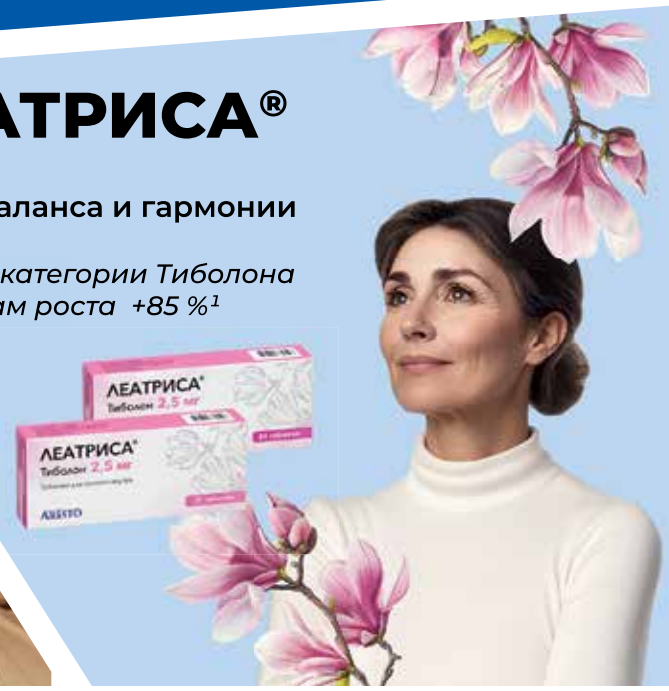


ЛЕАТРИСА®

Тиболон

Наука баланса и гармонии

Лидер в категории Тиболона по темпам роста +85 %¹



1. По данным AlphaRM за 2025 г.
2. По данным AlphaRM за 2026 г.
3. Архивные данные Stiefel GSK 2019; Yuan C. и соавт. «Улучшение барьерных функций сухой кожи при использовании крема Physiogel – Chinese Journal of Aesthetic Medicine 2011»

На правах рекламы ООО «АРИСТО ФАРМА», 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе 16А,стр. 3, 9 этаж Т: +7 495 909 00 55, info@aristo-pharma.ru

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ